ـ علایم شایع:

۱. درد چشم و سردرد شدید و ضربان‌دار قرمزی چشم

۲. تاری دید یا دیدن هاله در اطراف نورها

۳. کره چشم سفت و حساس می‌شود.

۴. گاهی به علت درد شدید در چشم ممکن است تهوع، استفراغ و ضعف رخ دهد.

۵. گشادشدن مردمك و عدم پاسخ آن به نور (مردمك در حالت عادی در اثر تابش نور تنگ می‌شود).

ـ علل بیماری:

علت دقیق آن ناشناخته است.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. سن بالای 60 سال

۲. سابقه خانوادگی آب سیاه یا دوربینی

۳. استفاده از بعضی از داروها که باعث مهار سیستم کولینرژیك (پاراسمپاتیك) می‌شوند.

ـ پیشگیری:

مرتباً تحت معاینه چشم قرار گیرید تا قبل از شروع علایم بتوان آب سیاه را کشف کرد. اگر بیش از 40 سال دارید، باید فشار داخل چشمتان سالانه حداقل یك بار اندازه‌گیری شود. اندازه‌گیری فشار چشم ساده و بدون درد است.

ـ عواقب مورد انتظار:

اگر درمان زود آغاز شود می‌توان علایم را کنترل نمود.

ـ عوارض احتمالی:

اگر درمان به تأخیر افتد یا موفقیت‌آمیز نباشد، امکان دارد آن چشم بینایی خود را به طور کامل از دست بدهد.

ـ درمان:

بستری شدن به هنگام حمله حاد آب سیاه. برای پایین آوردن فشار بسیار بالای چشم از داروهای مختلف (قطره، قرص، سرم) ممکن است استفاده شود.

جراحی (سوراخ کردن عنبیه با لیزر) برای پیشگیری از بروز حملات آب سیاه در صورتی که دیگر درمان‌ها موفقیت‌آمیز نباشند. با ایجاد این سوراخ کوچك در قسمت محیطی عنبیه به مایع درون چشم اجازه تخلیه داده می‌شود. با این کار ممکن است بتوان حملات آب سیاه را تحت کنترل در آورد، اما برای کنترل فشار چشم ممکن است تجویز دارو همچنان ضروری باشد.

ـ داروها:

۱. به هنگام بستری، برای کنترل فشار داروهایی داخل رگ تزریق می‌شوند.

۲. داروهای ادرارآور برای کم کردن فشار چشم

۳. پس از جراحی، ممکن است نیاز به قطره‌های چشمی برای کم کردن فشار داخل چشم وجود داشته باشد. حتی در صورت رفع علایم یا بروز ناراحتی گاه‌گاهی در اثر قطره‌های چشمی، دستور دارویی را به دقت پیگیری و رعایت کنید.

ـ فعالیت:

پس از درمان، فعالیت‌های عادی خود را تدریجاً از سر گیرید و سعی کنید خسته نشوید.

ـ رژیم غذایی:

رژیم خاصی توصیه نمی‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمایید:

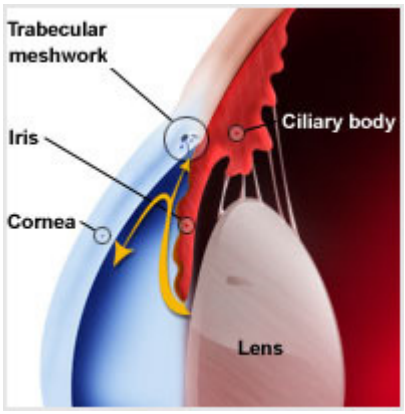
۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان علایم آب سیاه حاد چشم را دارید. این یك اورژانس است!

۲. اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124109

vista.ir
Online Classified Service

آب سیاه چشم، نوع مزمن زاویه باز - glaucoma chronic open angle



آب سیاه چشم، نوع مزمن زاویه باز عبارت است از یك نوع بیماری مزمن چشم که در آن مایعی که به طور طبیعی به چشم وارد و از آن خارج می‌شود تدریجاً گیر می‌افتد. این تجمع مایع در چشم موجب آسیب رسیدن به عصب بینایی و درجاتی از نابینایی می‌شود. آب سیاه مزمن، برعکس آب سیاه حاد، معمولاً درد ایجاد نمی‌کند. بیماری آب سیاه مزمن چشم در تمام سنین می‌تواند به وجود آید، اما در افراد بالای 40 سال شایع‌تر است.

ـ علایم شایع:

۱. تاری دیدی در یك طرف در سمت بینی میدان دید.

۲. از دست رفتن دید محیطی در نواحی کوچك از میدان دید.

۳. بزرگتر شدن نواحی از دست رفتن دید، معمولاً در هر دو چشم.

۴. سفت شدن کره چشم.

۵. دیدن هاله در اطراف نورها.

۶. وجود نقاط کور در میدان دید.

۷. نامناسب بودن دید در شب.

ـ علل بیماری:

علایم در اثر تجمع مایع و افزایش درون چشم و در نتیجه آسیب رسیدن به رشته‌های عصب چشمی به وجود می‌آیند. وقتی علایم زیر در فرد وجود داشته باشند امکان دارد شك به وجود بیماری آب سیاه مزمن چشم برانگیخته شود: عوض کردن مداوم عدسی عینك، سردرد خفیف یا اختلالات مبهم بینایی، دیدن هاله در اطراف لامپ‌ها، یا عدم توانایی در تطبیق بینایی از روشنایی به تاریکی.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. سن بالای 60 سال

۲. سابقه خانوادگی آب سیاه حاد یا مزمن چشم،

۳. دیابت

۴. بیماران باید توجه داشته باشند که بسیاری از داروها فشار داخل چشم را بالا می‌برند و موجب بدتر شدن بیماری می‌شوند. این داروها عبارتند از قرص‌های سرماخوردگی و آلرژی، آنتی‌هیستامین‌ها، آرام‌بخش‌ها، داروهای کورتیزونی، و داروهای مختلف برای مشکلات معده و روده

ـ پیشگیری:

از چشم پزشك خود بخواهید در هر بار معاینه چشم، فشار چشم شما را نیز اندازه بگیرد. توجه داشته باشید که پس از 40 سالگی باید حداقل سالی یك بار معاینه چشم انجام شود. در صورت بروز هرگونه تغییر در بینایی به پزشك مراجعه کنید.

ـ عواقب مورد انتظار:

علایم معمولاً با درمان برطرف می‌شوند. درمان آب سیاه چشم تا آخر عمر باید ادامه یابد. اگر آب سیاه به موقع تحت درمان قرار گیرد، اشکال دایمی در بینائی به وجود نمی‌آید.

ـ عوارض احتمالی:

از دست دادن بینایی قبل از این که سایر علایم آغاز شوند.

ـ درمان:

معاینات چشم از جمله تونومتری یا فشارسنجی (اندازه‌گیری فشار درون کره چشم). این بیماری را نمی‌توان معالجه قطعی کرد، اما علایم آن را می‌توان کنترل نمود. در اکثر اوقات می‌توان فشار چشم را با دارو تا حدی پایین آورد که از آسیب به عصب چشمی و از دست دادن احتمالی بینایی در آینده جلوگیری شود. در صورتی که با قطره‌های چشمی نتوان بیماری را کنترل نمود، می‌تواند از جراحی با لیزر کمك گرفت.

ـ داروها:

۱. قطره‌های چشمی برای کاهش فشار داخل چشم تجویز خواهند شد. دستورات و برنامه درمانی را به دقت پیگیری کنید، حتی اگر علایم تخفیف یابند.

۲. داروهای ادرارآور (دیورتیك) برای کاهش تولید و در نتیجه کاهش تجمع مایع در چشم.

ـ فعالیت:

محدودیتی برای آن وجود ندارد.

ـ رژیم غذایی:

رژیم خاصی توصیه نمی‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آب سیاه مزمن چشم را دارید.

۲. اگر قطره‌های چشمی غیرقابل تحمل شوند

۳. اگر هرگونه علامت عفونت چشم مثل تب ظاهر شود.

۴. اگر شما دچار درد چشم شده اید.

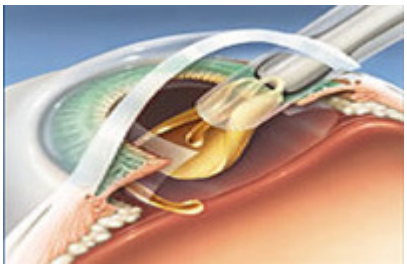
۵. اگر قرمزی چشم دارید.

۶. اگر تغییرات ناگهانی بینایی در خود احساس می کنید.

http://vista.ir/?view=item&id=124110

vista.ir
Online Classified Service

آب مروارید - cataract



آب مروارید عبارت است از کدر شدن عدسی چشم. عدسی چشم یك ساختار شفاف و انعطاف‌پذیر در نزدیکی جلوی کره چشم است. عدسی کمك می‌کند تا اشیایی که چشم به آنها نگاه می‌کند تار به نظر نرسند و نیز در شکست و تمرکز نور روی شبکیه نقش دارد.

عدسی رگ خونی ندارد و توسط زجاجیه که در اطراف آن قرار دارد تغذیه می‌شود. اگر تصلب شرایین موجب عدم تغذیه مناسب زجاجیه شود، عدسی چشم نیز منبع تغذیه خود را از دست خواهد داد (این مشکل اغلب در سنین پیری رخ می‌دهد). سپس شفافیت و انعطاف پذیری عدسی کم می‌شود و آب مروارید اتفاق می‌افتد. آب مروارید ممکن است در یك یا هر دو چشم تشکیل شود. البته در این حالت، سرعت رشد آب مروارید در دو چشم ممکن است متفاوت باشد. آب مروارید سرطان نیست.

ـ علایم شایع:

۱. کدر شدن و رنگ سفید شیری در آمدن مردمك‌ها (تنها در مراحل پیشرفته)

۲. دو تا دیدن اشیا (گاهی)

۳. تاری دید که ممکن است در نور روشن بدتر باشد. تاری دید ممکن است اول بار وقتی توجه فرد را جلب کند که به هنگام شب در حال رانندگی باشد و به نظر وی برسد که نورها پخش می‌شوند یا هاله‌ای دور آنها وجود دارد.

ـ علل بیماری:

۱. روند طبیعی پیری

۲. آسیب به چشم

۳. در بیماری‌های که قند خون بالاست، مثل دیابت شیرین

۴. التهاب، مثل اووئیت (التهاب آن قسمت‌هایی از چشم که عنبیه را می‌سازد)

۵. داروها، به خصوص کورتیزون و مشتقات آن

۶. قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس، امواج میکرو ویو و اشعه مادون قرمز

۷. علل ارثی، و نیز اثرات سرخجه روی چشم جنینی که مادرش در اوایل حاملگی مبتلا به این بیماری می‌شود.

۸. گالاکتوزمی (بیماری ارثی در شیرخواران که باعث ناتوانی در هضم شیر می‌شود). عوامل افزایش دهنده خطر سن بالای 60 سال وجود هر کدام از علل فهرست شده

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. سن بالای 60 سال

۲. وجود هر کدام از علل فهرست شده

ـ پیشگیری:

۱. خانم‌هایی که در سنین باروری هستند، در صورتی که سرخجه نگرفته‌اند یا واکسن آن را نزده‌اند، باید علیه آن واکسینه شوند.

۲. مصرف داروهای کورتیزونی یا هرگونه داروی دیگری که بر عدسی تأثیر می‌گذارد باید به دقت تحت‌نظر قرار داشته باشد.

۳. بیماری‌های چشمی‌ای که ممکن است باعث آب مروارید شوند، مثل ایریت (التهاب خود عنبیه) و اووئیت، باید سریعاً درمان شوند.

۴. به‌طور منظم از عینك آفتابی مناسب استفاده کنید.

۵. رژیمی دارای مقادیر مناسب از ویتامین ـ آ و بتا کاروتن داشته باشید.

ـ عواقب مورد انتظار:

معمولاً با جراحی خوب می‌شود. بعضی آب مرواریدها هرگز آن قدر در بینایی اختلال ایجاد نمی‌کنند که نیازمند جراحی باشد. در سیر تشکیل آب‌مروارید، تعویض مرتب عینك ممکن است به بینایی کمك کند.

ـ عوارض احتمالی:

۱. از دست دادن بینایی

۲. عوارض پس از عمل جراحی، از جمله پارگی چشم، چسبندگی‌ها، عفونت، و جدا شدن شبکیه از محل خود

ـ درمان:

۱. معاینه چشم (با افتالموسکپ) تشخیص آب مروارید را تأیید می‌کند.

۲. درمان معمولاً شامل عمل جراحی است.

۳. در صورتی که بینایی چندان زیاد تحت‌تأثیر قرار نگرفته باشد، می‌توان از عینک‌هایی که بیشترین فایده را داشته باشند بهره جست.

۴. در صورتی که بینایی بدتر شود یا آب مروارید باعث التهاب و فشار در چشم شود، عدسی چشم با جراحی برداشته می‌شود.

۵. هم‌اکنون روش‌های مختلفی برای بیهوشی، بستری کردن بیمار، و تصحیح بینایی پس از عمل جراحی وجود دارد. عمل جراحی را می‌توان با یا بدون بستری کردن بیمار در بیمارستان به انجام رساند. اگر هر دو چشم آب مروارید داشته باشند، معمولاً با هم عمل نمی‌شوند.

ـ داروها:

معمولاً دارو برای این بیماری لازم نیست.

ـ فعالیت:

هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد، فقط اگر بینایی در شب دچار مشکل شده است در شب رانندگی نکنید.

ـ رژیم غذایی:

رژیم خاصی توصیه نمی‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

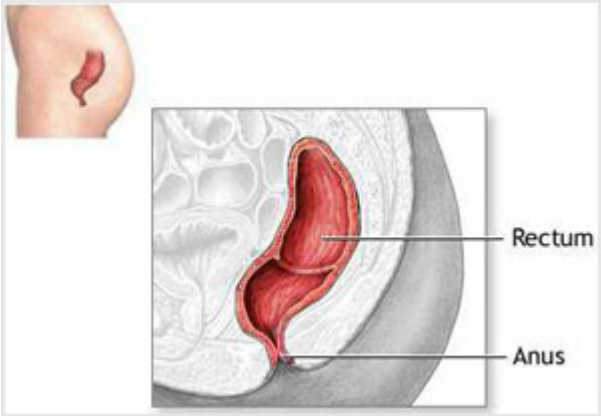
اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آب مروارید را دارید.

http://vista.ir/?view=item&id=124111

vista.ir
Online Classified Service

آبسه آنورکتال - anorectal abscess

آبسه آنورکتال عبارت است از بروز آبسه (تجمع چرك ناشی از عفونت) در ناحیه اطراف مقعد و راست روده. این بیماری در مردان و در کسانی که مبتلا به بعضی بیماری‌های گوارشی هستند بیشتر دیده می‌شود. این آبسه ممکن است درست در ناحیه سوراخ مقعدی یا به طورعمقی‌تر در جدار راست روده تشکیل شود.



ـ علایم شایع:

۱. تورم (در آبسه‌های سطحی)

۲. درد به هنگام لمس راست روده

۳. درد ضرباندار

۴. تب و دیگر علایم جدی‌تر در مورد آبسه‌های عمقی‌تر

۵. درد به هنگام اجابت مزاج

ـ علل بیماری:

باکتری‌های شایع مثل استافیلوکوك و اشرشیاکولی شایع‌ترین علل هستند. گاهی عفونت‌های قارچی باعث بروز این آبسه می‌شوند.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. افراد مبتلا به بیماری گوارشی

۲. تزریق برای درمان بواسیر داخلی

۳. آسیب ناشی از نوك وسیله تنقیه

۴. زخم ناسب ار دفع پوسته تخم‌مرغ یا استخوان ماهی

۵. جسم خارجی

۶. بواسیر بیرون‌زده

ـ پیشگیری:

۱. جلوی بروز یبوست را بگیرید.

۲. از تنقیه خودداری کنید.

ـ عواقب مورد انتظار:

بهبود آبسه به آهستگی صورت می‌گیرد و زمان آن بسته به وسعت آبسه متفاوت است. اگر عارضه‌ای اتفاق نیافتاد، آبسه در عرض 6 ماه کاملاً بهبود می‌یابد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. احتمال ایجاد فیستول مقعدی

عود آبسه در صورت عدم درمان علت زمینه‌ساز

ـ درمان:

۱. تشخیص با معاینه بالینی داده می‌شود.

۲. درمان شامل بازکردن آبسه و تخلیه آن است.

۳. حین جراحی از بی‌حسی موضعی استفاده می‌شود. برای آبسه‌های عمقی‌تر در راست روده، معمولاً از بیهوشی عمومی استفاده می‌شود.

۴. نشستن در لگن آب گرم هر 4-2 ساعت، پس از عمل جراحی، هر بار برای 20 دقیقه در لگن یا وان حمام که ارتفاع آب گرم در آن 20-15 سانتیمتر است بنشینید.

۵. استفاده از صفحه گرمکننده، لامپ گرمکننده یا کمپرس گرم برای تخفیف درد.

۶. جلوی بروز یبوست را بگیرید. در صورت احساس اجابت مزاج، از آن خودداری نکنید، حتی اگر درد داشته باشید. یبوست می‌تواند باعث افزایش فشارروی زخم محل جراحی شود.

۷. دستورات پزشك را در رابطه با تعویض پانسمان و تمیز نگاه داشتن محل جراحی رعایت کنید.

ـ داروها:

۱. برای عفونت ممکن است آنتی‌بیوتیك یا داروی ضدقارچ تجویز شود.

۲. مسهل‌های نرمکننده مدفوع برای جلوگیری از یبوست.

ـ فعالیت:

پس از جراحی، در زودترین زمان ممکن فعالیت‌های عادی خود را از سربگیرید.

ـ رژیم غذایی:

افزایش میزان فیبر در رژیم غذایی می‌تواند به کاهش خطر بروز یبوست کمك کند.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آبسه آنورکتال را دارید.

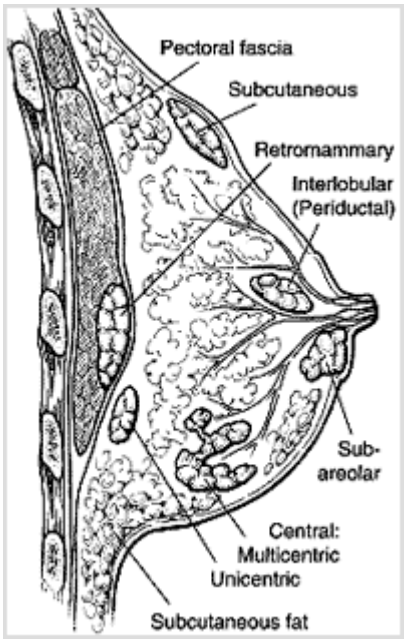
۲. اگر دچار علایم جدید و غیرقابل کنترل شده اید . توجه داشته باشید که داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124112

vista.ir
Online Classified Service

آبسه پستان - breast abscess

آبسه پستان عبارست است از یك ناحیه عفونی شده بافت پستان که در اثر مبارزه بدن باعفونت، چرك در آن جمع می‌شود، آبسه دربر گیرنده بافت پستان، نوك پستان، غدد شیری، و مجراهای شیری است.



ـ علایم شایع:

۱. درد، حساسیت به لمس، قرمزی و سفتی پستان

۲. تب و لرز

۳. احساس ناخوشی عمومی

۴. دردناك شدن گره‌های لنفاوی زیر بغل

ـ علل بیماری:

وارد شدن باکتری‌ها از راه نوك پستان (معمولاً از راه زخم‌های کوچك روی نوك پستان که در روزهای اولیه شیردهی ایجاد می‌شوند).

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. عفونت لگنی پس از زایمان

۲. دیابت (مرض قند)

۳. آرتریت روماتویید

۴. استفاده از داروهای استرویدی

۵. سیگار کشیدن به مقدار زیاد

۶. سابقه برداشتن قسمتی از پستان همراه با اشعه درمانی

۷. پستان مصنوعی سیلیکونی

ـ پیشگیری:

۱. نوك پستان و خود پستان را پس از هر بار شیردهی کاملاً بشویید.

۲. اجازه ندهید کودك شیرخوارتان نوك پستان شما را گاز بگیرد یا بجود.

۳. از پارچه‌هایی که پستان را اذیت می‌کنند استفاده نکنید.

۴. نوك پستان را پس از شیردهی با پماد ویتامین ـ آ و د، یا سایر داروهای موضعی، نرم کنید (در صورت توصیه).

ـ عواقب مورد انتظار:

با درمان معمولاً در عرض 10-8 روز خوب می‌شود. برای تسریع بهبود آبسه، گاهی تخلیه آن ضروری است.

ـ عواض احتمالی:

ندرتاً لازم است شیردهی متوقف شود، حتی در مواردی که عفونت شدید است. گاهی لزوم مصرف بعضی آنتی‌بیوتیك‌ها (به خصوص تتراسیکلین) و داروهای ضد درد موجب می‌شود که شیردهی برای مدت کوتاهی قطع شود. در این حالت باید شیر را مرتباً پمپ نمود.

ندرتاً ممکن است فیستول ایجاد شود (فیستول عبارت است از به وجود آمدن یك مجرای غیرطبیعی بین دو عضو بدن، یا بین یك عضو و محیط بیرون از بدن)

ـ درمان:

از پارچه یا حوله آب گرم برای تخفیف درد و تسریع التیام استفاده کنید (اگر آب سرد را امتحان کردید و دیدید بهتر است، از آب سرد استفاده کنید).

تا زمان خوب شدن عفونت پستان، شیردهی به نوزاد را از آن پستان متوقف کنید. به طور منظم از یك پمپ مخصوص پستان برای خارج ساختن شیر از پستان عفونی شده استفاده کنید، تا زمانی که بتوانید شیردهی را مجدداً از آن پستان از سر بگیرید. جراحی برای تخلیه آبسه (معمولاً انجام نمی‌شود).

ـ داروها:

۱. آنتی‌بیوتیك‌ها در صورت لزوم، برای مبارزه با عفونت.

۲. استفاده از داروهای ضد درد معمولاً تنها برای 7-2 روز پس از انجام عمل جراحی لازم است.

ـ فعالیت:

پس از درمان، فعالیت‌های عادی خود را به محض رو به بهبود گذاشتن علایم از سر گیرید.

ـ رژیم غذایی:

هیچ رژیم خاصی توصیه نمی‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آبسه پستان را دارید.

۲. اگر یکی از مشکلات زیر به هنگام درمان رخ می‌دهد: تب؛ شدید شدن درد؛ گسترش عفونت علی‌رغم درمان؛ علایم در عرض 72 ساعت رو به بهبود نگذارند.

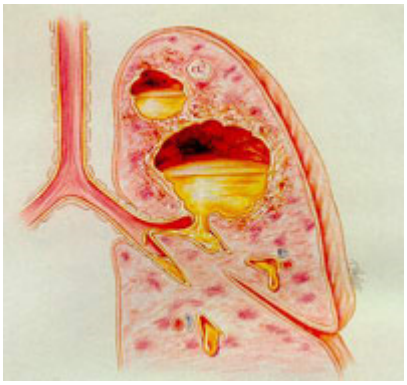
۳. اگر دچار علایم جدید و غیرقابل کنترل شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124113

vista.ir
Online Classified Service

آبسه ریه - lung abscess

آبسه ریه ناحیه‌ای از عفونت در ریه که توسط بافت ملتهب احاطه شده است. بافت عفونی شده ریه تخریب شده و چرك جایگزین آن می‌گردد. این بیماری مسری نیست.



ـ علایم شایع:

۱. درد سینه (گاهی)

۲. بوی بد تنفس

۳. تعریق

۴. تب 3/38 درجه سانتیگراد یا بالاتر

۵. لرز

۶. کاهش وزن

۷. سرفه همراه خلط. خلط این بیماران چرکی، اغلب دارای رگه‌های خونی و گاهی بدبو است.

ـ علل بیماری:

آبسه ریه معمولاً به‌عنوان عارضه‌ای متعاقب پنومونی (ذات‌الریه) رخ می‌دهد. گاهی آبسه ریه در اثر استنشاق ترشحات آلوده از مجاری تنفسی فوقانی به داخل ریه، در یك فرد بیهوش یا دچار افت هوشیاری ایجاد می‌شود. افت هوشیاری بیماران ممکن است ناشی از ضربه سر، استفاده از بیهوشی یا بی‌حسی برای جراحی (شامل بیحسی دندانی)، مسمومیت ناشی از الکل و خواب عمیق اعمال شده توسط

داروها باشد. عامل آبسه ریه عموماً باکتری‌های بیماری‌زایی نظیر کلبسیلا، پسودوموناس، استافیلوکوک یا استرپتوکوک بتاهمولیتیک می‌باشند.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. بیماری اخیر، به ویژه پنومونی (ذات‌الریه) با سرعت بهبود آهسته.

۲. اعتیاد به الکل.

۳. بیهوشی عمومی برای جراحی یا صدمات اخیر منجر به بیهوشی.

ـ پیشگیری:

۱. اقدام فوری جهت درمان طبی در موارد عفونت‌های تنفسی و به ویژه پنومونی (ذات‌الریه)

۲. حفظ بهداشت مطلوب دهان و دندان برای جلوگیری از عفونت‌های دهانی که می‌تواند منجر به آبسه ریه گردد.

ـ عواقب موردانتظار:

معمولاً با درمان آنتی‌بیوتیکی طولانی‌مدت (تا شش ماه) قابل علاج است.

ـ عوارض احتمالی:

۱. پاره شدن آبسه که منجر به آمپیم یا خونریزی شدید در ریه می‌گردد.

۲. گسترش عفونت به سایر نواحی بدن، به ویژه مغز

۳. در صورت عدم پاسخ مناسب به درمان آنتی‌بیوتیکی، آبسه مزمن شده و عوارضی چون کاهش وزن، کم‌خونی، برونشکتازی یا بیماری مزمن ریه را در پی دارد.

ـ درمان:

۱. بررسی‌های تشخیصی ممکن است شامل آزمایش‌های خون، کشت چرك به‌دست آمده از آبسه جهت تعیین نوع آنتی‌بیوتیك تجویزی و عکس ساده ریه و اسکن ریه باشد. برونکوسکوپی (استفاده از یك وسیله بصری با چراغی در نوك آن که از نای عبور داده شده و وارد برونش‌ها می‌گردد) در موارد مشکوك به ورود جسم خارجی به ریه.

۲. ترك استعمال دخانیات

۳. در حد امکان به تمرین‌های ورزشی با تنفس عمیق بپردازید.

۴. نحوه تخلیه وضعیتی ریه را بیاموزید تا به خروج ترشحات نایژه‌ای کمك کنید. از ناحیه شکم به‌طوری بر روی تخت قرار گیرید که سر و سینه شما از لبه تخت آویزان باشد. خود را وادار به سرفه کنید. این کار را تا هنگامی که دیگر قادر به دفع خلط نباشید، ادامه دهید. این عمل را دوبار در روز به مدت 10-5 دقیقه انجام دهید.

۵. در صورت عدم بهبود آبسه، گاهی جراحی جهت تخلیه چرك آبسه یا برداشت آبسه و قسمت درگیر ریه لازم می‌شود.

ـ داروها:

آنتی‌بیوتیك‌ها به مدت طولانی برای مقابله با عفونت و جلوگیری از عود آن.

ـ فعالیت:

تا هنگامی که عکس ریه نشان‌دهنده پاك شدن عفونت باشد، فعالیت خود را کاهش دهید.

ـ رژیم غذایی:

رژیم خاصی نیاز نیست. مصرف مایعات را افزایش دهید به‌طوری که روزانه حداقل هشت لیوان مایعات مصرف کنید. با مصرف مایعات بیش از حد معمول، بدن مجبور می‌شود تا قسمتی از این مایعات را از طریق ریه دفع کند و بنابراین ترشحات ریوی غلیظ، رقیق‌تر شده و دفع آن با سرفه آسان‌تر می‌گردد.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان دچار علایم آبسه ریه باشید.

۲. افزایش تب به 3/38 درجه سانتیگراد یا بالاتر

۳. غلیظ شدن ترشحات با وجود درمان

۴. تخلیه وضعیتی ریه نشان‌دهنده تغییر در رنگ، مقدار یا قوام خلط باشد.

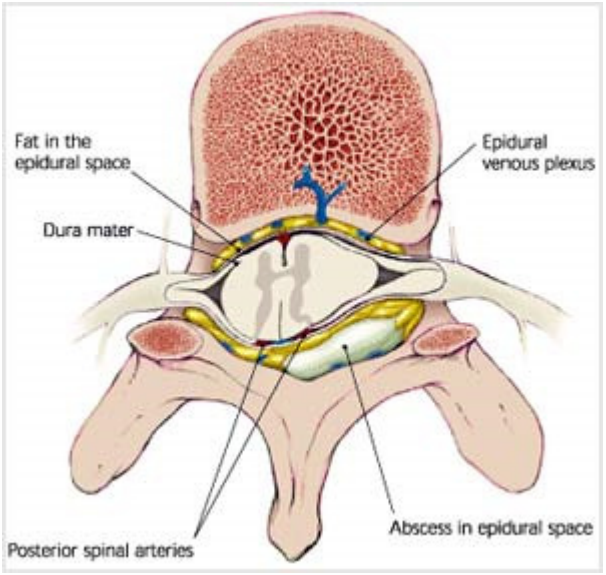
۵. علایم عفونت ریه پس از درمان عود نماید، به‌خصوص سرفه خلط‌دار، تب یا احساس ناخوشی عمومی

http://vista.ir/?view=item&id=124114

vista.ir
Online Classified Service

آبسه مغزی یا اپی‌دورال - brain or epidural abscess

آبسه مغزی یا اپی‌دورال تجمع چرك ناشی از یك عفونت باکتریال در مغز یا خارجی‌ترین لایه از سه لایه غشایی که مغز و نخاع را می‌پوشانند.



ـ علایم شایع:

علایم زیر به تدریج در عرض چند ساعت ظاهر می‌شوند. این علایم شبیه علایم تومور یا سکته مغزی هستند:

۱. درد در پشت و کمر، در صورتی که عفونت در غشای پوشاننده نخاع باشد.

۲. سردرد

۳. تهوع و استفراغ

۴. ضعف، بی‌حسی یا فلج در یك طرف بدن

۵. راه رفتن نامنظم

۶. تشنج

۷. تب

۸. منگی، گیجی، یا حالت هذیانی

۹. مشکل در صحبت کردن

ـ علل بیماری:

منشأ اولیه عفونت باکتریایی که موجب بروز آبسه مغزی یا اپی‌دورال می‌شود را اغلب نمی‌توان پیدا کرد. اما سه منشأ زیر شایع‌ترین هستند:

۱. عفونتی که از جمجمه به درون گسترش می‌یابد، مثلاً استئومیلیت (عفونت استخوان و مغز استخوان، ماستوئیدیت (عفونت زایده ماستوئید در پشت گوش)، یا سینوزیت (عفونت سینوس‌ها).

۲. عفونتی که به دنبال شکستگی جمجمه آغاز و گسترش می‌یابد.

۳. عفونتی که از سایر بخش‌های بدن که دچار عفونت شدند، مثلاً ریه‌ها، پوست، یا دریچه‌های قلب، از راه خون گسترش می‌یابد

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. صدمه به سر

۲. وجود یك بیماری که مقاومت بدن را کاهش داده باشد، به خصوص دیابت

۳. بروز اخیر یك عفونت، به خصوص در اطراف بینی، چشم‌ها و صورت

۴. بیماری که دستگاه ایمنی‌اش به علت بیماری (مثلاً ایدز) یا داروها سرکوب شده است.

۵. تزریق وریدی مواد مخدر

ـ پیشگیری:

۱. در هر گونه فعالیتی که خطر صدمه به سر وجود دارد، از کلاه ایمنی و سایر وسایل حفاظتی استفاده نمایید.

۲. در صورت بروز هر گونه عفونت در بدن به پزشك مراجعه کنید، به خصوص اگر عفونت در اطراف بینی یا صورت باشد (مثلاً عفونت گوش یا آبسه دندان). با مراجعه زود هنگام می‌توان از گسترش عفونت جلوگیری کرد.

ـ عواقب مورد انتظار:

با تشخیص و درمان زودهنگام معمولاً خوب می‌شود.

ـ عوارض احتمالی:

۱. بروز حملات تشنج، اغماء و مرگ، در صورتی که درمان انجام نشود.

۲. آسیب دایمی به مغز

ـ درمان:

آزمایشات تشخیصی ممکن است شامل موارد زیر باشند: آزمایش خون، آزمایش مایع نخاع، نوار مغز، سی‌تی‌اسکن، عکس‌برداری از جمجمه. نیاز به مراقبت ویژه وجود دارد. درمان طبی یا جراحی بستگی به محل آبسه دارد. معمولاً احتیاج به دادن آنتی‌بیوتیك و نیز جراحی برای تخلیه آبسه است. سایر درمان‌هایی که ممکن است لازم شوند عبارتند از مایعات داخل وریدی و تهویه مکانیکی.

ـ داروها:

۱. آنتی‌بیوتیك برای 6-4 هفته جهت مبارزه با عفونت

۲. داروهای ضد تشنج برای پیشگیری از بروز حملات تشنجی

۳. کورتیکواستروییدها برای کاهش تورم مغزی پس از عمل جراحی

ـ فعالیت:

هنگامی که در بیمارستان هستید نیاز به استراحت در تخت دارید. پس از طی دوران نقاهت 3-2 هفته‌ای، به هر اندازه که قدرت بدنی و احساس خوب بودن به شما اجازه می‌دهد، فعالیت داشته باشید.

ـ رژیم غذایی:

به هنگام بستری در بیمارستان، امکان دارد تزریق مایعات داخل وریدی ضروری باشد. پس از درمان، یك رژیم عادی و متعادل داشته باشید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمایید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان یکی از علایم آبسه مغزی یا اپی‌دورال را دارید.

۲. اگر تب به 3/38 درجه سانتیگراد یا بیشتر افزایش یابد.

۳. اگر دچارعلایم جدید و غیرقابل کنترل شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124115

vista.ir
Online Classified Service

آبله مرغان - chickenpox

آبله مرغان‌عبارت است از یك بیماری خفیف و بسیار مسری که توسط ویروس هرپس زوستر ایجاد می‌شود. این بیماری می‌تواند در سنی رخ دهد اما در کودکان شایع‌تر است.



ـ علایم شایع:

علایم زیر معمولاً در کودکان خفیف، اما در بزرگسالان شدید هستند:

۱. تب

۲. درد شکمی یا احساس ناخوشی عمومی که 2-1 روز طول می‌کشد.

۳. بثورات پوستی که تقریباً در هر جای بدن می‌تواند پدید آید، از جمله روی پوست سر، آلت تناسلی، و داخل دهان، بینی، گلو، یا مهبل. تاول‌ها ممکن است در نواحی بسیار وسیعی از پوست گسترده شده باشند، اما در دست و پا کمتر ظاهر می‌شوند. تاول‌ها در عرض 24 ساعت می‌ترکند و در محل آنها دلمه تشکیل می‌شود. هر 4-3 روز مجموعه‌هایی از تاول‌های جدید به وجود می‌آیند. در بزرگسالان یك سری علایم شبیه آنفلوآنزا وجود دارد.

ـ علل بیماری:

عفونت با ویروس هرپس زوستر، این ویروس از راه قطره‌های ریز در هوا یا تماس با ضایعات پوستی، از فرد بیمار انتقال می‌یابد. دوره نهفته پیش از آغاز علایم بیماری 21-7 روز است. اگر مادر یك نوزاد قبلاً یا در حین حاملگی آبله مرغان گرفته باشد، کودك وی تا چندین ماه در برابر آبله مرغان ایمنی دارد. اما این ایمنی در عرض 12-4 ماه پس از تولد کاهش می‌یابد.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

استفاده از داروهای سرکوب‌کننده دستگاه ایمنی بدن.

ـ پیشگیری:

در حال حاضر نمی‌توان از آن پیشگیری به عمل آورد. سرم حاوی پادتن علیه این ویروس برای افرادی که خطر ایجاد بیماری خطرناك در آنها زیاد است (مثل کسانی که داروهای ضدسرطان یا سرکوب‌کننده ایمنی دریافت می‌کنند) استفاده می‌شود. اخیراً یك واکسن جدید برای این بیماری مورد تأیید قرار گرفته است.

ـ عواقب مورد انتظار:

۱. بهبود خود به خودی. کودکان معمولاً در عرض 10-7 روز بهبود می‌یابند، در بزرگسالان این مدت بیشتر است و احتمال بروز عوارض در آنها بیشتر است.

۲. پس از بهبود، فرد برای تمام عمر در مقابل آبله مرغان ایمنی دارد.

۳. گاهی پس از طی شدن سیر بیماری آبله مرغان، ویروس در بدن به حالت خفته باقی می‌ماند (احتمالاً در ریشه اعصاب نزدیك نخاع). این ویروس خفته ممکن است سال‌ها بعد دوباره بیدار شود و بیماری زونا را ایجاد کند.

ـ عوارض احتمالی:

۱. عفونت باکتریایی ثانویه برروی تاول‌های آبله مرغان

۲. عفونت ویروسی چشم

۳. ندرتاً آنسفالیت (التهاب یا عفونت مغز)

۴. احتمال بروز زونا سال‌ها بعد در دوران بزرگسالی

۵. ندرتاً باقی‌ماندن جای تاول، در صورتی که تاول عفونی شود

۶. میوکاردیت (التهاب عضله قلب)

۷. آرتریت (التهاب مفصل) به طور گذرا

۸. ذات‌الریه

۹. نشانگان رای

ـ درمان:

۱. تشخیص معمولاً با ظهور تاول‌های پوستی داده می‌شود و بنابراین انجام آزمایش ضرورتی ندارد.

۲. درمان با هدف تخفیف علایم انجام می‌گیرد.

۳. برای کاهش خارش از پارچه، حوله، یا کمپرس آب سرد استفاده کنید.

۴. بیمار را تا حدامکان آرام و خنك نگهدارید. گرما و تعریق باعث بروز خارش می‌شوند.

۵. ناخن‌ها را کوتاه دارید تا بیمار نتواند خود را بخاراند. خاراندن تاول‌ها می‌تواند باعث عفونت ثانویه شود.

ـ داروها:

۱. داروهای زیر ممکن است خارش را کم کنند: بی‌حس‌کننده‌های موضعی و آنتی‌هیستامین‌های موضعی. این داروها موجب تخفیف خارش به سرعت و در کوتاه مدت می‌شوند. محصولاتی که حاوی لیدوکایین و پراموکسین هستند کمترین احتمال بروز واکنش‌های آلرژی را دارند. لوسیون‌های حاوی فنول، منتول و کافور (مثل لوسیون کالامین) نیز شاید توصیه شود. دستور دارویی را در مورد محصولات فوق رعایت کنید.

۲. اگر تب وجود دارد، از استامینوفن استفاه کنید. به هیچ عنوان از آسپیرین استفاده نکنید زیرا این دارو ممکن است در بروز نشانگان رای (یك نوع آنسفالیت) در کودکانی که دچار عفونت ویروسی هستند نقش داشته باشد.

۳. امکان دارد آسیکلوویر تجویز شود.

ـ فعالیت:

استراحت در رختخواب ضروری نیست. بیمار می‌تواند فعالیت آرام در یك محیط خنك داشته باشد. اگر هوا خوب باشد، کودك می‌تواند بیرون از خانه و در سایه بازی کند. تا زمانی که تمام تاول‌ها دلمه نبسته باشند و تاول جدیدی تشکیل نشود، کودك باید از سایرین جدا باشد و مدرسه نیز نباید برود.

ـ رژیم غذایی:

رژیم خاصی توصیه نمی‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا کودکتان علایم آبله مرغان را دارید.

۲. اگر بی‌حالی، سردرد، یا حساسیت به نور روشن رخ دهد.

۳. اگر تب بالای 3/38 درجه سانتیگراد وجود داشته باشد.

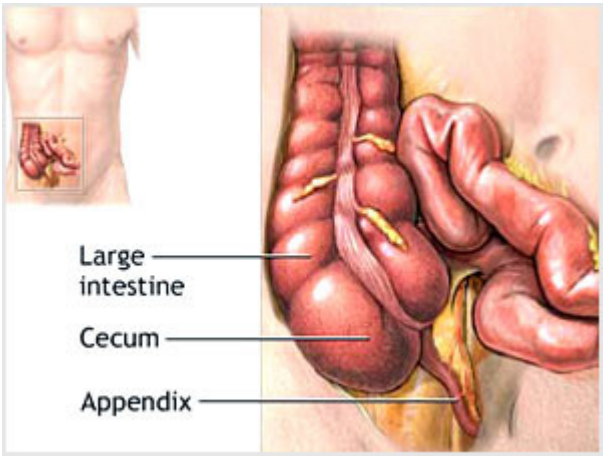
۴. اگر ضایعات آبله مرغان، سرفه نیز به علایم اضافه شود.

http://vista.ir/?view=item&id=124116

vista.ir
Online Classified Service

آپاندیسیت - appendicitis

آپاندیسیت عبارت است از التهاب زایده کرمی شکل آپاندیس که از اولین قسمت روده بزرگ به نام سکوم منشاء می‌گیرد. آپاندیس هیچ کار شناخته‌شده‌ای ندارد، ولی باعث بیماری می‌شود. هر ساله از هر 500 نفر جمعیت یك نفر دچار آپاندیسیت می‌شود.



علایم آپاندیسیت بسیار متغیر هستند. در مورد هر فردی که درد شکمی تشخیص داده نشده دارد، آپاندیسیت حتماً باید مدنظر باشد. این بیماری در هر سنی می‌تواند رخ دهد (در مردان بیشتر از زنان)، اما در کودکان زیر 2 سال نادر است. حداکثر بروز بیماری در سنین 24-15 سالگی است.

ـ علایم شایع:

۱. دردی که از نزدیك ناف شروع می‌شود و تدریجاً به قسمت تحتانی شکم در سمت راست نقل مکان می‌کند. درد کم‌کم مداوم می‌شود و از حالت مبهم به صورت کاملاً مشخص در می‌آید به طوری که مکان آن دقیق‌تر توسط بیمار نشان داده می‌شود. درد با حرکت، تنفس عمیق، سرفه، عطسه، راه رفتن، یا لمس، بدتر می‌شود.

۲. تهوع و گاهی استفراغ

۳. یبوست و ناتوانی در دفع گاز

۴. اسهال (گاهی)

۵. تب کم شدت، که پس از سایر علایم آغاز می‌گردد.

۶. تشدید درد به هنگام لمس ناحیه تحتانی شکم در سمت راست، معمولاً در نقطه‌ای حدود یك سوم مسیر ناف به برجستگی بالایی استخوان لگن. (توجه داشته باشید که این توصیف فقط زمانی صدق می‌کند که آپاندیس در جای طبیعی خود باشد. در بعضی موارد، نوك آپاندیس در جای دیگر واقع شده است، که این باعث مشکل شدن تشخیص می‌شود)

۷. تورم شکم (در مراحل انتهایی)

۸. افزایش تعداد گلبول‌های سفید خون

ـ علل بیماری:

عفونت به دلیل نامشخص، معمولاً توسط باکتری‌های موجود در لوله گوارش. آپاندیس ممکن است توسط محتویات در حال عبور در لوله گوارشی یا یك رشته بافتی غیرطبیعی که از بیرون به آن فشار وارد می‌آورد، مسدود شود. زمانی که آپاندیس عفونی می‌شود، متورم و ملتهب گشته و از چرك پر می‌شود.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

یك بیماری اخیر، به خصوص آلودگی با کرم‌های حلقوی، یا عفونت ویروسی دستگاه گوارش.

ـ پیشگیری:

هیچ روش خاصی برای پیشگیری وجود ندارد.

ـ عواقب مورد انتظار:

معمولاً با جراحی قابل درمان است. اگر درمان نشود، پاره شدن آپاندیس مرگبار خواهد بود.

ـ عوارض احتمالی:

۱. پاره شدن آپاندیس، تشکیل آبسه، و پریتونیت. این عوارض در افراد مسن‌تر بیشتر دیده می‌شود.

۲. عدم تشخیص درست، به علت کم بودن یا نامعمول بودن علایم، به خصوص در سنین خیلی پایین یا خیلی بالا

۳. تشکیل آبسه

ـ درمان:

امکان دارد آزمایش خون (افزایش تعداد گلبول‌های سفید خون) و آزمایش ادرار (برای رد عفونت ادراری) انجام شوند. عفونت ادراری ممکن است علایمی شبیه آپاندیسیت داشته باشد. زمانی که تشخیص هنوز قطعی نیست، هر دو ساعت درجه حرارت بدن را با دماسنج مقعدی اندازه‌گیری و ثبت نمایید. جراحی برای برداشتن آپاندیس (آپاندکتومی). از آنجایی که تشخیص آپاندیسیت مشکل است، اغلب تا زمانی که تشخیص قطعی داده نشود، دست به جراحی زده نمی‌شود. اگر آبسه تشکیل شود، امکان دارد جراحی به تعویق افتد تا زمانی که آبسه تخلیه شود و فرصت برای التیام آن باشد.

ـ داروها:

۱. داروهای ضددرد پس از جراحی تجویز می‌شوند.

۲. امکان دارد نرم‌کننده‌های مدفوع برای جلوگیری از یبوست توصیه شوند.

۳. اگر عفونت وجود داشته باشد آنتی‌بیوتیك نیز تجویز می‌شود.

۴. هرگز از داروی مسهل، تنقیه، یا داروی ضددرد استفاده نکنید. داروهای مسهل می‌توانند باعث پارگی آپاندیس شوند، و داروهای تخفیف دهنده درد یا تب نیز باعث مشکل‌تر شدن تشخیص می‌شوند.

ـ فعالیت:

تا وقت عمل در تخت یا صندلی استراحت کنید. پس از عمل، تدریجاً فعالیت‌های عادی خود را از سر گیرید.

ـ رژیم غذایی:

تا زمانی که آپاندیسیت تشخیص داده نشده است از خوردن و آشامیدن بپرهیزید. وقتی که معده خالی باشد، بیهوشی برای عمل جراحی بسیار بی‌خطرتر خواهد بود. اگر خیلی تشنه هستید، دهان خود را با آب بشویید. پس از عمل، ابتدا رژیم مایعات و به تدریج رژیم جامدات آغاز می‌شود

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. تب مساوی یا بیش از 9/38 درجه سانتیگراد

۲. استفراغ مداوم

۳. افزایش درد شکمی

۴. غش

۵. وجود خون در مدفوع یا محتویات استفراغ شده

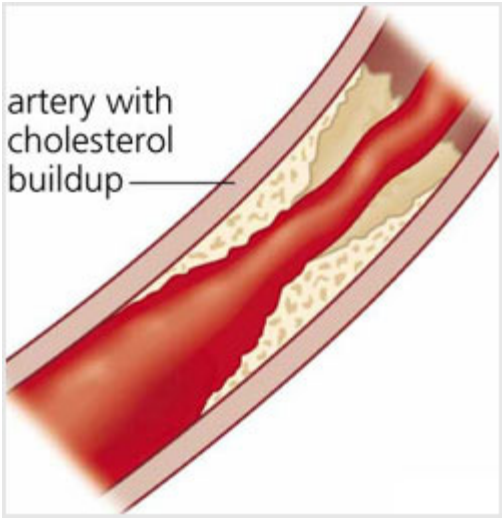
۶. منگی یا سردرد

http://vista.ir/?view=item&id=124117

vista.ir
Online Classified Service

آترواسکلروز (تصلب شرایین) - atherosclerosis

آترواسکلروز (تصلب شرایین) عبارت است از یك گونه بسیار شایع از تصلب شرایین که طی آن رسوباتی به نام پلاك در دیواره رگ‌هایی که خون حاوی اکسیژن و سایر موادمغذی را از قلب به سایر بخش‌های بدن می‌برند، تشکیل می‌شوند.



آترواسکلروز می‌تواند باعث آسیب کلیوی، کاهش خونرسانی به مغز و اندام‌ها، و بیماری رگ‌های قلبی شود. آترواسکلروز یکی از علل عمده سکته مغزی و قلبی است. شروع آن می‌تواند در سی و چند سالگی باشد. شیوع آن تا سن 45 سالگی در مردان بیشتر است. اما پس از یائسگی، شیوع آن در زنان افزایش می‌یابد.

ـ علایم شایع:

۱. تا زمانی که آترواسکلروز به مراحل پیشرفته نرسیده باشد، اغلب بدون علامت است. بروز علایم بستگی به این دارد که خونرسانی کدام قسمت بدن کم شده، و شدت و گسترش بیماری در چه حد است.

۲. گرفتگی عضله، وقتی که رگ‌های پا درگیر شده باشد.

۳. آنژین صدری یا حمله قلبی، وقتی رگ‌های قلبی درگیر شده باشند.

۴. سکته مغزی، یا کاهش ناگهانی و موقت خونرسانی به مغز اما بدون بروز سکته، در صورتی که رگ‌هایی که به گردن و سپس مغز می‌روند درگیر شده باشند.

ـ علل بیماری:

تکه‌های بافت چربی‌دار، که حاوی لیپوپروتئین کم‌چگال (همان کلسترول بد) هستند و به دیواره سرخرگ آسیب می‌رسانند، اغلب در محل اتصال و انشعاب سرخرگ‌ها رسوب می‌کنند. تشکیل این رسوبات شاید حتی در اوایل جوانی آغاز شود. بافت پوشاننده دیواره داخلی سرخرگ در این نقاط اتصال و انشعاب، مواد چربی موجود در خون را به دام می‌افکند. با تجمع مواد چربی، انعطاف‌پذیری سرخرگ کم و فضای داخلی آن تنگ‌تر می‌شود. در نتیجه جریان خون مشکل پیدا می‌کند. از طرفی این رسوبات ممکن است شکاف بردارند یا پاره شوند و روی آنها لخته خونی تشکیل شود که در نتیجه، رگ مسدود می‌شود.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. فشارخون بالا

۲. سابقه خانوادگی آترواسکلروز

۳. سن بالای 60 سال

۴. جنس مذکر

۵. استرس

۶. دیابت شیرین (مرض قند)

۷. چاقی؛ کم‌تحرکی

۸. سیگارکشیدن

۹. تغذیه نامناسب (خوردن چربی و کلسترول به مقدار زیاد)

۱۰. کلسترول بالا (بالا بودن غلظت لیپوپروتئین کم چگال [کلسترول بد] و پایین بودن غلظت لیپوپروتئین پرچگال (کلسترول خوب).

ـ پیشگیری:

۱. ترك سیگار

۲. به طور منظم ورزش کنید.

۳. حتی‌المقدور استرس را کاهش دهید و به سطح قابل کنترل برسانید.

۴. اگر دیابت یا فشارخون بالا دارید، برنامه درمانی مربوطه را به دقت رعایت کنید.

۵. توصیه‌هائی که در قسمت رژیم غذایی آمده است را رعایت کنید. کودکان و نوجوانانی که والدین آنها دچار آترواسکلروز هستند نیز از رژیم کم چربی سود خواهند برد.

ـ عواقب مورد انتظار:

این بیماری در حال حاضر علاج‌ناپذیر است. اما به تازگی گزارشات زیادی رسیده مبنی بر این که درمان مجدانهٔ عوامل خطر این بیماری می‌تواند تا حدی انسداد را کاهش دهد. بدون درمان، عوارضی پدید خواهند آمد که نهایتاً به مرگ منتهی خواهند شد. تحقیقات در زمینه علل و روش‌های درمانی این بیماری ادامه دارند.

ـ عوارض احتمالی:

۱. سکته قلبی

۲. سکته مغزی

۳. آنژین صدری

۴. بیماری کلیوی

۵. نارسایی احتقانی قلب

۶. مرگ ناگهانی

ـ درمان:

۱. آزمایشات تشخیصی ممکن است شامل موارد زیر باشد: نوار قلب، آزمون ورزش، آزمایش خون از نظر کلسترول کلی، خوب و بد، قندخون، و نیز عکس‌برداری از قفسه سینه و عروق

۲. برای بعضی از بیماران که خطر در مورد آنها زیاد است، جراحی انجام می‌شود: بازکردن رگ با بادکنك‌های مخصوص در مورد رگ‌های تنگ شده؛ و سایر روش‌های جراحی مانند تعویض رگ بیمار با سیاهرگ یا رگ‌های مصنوعی.

۳. ترك سیگار

ـ داروها:

به دلیل اینکه کار از کار گذشته و آسیب قبلاً وارد شده است، هیچ داروی رضایت‌بخشی برای درمان آترواسکلروز وجود ندارد. در تحقیقات اخیر مشخص شده است که پایین آوردن سطح کلسترول در کسانی که کلسترول خونشان بالا است، می‌تواند طول عمر را افزایش دهد. اگر شما علایم یك اختلال ناشی از آترواسکلروز را دارید، و رژیم غذایی و ورزش در کاهش کلسترول مؤثر واقع نشده باشند، شاید برای شما داروهای ضدچربی تجویز شود. برای درمان مشکلات همراه آترواسکلروز (مثلاً فشار خون بالا، یا بی‌نظمی‌های ضربان قلب) ممکن است تجویز داروهای دیگر ضروری باشد. در برخی تحقیقات مشخص شده است که آسپیرین و ویتامین ـ ای ممکن است خطر سکته قلبی را کاهش دهند. با پزشك خود در مورد اینکه آیا تجویز آنها برای شما لازم است یا خیر مشورت کنید.

ـ فعالیت:

معمولاً محدودیتی برای آن وجود ندارد. البته میزان فعالیت بستگی به وضعیت عمومی سلامت و وجود بیماری‌های دیگر دارد.

ـ رژیم غذائی:

رژیم غذایی باید کم چرب، کم نمك و پرفیبر باشد. مصرف غلات، میوه‌ها و سبزیجات تازه را افزایش دهید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

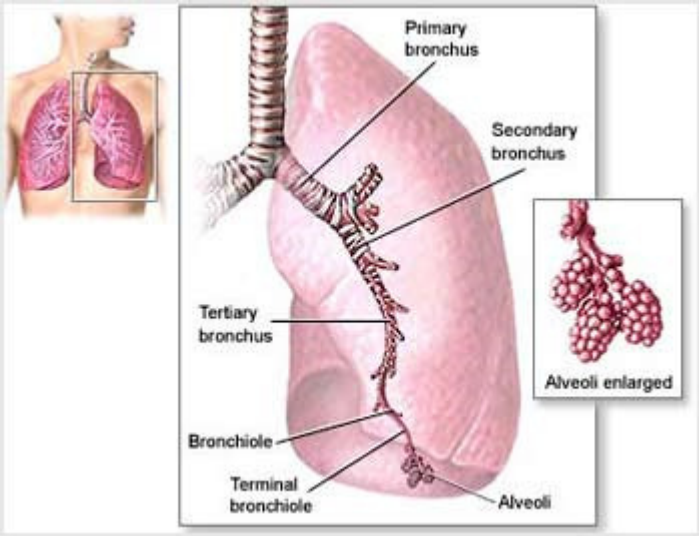
اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان دارای عوامل خطر بروز آترواسکلروز هستید و تمایل دارید از این بیماری پیشگیری کنید.

http://vista.ir/?view=item&id=124118

vista.ir
Online Classified Service

آتلکتازی - atelectasis

آتلکتازی عبارت است از جمع شدن یك قسمت از یا تمامی یك ریه. این وضعیت باعث عدم جذب اکسیژن به مقدار کافی از ریه می‌شود



ـ علایم شایع:

۱. جمع شدن ناگهانی و دربرگیرنده یك ناحیهٔ وسیع از ریه

۲. درد قفسهٔ صدری

۳. تنگی نفس؛ تند تند نفس کشیدن

۴. شوك (ضعف شدید، رنگ‌پریدگی پوست، تند شدن ضربان قلب)

۵. گیجی و منگی جمع شدن تدریجی

۶. سرفه

۷. تب

۸. تنگی نفس

ـ علل بیماری:

۱. انسداد مجراهای هوایی کوچك یا بزرگ ریه توسط ترشحات مخاطی غلیظ در اثر عفونت یا یك بیماری دیگر مثل فیبروزکیستیك

۲. وجود تومور در داخل مجرای هوایی

۳. وجود تومور یا رگهای خونی خارج از مجرای هوایی به نحوی که روی مجرای هوایی فشار وارد بیاورند

۴. استنشاق جسم خارجی، مثل اسباب‌بازی‌های کوچك یا بادام کوهی (پسته شام)

۵. جراحی طولانی مدت قفسهٔ سینه یا شکم تحت بیهوشی عمومی

۶. صدمه به قفسهٔ سینه یا شکستگی دنده‌ها

۷. زخم نافذ

۸. بزرگ شدن گره‌های لنفاوی

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سیگار کشیدن

۲. وجود یك بیماری که مقاومت بیمار را کاهش داده باشد یا وی را ضعیف کرده باشد.

۳. بیماری انسدادی مزمن ریه ،مثل آمفیزم و برونشکتازی.

۴. استفاده از داروهایی که باعث کاهش توجه و هوشیاری می‌شوند، مثل خواب آورها، پاربیتورات‌ها، آرام‌بخش‌ها، یا الکل.

ـ پیشگیری:

۱. وادار کردن به سرفه و تنفس عمیق هر 2-1 ساعت پس از عمل جراحی که حین آن از بیهوشی عمومی استفاده شده است.

۲. همچنین حتی‌الامکان بیمار باید در تخت جابجا شود و تغییر وضعیت دهد.

۳. به هنگام بیماری ریوی، یا پس از عمل جراحی، مایعات باید بیشتر مصرف شوند، چه به صورت خوراکی و چه به صورت تزریقی. به این ترتیب ترشحات ریه رقیق‌تر و نرم‌تر خواهند شد.

۴. اشیای کوچکی که احتمال دارد بچه‌های کوچك آنها را استنشاق کنند از دسترسی آنها دور نگه دارید.

ـ عواقب مورد انتظار:

آتلکتازی ندرتاً زندگی را به خطر می‌اندازد و معمولاً خود به خود برطرف می‌شود. در صورتی که آتلکتازی به علت ترشحات مخاطی غلیظ یا جسم خارجی ایجاد شده باشد، بیرون کشیدن آنها باعث رفع آن خواهد شد.اگر علت آتلکتازی یك تومور باشد، سرنوشت بیمار به ماهیت تومور بستگی دارد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. ذات‌الریه

۲. آبسه کوچك داخل ریه

۳. دایمی شدن جمع شدگی بافت ریه و تشکیل بافت جوشگاهی

ـ درمان:

۱. آزمایش برای اندازه‌گیری اکسیژن و دی اکسیدکربن خون و نیز عکس‌برداری از قفسهٔ سینه

۲. جراحی برای برداشتن تومور

۳. برونکوسکپی برای در آوردن جسم خارجی یا ترشحات مخاطی غلیظ

۴. سیگار را ترك کنید.

۵. روش تخلیهٔ ترشحات را فرابگیرید و پس از ترخیص اجرا کنید.

۶. حداکثر همکاری را در زمینهٔ دستورات پس از عمل جراحی داشته باشید. وضعیت خود را در تخت مرتباً عوض کنید، و سعی کنید مرتباً سرفه نمایید و نفس عمیق بکشید. توجه داشته باشید که هنگام سرفه، یك بالش را محکم روی محل تخلیه فشار دهید.

ـ داروها:

۱. از مصرف داروهای خواب آور پرهیز کنید. ممکن است آنها باعث عود آتلکتازی شوند.

۲. داروهای ضد درد برای رفع درد خفیف

۳. آنتی‌بیوتیك برای مبارزه با عفونت، که به طور اجتناب‌ناپذیر همراه با آتلکتازی رخ خواهد داد.

ـ فعالیت:

به محض روبه بهبود گذاشتن علایم، فعالیت‌های عادی خود را از سر گیرید.

ـ رژیم غذائی:

هیچ رژیم غذایی خاصی توصیه نمی‌شود، اما حداقل 8 لیوان آب یا سایر مایعات در شبانه‌روز بنوشید تا ترشحات ریه رقیق و نرم شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اتساع و برآمدگی شکم

۲. احساس تنگی نفس به طور ناگهانی

۳. آبی شدن بستر ناخن‌ها و لب‌ها

۴. درجه حرارت بدن مساوی یا بیشتر از 9/38 درجهٔ سانتیگراد

http://vista.ir/?view=item&id=124119

vista.ir
Online Classified Service

آرتریت روماتویید کودکان - arthritis juvenile rheumatoid

آرتریت روماتویید کودکان عبارت است از یك بیماری التهابی بافت همبند، عمدتاً بافت مفاصل، که در کودکان رخ می‌دهد. امکان دارد با آرتریت ناشی از بیماری لایم اشتباه شود. مفاصلی که درگیر می‌شوند معمولاً عبارتند از زانو، آرنج، مچ پا، و گردن.



التهاب می‌تواند عضلات نزدیك مفصل، غضروف، و غشاهای پوشانندهٔ مفصل را نیز متأثر سازد. این بیماری بین سنین 5-2 سالگی آغاز می‌شود، و اغلب تا جوانی بهبود می‌یابد. این بیماری در دختران چهار برابر شایع‌تر از پسران است.

ـ علایم شایع:

۱. درد، تورم، و خشکی در مفاصل انگشتان پا، زانو، مچ پا، آرنج، شانه، یا گردن. درد ممکن است به طور ناگهانی یا تدریجی آغاز شود و ممکن است در تنها یك، یا بسیاری از مفاصل وجود داشته باشد. امکان دارد کودك بدون این که قادر به توضیح باشد، از راه‌رفتن امتناع کند.

۲. دمای بدن هر روز و معمولاً در عصر تا حدود 4/39 درجهٔ سانتیگراد بالا می‌رود. تب به طور شایع با بثورات پوستی و لرز همراه است.

۳. بی‌اشتهایی، کاهش وزن

۴. کم‌خونی

۵. تحریك‌پذیری، بی‌حالی

۶. تورم گره‌های لنفاوی

۷. درد و قرمزی چشم

۸. درد قفسهٔ صدری به قدری شدید است که بر قلب تأثیر می‌گذارد.

ـ علل بیماری:

احتمالاً به علت اختلال خود ایمنی است که طی آن دستگاه ایمنی بدن به بافت خودی حمله می‌کند. بروز علایم برای اولین بار، اغلب باعث استرس جسمانی یا عاطفی می‌شود.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

ارث

ـ پیشگیری:

در حال حاضر قابل پیشگیری نیست.

ـ عواقب مورد انتظار:

این بیماری در حال حاضر غیر قابل درمان است. اما در عین حال، در 80%- 75% موارد، به هنگام بلوغ یا اوایل جوانی، بیماری به کلی فروکش کرده است. هر حمله معمولاً چند هفته به طول می‌انجامد و در طی دوران کودکی، بیماری هر از چندگاهی شعله‌ور می‌شود و دوباره فروکش می‌کند. علایم را معمولاً می‌توان با درمان تحت کنترل درآورد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. متأثر شدن بافت‌هایی غیر از مفاصل، مثلاً التهاب چشم، بزرگ شدن طحال، التهاب پردهٔ دور قلب یا عضلهٔ قلب.

۲. تغییر شکل و به هم خوردن ساختمان مفصل به طور دایمی

ـ درمان:

۱. آزمایش خون، از جمله بررسی وضعیت خود ایمنی

۲. عکس برداری از مفاصل. البته تغییرات مفصل ممکن است تا مراحل انتهایی بیماری نیز خود را در عکس مفصل نشان ندهند.

۳. روان درمانی یا مشاوره برای کمك به خانوادهٔ کودك، تا آنها بتوانند به خوبی از عهدهٔ بیماری طولانی مدت کودك برآیند. شاید مهمترین عامل در درمان کودك حمایت عاطفی از وی باشد.

۴. جراحی برای درست‌کردن مفصل تغییر شکل یافته (گاهی)

۵. اگر تشك کودك سفت نیست، یك تختهٔ ضخیم چندلا زیر تشك قرار دهید.

۶. چشم کودك باید حداقل 2 بار در سال معاینه شود تا اگر التهابی در چشم وجود دارد زود تشخیص داده شود.

۷. بسیار مهم است که کودك به مدرسه عادی به طور روزانه برود. هر جا که لازم باشد، مدرسه باید خدمات اضافی برای برآورده کردن نیازهای کودك فراهم کند.

ـ داروها:

آسپرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استرویيدی، برای کاهش درد و التهاب. امکان دارد داروهای دیگری چون کورتیکواستروييد، نمك طلا، یا یا سایر داروها تجویز شوند.

ـ فعالیت:

۱. به هنگام حمله، کودك باید در تخت استراحت کند، مگر برای توالت، تا زمانی که تب و سایر علایم تخفیف یابند.

۲. امکان دارد برای حفاظت و حمایت از مفصل ملتهب استفاده از آتل ضروری باشد.

۳. پس از رفع حمله، کودك می‌تواند به تدریج فعالیت‌های عادی را از سر بگیرد، البته باید در طی روز ساعت‌هایی را به استراحت بپردازد. کودك نباید زیاد خسته شود و هر شب باید حداقل 12-10 ساعت بخوابد.

۴. فیزیوتراپی توصیه خواهد شد. بعضی از حرکات را کودك خود می‌تواند انجام دهد، و بعضی از آنها را والدین می‌توانند برای کودك انجام دهند. انجام حرکات توصیه شده مهم است زیرا کمك می‌کند تا درد و اثرات ناتوان کنندهٔ بیماری به حداقل برسند.

۵. به دلیل تغییرات دوره‌ای علایم، گاهی برنامه فیزیوتراپی نیاز به بازبینی خواهد داشت.

۶. به طور کلی از انجام ورزش‌هایی که بدن کودك در معرض ضربه قرار می‌گیرد باید خودداری شود، اما کودك باید تشویق شود تا در دیگر فعالیت‌های مدرسه، خانه یا اجتماع شرکت کند.

ـ رژیم غذائی:

کودك باید یك رژیم مغذی و متعادل داشته باشد، در عین حال وی را باید تشویق به خوردن نمود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. درد قفسهٔ صدری یا تب

۲. علایم جدید و بدون توجیه. توجه داشته باشید که داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است با عوارض جانبی همراه باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124120

vista.ir
Online Classified Service

آرتریت عفونی (چرکی) - arthritis infectious

آرتریت عفونی (چرکی) عبارت است التهاب در یك مفصل ناشی از عفونت. هر مفصلی می‌تواند درگیر شود، اما این بیماری در مفاصل بزرگتر مثل مفصل ران، یا آن دسته از مفاصلی که در معرض ضربه قرار دارند مثل زانو یا مفاصل موجود در دست، شایع‌تر است.



ـ علایم شایع:

۱. تب و لرز (گاهی تب بالا است)

۲. درد در باسن، ران یا کشاله ران (گاهی)

۳. قرمزی، تورم، درد (اغلب ضرباندار) مفصل و درد به هنگام لمس مفصل. درد گاهی به سایر مفاصل انتشار می‌یابد و با حرکت بدتر می‌شود.

ـ علل بیماری:

واردشدن میکرب به مفصل، معمولاً باکتری‌ها (استرپتوکك، استافیلوکك، گنوکك [عامل سوزاك] ، هموفیلوس، یا باسیل سل) یا قارچ‌ها. میکروب‌ها از منشاءهای مختلف وارد مفصل می‌شوند: عفونت در مکانی دیگر در بدن، مثلاً در مورد سوزاك و بیماری سل عفونت در جوار مفصل، مثل جوش‌های چرکی روی پوست سلولیت، یا عفونت استخوانی. صدمه به مفصل، مثل زخم با اجسام سوراخ‌کننده، یا سائیدگی پوست روی مفصل

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سن بالاتر از 60 سال

۲. بروز یك بیماری که مقاومت بدن را کم کرده است.

۳. عفونت‌های منتقله از راه جنسی

۴. دیابت شیرین (مرض قند)

۵. آرتریت روماتویید

۶. استفاده از داروهای سرکوب‌کننده ایمنی

۷. عمل جراحی روی مفصل

۸. تزریق داخل مفصل

۹. مصرف الکل

۱۰. مصرف داروهای روان‌گردان، به خصوص انواع تزریقی آنها

۱۱. بهداشت پایین

۱۲. وجود مفصل مصنوعی

۱۳. استفاده از آسپیرین و سایر داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی برای سایر بیماری‌ها ممکن است علایم التهاب مفصل را سرکوب کند و تشخیص را به تعویق بیاندازد.

ـ پیشگیری:

به هنگام فعالیت‌هایی که حین آنها احتمال آسیب به مفصل‌های در معرض ضربه مثل زانو وجود دارد، دقت لازم را در محافظت از مفصل به عمل آورید. چنانچه عفونتی در جای دیگر بدن وجود دارد، سریعاً در صدد درمان آن برآیید.

ـ عواقب مورد انتظار:

معمولاً با تشخیص و درمان زودهنگام بهبود می‌یابد. البته بهبود کامل هفته‌ها یا ماه‌ها به طول می‌انجامد. تأخیر در درمان ممکن است موجب تخریب مفصل و از بین رفتن حرکات آن شود، که حتی نهایتاً ممکن است به تعویض مفصل هم بیانجامد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. عفونت خون

۲. آسیب و یا معلولیت دایمی مفصل

۳. تشخیص اشتباهی به عنوان نقرس یا یك بیماری غیرعفونی دیگر، که باعث به تأخیر افتادن استفاده از آنتی‌بیوتیك می‌شود.

ـ درمان:

۱. آزمایشات تشخیصی ممکن است شامل موارد زیر باشد: شمارش سلول‌های خون، کشت خون، و کشت مایع مفصل عفونی شده، و عکس‌برداری از مفصل

۲. درمان شامل مصرف آنتی‌بیوتیك است. سیر بهبودی با کشت‌های متوالی از مفصل پیگیری می‌شود.

۳. بستری شدن (استراحت کامل) و استفاده از آنتی‌بیوتیك داخل وریدی

۴. جراحی برای تخلیه مایع مفصلی عفونی شده یا خارج نمودن جسم خارجی وارد شده به مفصل در اثر ضربه

۵. فیزیوتراپی پس از بهبود، برای به دست آوردن مجدداً توانایی‌های کامل مفصل

ـ داروها:

۱. داروهای ضددرد مخدری به طور کوتاه‌مدت برای دفع درد

۲. آنتی‌بیوتیك‌ها (اغلب داخل وریدی). تا زمانی که گفته نشده است، آنتی‌بیوتیك را قطع نکنید. امکان دارد عفونت پس از بهبود علایم مجدداً عود کند.

ـ فعالیت:

۱. همگام با بهبود علایم، فعالیت‌های عادی را به تدریج از سر گیرید.

۲. امکان دارد پس از درمان، از تمرینات مخصوص جهت بازگرداندن حرکت مفصل استفاده شود.

۳. پس از بهبودی، برای بازگرداندن کامل کار مفصل نیاز به فیزیوتراپی وجود دارد.

۴. امکان دارد استفاده از آتل یا گچ برای استراحت کامل مفصل ضروری باشد. توجه کنید که حرکت مفصل باعث به تعویق افتادن بهبود می‌شود.

ـ رژیم غذائی:

هیچ رژیم خاصی توصیه نمی‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. تب مساوی یا بالاتر از 9/38 درجه سانتیگراد

۲. خستگی، سردرد، درد عضلانی، و عرق ریزش

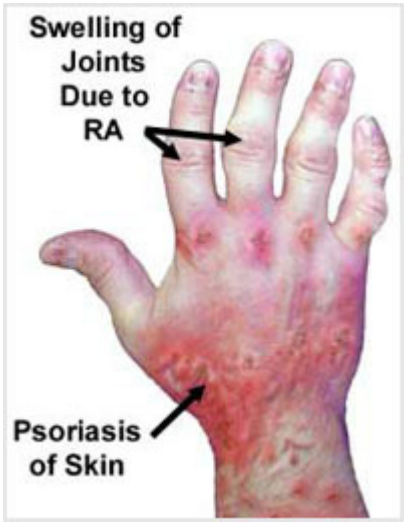
۳. اگر دچار علایم جدید و غیر قابل کنترل شده اید. توجه داشته باشید که داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124121

vista.ir
Online Classified Service

آرتریت مرتبط با پسوریازیس - psoriatic arthritis

آرتریت مرتبط با پسوریازیس التهاب مفاصل مجاور ضایعات پوستی و ناخنی پسوریازیس. هر یك از مفاصل بدن ممکن است درگیر شوند، ولی عمدتاً مفاصل انگشتان و مهره‌های کمری و گردنی مبتلا می‌شوند. این اختلال معمولاً خفیف بوده و بیشتر بین سنین 35-30 سال شروع شده و در سراسر زندگی به طور متناوب ادامه می‌یابد.



ـ علایم شایع:

۱. درد، تورم، محدودیت حرکت، احساس درد هنگام لمس و گرمی مفاصل مبتلا

۲. پوسته‌ریزی پوست

۳. ناخن‌های چاله‌دار، برجسته و زرد رنگ

۴. خستگی و تب (گاهی)

ـ علل بیماری:

۱. استعداد ابتلا به آرتریت مرتبط با پسوریازیس ممکن است ارثی باشد.

۲. واکنش ایمنی نسبت به یك عفونت استرپتوکوکی

۳. ناشناخته (علت این اختلال معمولاً ناشناخته است)

۴. صدمات جسمی یا روحی (به ندرت)

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. عفونت‌های استرپتوکوکی (به ندرت)

۲. سابقه خانوادگی آرتریت روماتویید یا پسوریازیس

ـ پیشگیری:

اقدام فوری برای درمان آنتی‌بیوتیکی عفونت‌های استرپتوکوکی.

ـ عواقب مورد انتظار:

این اختلال در حال حاضر غیر قابل علاج محسوب می‌گردد. مشخصه این بیماری دوره‌های مکرر فروکش و شعله‌ور شدن به طور حاد است. البته علایم بیماری با درمان قابل تسکین یا کنترل بوده و موارد معدودی از بهبود خودبه‌خود بیماری در مقالات پزشکی گزارش شده است. تحقیقات علمی درباره علل و درمان این بیماری ادامه داشته و این امید وجود دارد که درمان‌هایی مؤثرتر و در نهایت علاج‌بخش عرضه گردد.

ـ عوارض احتمالی:

پیشرفت به سوی آرتریت مزمن و ناتوانی شدید در حرکت ممکن است رخ دهد (به ندرت).

ـ درمان:

بررسی‌های تشخیصی ممکن است شامل آزمایش‌های خون از نظر عامل روماتویید و پادتن‌های ضد هسته (ANA) ، و رادیوگرافی مفاصل باشد. هدف درمانی عبارتست: از کنترل ضایعات پوستی و التهاب مفصلی، بی‌حرکت کردن مفاصل مبتلا با آتل ممکن است انجام شود. برای تخفیف درد مفصلی از گرم کردن مفصل استفاده کنید. برای این منظور استفاده از آب داغ، جریان‌های گردابی، لامپ‌های گرمایی، امواج ماوراء صورت یا دیاترمی همگی مؤثرند. برنامه‌ریزی دوره‌های منظم آفتاب گرفتن در حد متوسط کمك کننده است. اگر گرم کردن مفاصل باعث تسکین درد نشد، کمپرس سرد را امتحان کنید. اشعه درمانی PUVA (تاباندن اشعه ماوراءبنفش پر شدت پس از تجویز داروی پسورانی) برای ضایعات پوستی مؤثر است.

ـ داروها:

برای ناراحتی خفیف، استفاده از داروهای بدون نسخه نظیر آسپیرین ممکن است کافی باشد. برای کاهش التهاب مفصلی از داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی، تزریق کورتون به داخل مفاصل مبتلا (گاهی) و داروهای سرکوبگر دستگاه ایمنی نظیر متوترکسات ممکن است استفاده شود.

ـ فعالیت:

در طی دوره شعله‌وری بیماری استراحت نمایید و پس از آن فعالیت‌های طبیعی خود را به تدریج از سر بگیرید. سعی کنید فعالیت‌های بیرون از خانه در تماس با آفتاب را افزایش دهید.

ـ رژیم غذایی:

رژیم خاصی نیاز نیست.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمایید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان دارای علایم آرتریت مرتبط با پسوریازیس باشید.

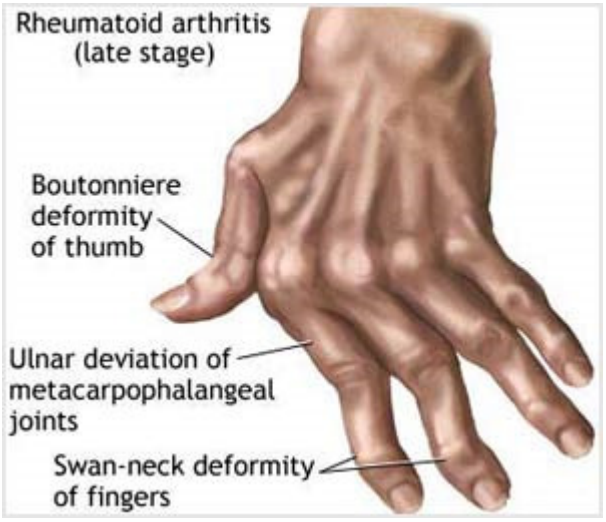
۲. اگر دچارعلایم جدید و غیر قابل توجیه شده اید. داروهای تجویزی ممکن است با عوارض جانبی همراه باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124122

vista.ir
Online Classified Service

آرتیت روماتوئید - arthritis rheumatoid

آرتیت روماتویید عبارت است از یك بیماری طولانی مدت که طی آن مفصل به همراه عضلات، غشاهای پوشاننده و غضروف متأثر می‌شوند. گاهی چشم و رگ‌های خونی نیز درگیر می‌شوند. این بیماری سه برابر در زنان شایع‌تر است و معمولاً بین سنین 60-20 سالگی رخ می‌دهد. حداکثر بروز آن در سنین 40-35 سالگی است.



ـ علایم شایع:

۱. تب پایین

۲. وجود برآمدگی‌هایی زیر پوست (گاهی)

۳. خشکی صبحگاهی

۴. شروع آهسته یا ناگهانی: قرمزی، درد، گرمی و درد به همگام لمس در یك یا تمام مفاصل فعال در دست، مچ دست، آرنج، شانه، پا، و مچ پا

ـ علل بیماری:

ناشناخته است، ولی این بیماری احتمالاً منشاِء خودایمنی دارد.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. سابقهٔ خانوادگی آرتریت روماتوئید یا سایر بیماریهای خودایمن

۲. عوامل ژنتیك، مثل نقص در دستگاه خودایمنی

۳. زنان در سنین 50-20 سالگی

۴. استرس عاطفی می‌تواند باعث شعله‌ور شدن بیماری شود

ـ پیشگیری:

هیچ روش خاصی برای پیشگیری وجود ندارد

ـ عواقب مورد انتظار:

بیماری ممکن است خفیف یا شدید باشد و این بیماری در حال حاضر قابل علاج نیست، اما با تشخیص زودهنگام، می‌توان درد بیمار را تخفیف داد، از بروز ناتوانی و معلولیت جلوگیری به عمل آورد، و عمر طبیعی توأم با فعالیت را برای بیمار به ارمغان آورد. با درمان محافظه‌کارانه، علایم در 75% بیماران در عرض یك سال بهبود می‌یابند. اما حدود 10%-5% بیماران، علی رغم درمان، نهایتاً معلولیت پیدا خواهند نمود

ـ عوارض احتمالی:

۱. اختلال بینایی

۲. کم‌خونی متوسط

۳. تغییر شکل مفصل به طور دایمی و از کارافتادگی بیمار

۴. داروهای مورد استفاده در درمان می‌توانند عوارضی به همراه داشته باشند، مثل مشکلات در معده، و مشکلات ناشی از استفاده طولانی مدت از استریید.

ـ درمان:

۱. انجام آزمایش خون برای بررسی وجود «عامل روماتویید»

۲. به فکر نقل مکان به آب و هوای خشك باشید. هوای مرطوب علایم را بدتر می‌کند.

۳. استفاده از دستکش در شب برای حفظ گرما

۴. تخفیف درد با گرما مثلاً استفاده از حوله آب داغ، لامپ تولید کنندهٔ، یا استخر آب گرم

۵. اگر تشك سفت ندارید، یك تختهٔ ضخیم چندلا زیر تشك خود قرار دهید.

۶. استفاده از آتل به هنگام خواب می‌تواند در حمایت و حفاظت از مفصل دچار بیماری کمك‌کننده باشد.

ـ داروها:

داروهای ضد التهاب غیراستروییدی، از جمله آسپیرین و سایر سالیسیلات‌ها؛ ترکیبات طلا؛ داروهای سرکوب کننده ایمنی. داروهای کورتیزونی معمولاً درد را به طور سریع و مؤثر برای مدت کوتاهی برطرف می‌کنند، اما در استفاده طولانی‌مدت، کمتر اثر بخش هستند. این داروها نمی‌توانند از تخریب پیش روندهٔ مفصل جلوگیری کنند، و گاهی اثرات جانبی زیانباری به بار می‌آورند. توجه داشته باشید که تزریق کورتیزون به داخل مفصل نیز درد را فقط به طور موقتی بهبود می‌بخشد.

ـ فعالیت:

تا زمانی که تب و سایر علایم شعله‌ور شدن بیماری ناپدید نگشته‌اند، در رختخواب به استراحت بپردازید، مگر برای رفتن به توالت. پس از آن فعالیت خود را از سر بگیرید ، اما در طی روز اوقاتی را برای استراحت اختصاص دهید. هر شب حداقل 12-10 ساعت بخوابید. خود را زیاده از حد خسته نکنید. به هنگام ایستادن، راه رفتن، و نشستن، بدن خود را راست نگاه دارید. حتی‌المقدور به طور فعال ورزش کنید تا قدرت عضلانی و حرکت مفصل تا حد امکان حفظ شود. شدت فعالیت را به تدریج به حد توصیه شده برسانید. ورزش در استخر آب گرم برای خشکی مفاصل خوب است. مفصل معلول شده را باید به طور غیر فعال (بدون استفاده از عضلات حرکت‌دهندهٔ آن مفصل) حرکت داد تا بدین‌وسیله از انقباض دایمی و جمع‌شدگی عضلات جلوگیری شود.

ـ رژیم غذائی:

یکی رژیم غذایی عادی و متعادل داشته باشید. از روی آوردن به رژیم‌های مد روز برای آرتریت، که اتفاقاً زیاد هم هستند، خودداری کنید. اگر چاق هستید وزن خود را کم کنید. چاقی باعث وارد آمدن فشار به مفصل می‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آرتریت روماتویید را دارید.

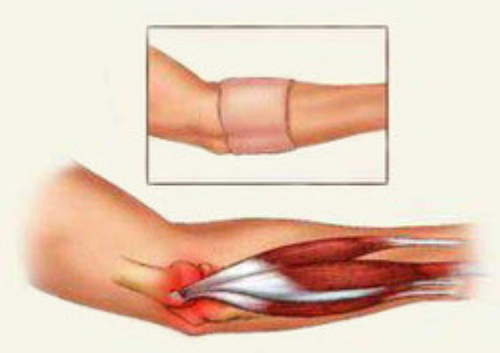
۲. اگر یکی از موارد زیر هنگام درمان رخ دهد: تب عارض شود، یا علایم در مفاصلی که قبلاً درگیر نبوده‌اند پدیدار شوند. اگر دچار علایم جدید و غیر قابل کنترل شده اید. توجه داشته باشید که داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است اثرات جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124123

vista.ir
Online Classified Service

آرنج تنیس‌بازان - tennis elbow

بیماری آرنج تنیس‌بازان عبارت است از التهاب نواحی استخوانی آرنج. عضلات، تاندون‌ها و اپی‌کوندیل (يك برجستگی استخوانی در سطح خارجی آرنج که در آنجا عضلات ساعد به استخوان بازو می‌چسبند) آرنج را درگیر می‌کند. بیشتر، بزرگسالان (40-20 ساله) را مبتلا می‌کند.



ـ علایم شایع:

۱. درد و حساسیت به لمس در اپی‌کوندیل

۲. مشت ضعیف

۳. درد در هنگام حرکات پیچشی دست یا بازو مثلاً حین استفاده از پیچ‌گوشتی یا بازی تنیس

ـ علل بیماری:

پارگی نسبی تاندون یا کشیده شدن تاندون روی استخوان به علت: استرس مکرر مزمن بر بافت‌هایی که عضلات ساعد را به ناحیه آرنج وصل می‌کنند. کشیدگی ناگهانی ساعد.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. شغل‌هایی که مستلزم حرکات شدید یا مکرر ساعد باشند مثل مکانیکی یا درودگری

۲. شرکت در ورزش‌هایی که مستلزم حرکات شدید یا مکرر ساعد باشند مثل تنیس

۳. وضعیت فیزیکی نامناسب

ـ پیشگیری:

۱. تا وقتی که در شرایط عالی قرار بگیرید، ورزش‌هایی مثل تنیس را به مدت طولانی انجام ندهید.

۲. راکت‌های تنیس می‌توانند آرنج تنیس‌بازان را بدتر کنند. انتخاب اندازه یا نوع متفاوت (بزرگ‌تر، قابل انعطاف‌تر، دسته بزرگتر) ممکن است کمك‌کننده باشد.

۳. اگر به تازگی یادگیری تنیس را آغاز کرده‌اید، از فرد متخصص کمك بگیرید. روش و وضعیت قرارگیری در پیشگیری از آسیب‌ها مهم هستند.

۴. برای افزایش تدریجی قدرت خود، از تمرینات وضعیت دهنده ساعد استفاده کنید.

۵. قبل از شرکت در ورزش‌ها به ویژه رقابت‌ها، به آهستگی و به‌طور کامل خود را گرم کنید.

ـ عواقب مورد انتظار:

معمولاً قابل‌علاج است اما درمان ممکن است 6-3 ماه زمان ببرد.

ـ عوارض احتمالی:

پارگی کامل رباط که برای ترمیم نیازمند جراحی است.

ـ درمان:

آزمون‌های تشخیصی معمولاً لازم نیستند (رادیوگرافی معمولاً همیشه منفی است). برای تسکین درد از گرما یا یخ استفاده کنید. از پوشش‌های مرطوب و گرم، لامپ گرمادهنده یا غوطه‌ور شدن در گرداب یا کمپرس سرد یا کیسه یخ (هر کدام مؤثرتر به نظر برسد) استفاده کنید. ممکن است درمان‌های دیامتری، فراصوت یا ماساژ دریافت کنید. این موارد به تسکین سریع‌تر علایم و بهبودی کمك می‌کند: ماساژ درمانی. ممکن است مجبور باشید برای بی‌حرکت کردن آرنج از یك اسپلینت ساعد استفاده کنید. در زمان استفاده از اسپلینت، ورزش زیر را 4-3 بار در روز انجام دهید: بازوهای خود را بکشید؛ مچ دست خود را خم کنید؛ سپس پشت دست خود را روی یك دیوار فشار دهید. آن را به مدت یك دقیقه نگه دارید. در صورت شکست سایر روش‌های درمانی ممکن است آزاد کردن تاندون در اپی‌کوندیل با جراحی لازم باشد. استفاده از تسمه آرنج تنیس‌بازان را هنگام از سرگیری فعالیت طبیعی پس از درمان مدنظر قرار دهید.

ـ داروها:

۱. داروهای ضد التهاب غیراستروییدی برای کاهش التهاب.

۲. تزریق بی‌حس کننده‌ها یا داروهای کورتیزونی. کورتیزون التهاب را کاهش می‌دهد و بی‌حس کننده‌ها موقتاً درد را تسکین می‌دهند.

ـ فعالیت:

تا زمان محو علایم، فعالیتی را که باعث ایجاد آرنج تنیس‌بازان بود، تکرار نکنید. سپس به تدریج پس از وضعیت‌گیری مناسب، فعالیت طبیعی خود را از سر بگیرید.

ـ رژیم غذائی:

رژیم غذایی خاصی ندارد.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان علایم آرنج تنیس‌بازان را داشته باشید.

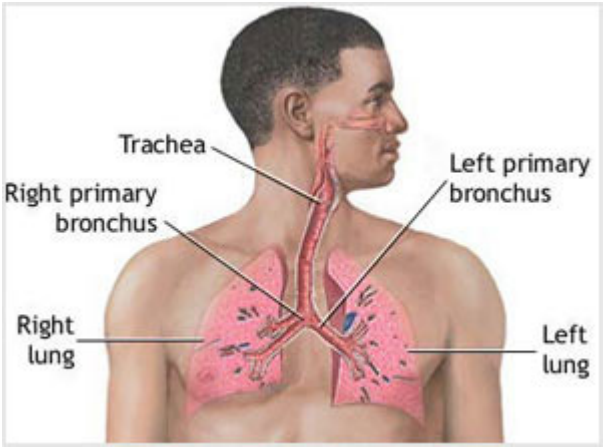
۲. اگر علی‌رغم درمان، علایم ظرف 2 هفته بهبود نیابند.

http://vista.ir/?view=item&id=124124

vista.ir
Online Classified Service

آزبستوز - asbestosis

آزبستوز عبارت است از التهاب ریه‌ها به علت استنشاق ذرات آزبست. این یك اختلال مزمن است اما مسری نیست. آزبستوز ممکن است منجر به سرطان ریه شود (خطر بروز با سیگار کشیدن بسیار بیشتر می‌شود). مردان بالای 40 سالی که در معرض ذرات آزبست بوده‌اند با احتمال بیشتری دچار این بیماری می‌شوند. آزبستوز شاید مهمترین بیماری ریوی ناشی از کار باشد.



ـ علایم شایع:

۱. تنگی نفس

۲. سرفه‌ای که یا بدون خلط است یا خلط کمی دارد.

۳. احساس کسالت عمومی

۴. نامنظمی خواب

۵. بی‌اشتهایی

۶. درد قفسه سینه

۷. خشونت صدا

۸. سرفه خونی

۹. علایم نارسایی احتقانی قلب

۱۰. آبی شدن ناخن‌ها

ـ علل بیماری:

مواجهه طولانی مدت با ذرات ریز آزبست به هنگام کار یا از منابع دیگر. قسمت محیطی ریه‌ها در اثر فیبرهای آزبست دچار آزردگی می‌شوند، که نهایتاً التهاب، ضخیم‌شدگی و تشکیل بافت جوشگاهی در بافت ریوی (فیبروز ریوی) را به دنبال خواهد داشت. امکان دارد تا 20 سال از زمان مواجهه با آزبست بگذرد و سپس علایم بیماری ظاهر شوند.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. مشاغلی که در ارتباط با آزبست هستند.

۲. تغذیه نامناسب

۳. سیگار کشیدن

۴. سوء در مصرف الکل

ـ پیشگیری:

۱. به هنگام قرار گرفتن در معرض آزبست، از ماسك حفاظتی مناسب یا هودی که با هوای آزاد ارتباط دارد استفاده کنید.

۲. اقدامات توصیه شده در رابطه با مهار غبارهای آزبست را به کار بندید.

۳. سیگار نکشید.

۴. یك برنامه منظم ورزشی داشته باشید تا سلامت قلبی ـ تنفسی شما حفظ شود.

۵. برای کارگرانی که در صنایع آزبست کار می‌کنند باید به طور منظم عکس‌برداری با اشعه ایکس انجام شود تا هرگونه سایه غیرطبیعی در ریه‌ها شناسایی شود. اگر در عکس مشکلی بود، فرد باید کار با آزبست را رها کند حتی اگر علامتی وجود نداشته باشد.

ـ عواقب مورد انتظار:

این بیماری در حال حاضر غیرقابل علاج است. اما علایم را می‌توان تخفیف داد یا تحت کنترل در آورد. تحقیقات علمی درباره علل و درمان این بیماری ادامه دارد. بنابراین امید می‌رود درمان‌های رو به روز مؤثری ابداع شوند و نهایتاً بتوان این بیماری را معالجه نمود.

ـ عوارض احتمالی:

۱. بیماری سل

۲. نارسایی قلبی به علت بیماری ریوی

۳. روی هم خوابیدن بافت ریوی

۴. جمع‌شدن مایع در فضای جنب (اطراف ریه‌ها)

ـ درمان:

۱. سیگار کشیدن را متوقف کنید.

۲. در صورت بروز هرگونه عفونت تنفسی، حتی سرماخوردگی، به پزشك مراجعه کنید.

۳. اگر بیماری پیشرفته باشد، به فکر نقل مکان به یك جای گرم و خشك باشید.

۴. فیزیوتراپی تنفسی و یادگیری روش‌های آن

۵. روش‌های تخلیه نایژه‌ای را فرا گیرید و به کار بندید.

۶. از افرادی که دچار عفونت هستند دوری کنید.

۷. واکسیناسیون آنفلوانزا و پنوموکك (ذات‌الریه) را به روز نگاه دارید.

۸. از دستگاه بخور خنك برای نرم کردن ترشحات نایژه‌ای استفاده کنید تا این ترشحات راحت‌تر تخلیه شوند.

ـ داروها:

۱. آنتی‌بیوتیك برای عفونت

۲. امکان دارد اکسیژن ضروری شود.

۳. برای رفع ناراحتی خفیف می‌توان از داروهایی مثل استامینوفن استفاده نمود.

۴. گشادکننده نایژه (استنشاقی یا خوراکی) همراه با استنشاق درمانی برای باز کردن لوله‌های نایژه‌ای تا حداکثر ممکن.

ـ فعالیت:

۱. در صورت وجود عفونت، در رختخواب استراحت کنید.

۲. پس از آغاز درمان، با رو به بهبود گذاشتن علایم فعالیت‌های عادی خود را از سر گیرید.

۳. برای حفظ ظرفیت ریه باید ورزش منظم به هر شکلی که قابل تحمل باشد انجام داد.

ـ رژیم غذائی:

رژیم خاصی توصیه نمی‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آزبستوز را دارید.

۲. بالا رفتن درجه حرارت بدن تا 3/38 درجه سانتیگراد یا بالاتر

۳. افزایش درد قفسه سینه یا تنگی نفس

۴. وجود خون در خلط

۵. کاهش فزاینده وزن

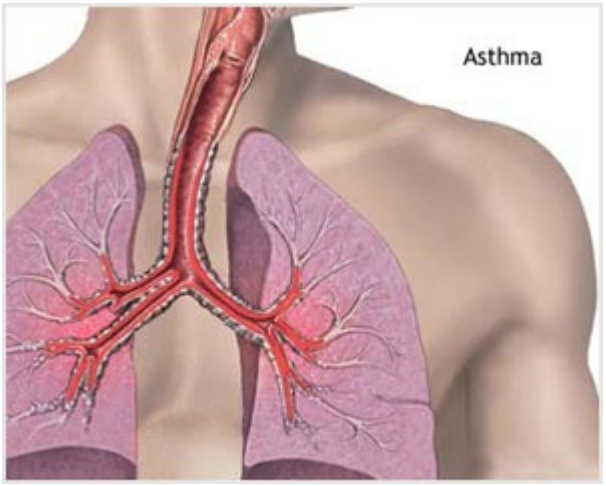
۶. اگر دچار علایم جدید و غیر قابل کنترل شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124125

vista.ir
Online Classified Service

آسم - asthma

عبارت است از یك بیماری مزمن همراه با حملات مکرر خس‌خس و تنگی نفس. این بیماری در تمام سنین می‌تواند وجود داشته باشد اما 50% از موارد، کودکان زیر 10 سال هستند. آسم بیشتر در پسران رخ می‌دهد تا دختران، اما در آسمی که در سنین بزرگسالی آغاز می‌شود زنان سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.



ـ علایم شایع:

۱. احساس فشردگی در قفسه سینه و تنگی نفس

۲. خس خس سینه به هنگام بازدم

۳. سرفه، خصوصاً در شب، معمولاً همراه با خلط غلیظ، شفاف و زرد

۴. تنفس سریع و سطحی که به هنگام نشستن بهتر می‌شود.

۵. مشکل در تنفس

۶. انقباض عضلات گردن

۷. آبی شدن پوست

۸. خستگی زیاد

۹. تنفس صدادار شبیه خرخر

۱۰. ناتوانی در صبحت کردن

۱۱. تغییرات ذهنی و روانی، از جمله بی‌قراری یا گیجی

ـ علل بیماری:

التهاب و اسپاسم ناشی از آن در مجاری هوایی (نایژه‌ها و نایژک‌ها)، و به دنبال آن ورم مجاری هوایی و غلیظ شدن ترشحات ریه (خلط). این امر باعث کاهش یا بسته شدن راه عبور هوا به ریه‌ها می‌شود. عواملی که می‌توانند این تغییرات را ایجاد کنند عبارتند از: مواد آلرژی‌زا مثل گرده گیاهان، گرد و غبار، شوره بدن حیوانات، کپک‌ها یا بعضی از غذاها، عفونت‌های ریوی مثل برونشیت، مواد آلاینده موجود در هوا، مثل دود و بوهای مختلف، قرار گرفتن در معرض موادشیمیایی یا سایر مواد، در قالب مواجهه شغلی.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. وجود سایر بیماری‌های آلرژیک، مثل اگزما یا تب یونجه.

۲. سابقه خانوادگی آسم یا آلرژی‌های دیگر.

۳. قرار گرفتن در معرض آلاینده‌های خطر.

۴. سیگار کشیدن.

۵. مصرف بعضی از داروها مثل آسپیرین.

۶. استرس‌های مختلف (عفونت‌های ویروسی، ورزش، ناراحتی عاطفی، بوهای زیانبار، و دود تنباکو).

ـ پیشگیری:

۱. از مواد آلرژی‌زای شناخته شده و آلاینده‌های هوا دوری کنید.

۲. داروهایی که به منظور پیشگیری از بروز حملات آسم تجویز می‌شوند را به طور منظم مصرف کنید؛ توجه داشته باشید که حتی اگر احساس می‌کنید مشکلی ندارید، مصرف داروها را قطع نکنید.

۳. از مصرف آسپیرین خودداری کنید.

۴. به دنبال عوامل آغازکننده حمله آسم بگردید و از آنها دوری کنید.

۵. نرمش‌های آسوده‌سازی و شل‌کننده عضلات، و نیز حرکات کمك‌کننده به تخلیه ترشحات تنفسی را انجام دهید.

ـ عواقب مورد انتظار:

۱. علایم را می‌توان با درمان و پایبندی جدی به اقدامات پیشگیرانه کنترل نمود.

۲. نیمی از کودکان آسمی نهایتاً خوب خواهند شد.

۳. در صورتی که درمان انجام نشود، حملات شدید ممکن است مرگبار باشند.

ـ عوارض احتمالی:

۱. نارسایی تنفسی

۲. پنوموتوراکس (وارد شدن هوا به فضای اطراف ریه‌ها).

۳. عفونت ریه و مشکلات مزمن ریوی در اثر حملات مکرر آسم.

ـ درمان:

اقدامات تشخیصی ممکن است عبارت باشند از آزمایش خون؛ بررسی‌های مربوط به کار ریه؛ و بررسی‌های مربوط به آلرژی که معمولاً به کمك آزمون‌های پوستی انجام می‌گیرند. مراقبت اورژانس و بستری کردن در موارد حملات شدید آسم. روان درمانی یا مشاوره، در صورتی که آسم با استرس ارتباط داشته باشد. حتی‌المقدور مواد آلرژی‌زا و آزاردهنده را از خانه و محل کار حذف کنید. درمان برای حساسیت‌زدایی از بعضی مواد آلرژی‌زای خاص. داروهایی را که به طور منظم استفاده می‌کنید همیشه به همراه داشته باشید. به هنگام حملات بنشینید. در زمان‌هائی از سال که مواد آلرژی‌زا در محیط فراوان هستند در منزل بمانید.

ـ داروها:

۱. اکسپکتورانت برای رقیق کردن خلط

۲. گشادکننده نایژه برای بازکردن مجاری هوایی

۳. داروی کورتیزونی داخل رگی (تنها برای موارد اورژانس) برای کم کردن واکنش آلرژی بدن

۴. استنشاق داروی کورتیزونی با دستگاه ریزقطره ساز. این شکل از مصرف داروهای کورتیزونی عوارض جانبی کمتری نسبت به نوع خوراکی دارد.

۵. آنتی‌هیستامین (کرومولین سدیم یا ندوکرومیل) به صورت استنشاقی با دستگاه ریزه قطره‌ساز. این نوع دارو جهت پیشگیری به کار می‌رود.

ـ فعالیت:

۱. شاید بهترین ورزش برای بیماران آسمی شنا باشد.

۲. درمان با داروهای گشادکننده نایژه غالباً از آسم ناشی از ورزش پیشگیری به عمل می‌آورد.

۳. فعالیت خود را حفظ کنید، اما از فعالیت‌های ورزشی ناگهانی خودداری کنید. اگر به دنبال ورزش سنگین حمله آسم رخ دهد، بنشینید و استراحت کنید. مقدار کمی آب گرم بنوشید.

ـ رژیم غذائی:

رژیم خاصی توصیه نمی‌شود، اما از خوردن غذاهایی که به آنها حساسیت دارید خودداری کنید. روزانه حداقل 3 لیتر آب بنوشید تا ترشحات رقیق باقی بمانند.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. شما یا یکی از اعضای خانواده علایم آسم را دارید.

۲. شما دچار حمله آسمی شده‌اید که به درمان جواب نمی‌دهد. این یك اورژانس است!

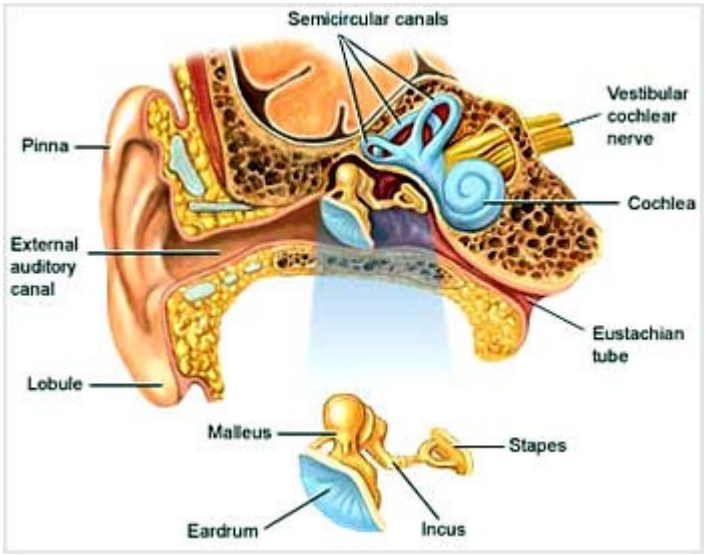
۳. علایم جدید و بدون توجیه. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124126

vista.ir
Online Classified Service

آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری - barotitis media

در این نوع آسیب، گوش میانی، شیپور اُستاش(مجرایی که محفظه گوش میانی را به حلق وصل می‌کند) و انتهای اعصابی که در گوش وجود دارند متأثر می‌شوند.



ـ علایم شایع:

۱. ناشنوایی (به درجات مختلف)

۲. احساس گرفتگی در گوش

۳. درد خفیف تا شدید در گوش، یا در ناحیه فك و پیشانی

۴. گیجی و منگی

۵. وزوز گوش

۶. گریه در شیرخواران و خردسالان

ـ علل بیماری:

آسیب ناشی از افزایش ناگهانی فشار محیط اطراف، مثلاً به هنگام ارتفاع کمکردن سریع هواپیما یا به هنگام غواصی. در این شرایط، هوا از راه بینی و حلق به محفظه گوش میانی می‌رود تا فشار در دوطرف پرده گوش متعادل شود. اگر مجرایی که از حلق به محفظه گوش میانی کشیده شده است (شیپور اُستاش) درست عمل نکند، فشار در محفظه گوش میانی کمتر از فشار محیط خواهد بود. این فشار منفی در گوش میانی باعث می‌شود پردهٔ گوش به درون گوش کشیده شود. بعداً ممکن است خون و مخاط در گوش میانی ظاهر شود. احتمال بروز این آسیب وقتی که فرد سرماخوردگی دارد و به غواصی می‌پردازد یا با هواپیما سفر می‌کند، بیشتر است. آسیب در اثر ضربه به گوش خارجی یا میانی (بوکس، اسکی روی آب، تصادفات، و غیره).

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. عفونت تنفسی اخیر

۲. پرواز با هواپیما

۳. غواصی

۴. سقوط با چتر نجات

۵. کوهنوردی در ارتفاعات بالا

۶. ورزش‌های مستلزم برخورد فیزیکی

۷. کم بودن سن (شیرخواران و خردسالان). در این حالت گشادکردن شیپور اُستاش (با قورت دادن آن دهان) دشوار است.

ـ پیشگیری:

۱. وقتی که سرماخوردگی دارید، غواصی نکنید. اگر مجبور به مسافرت با هواپیما هستید، از قرص‌ها یا اسپری‌های تخفیف‌دهنده تورم مخاط حلق و بینی استفاده کنید. دستور دارویی را رعایت کنید.

۲. به هنگام پرواز، زمانی که هواپیما در حال ارتفاع گرفتن است یا از ارتفاع خود کم می‌کند، یك شیرینی سفت یا آدامس را در دهان بجوید تا به این ترتیب مجبور به قورت دادن آب دهان خود به دفعات باشید.

۳. یك نفس متوسط بکشید، بینی خود را با دست بگیرید و دهان خود را ببندید و سعی کنید با راندن آهسته هوا به لُپ‌ها، هوا را به داخل شیپور اُستاش برانید (مانوور والسالوا).

۴. به هنگام ارتفاع گرفتن و کم‌کردن ارتفاع، به شیرخوار یك شیشه آب یا آب میوه بدهید.

ـ عواقب مورد انتظار:

اغلب موارد با درمان قابل برگشت هستند، بدون اینکه آسیب یا ناشنوایی دایمی رخ دهد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. ناشنوایی دایمی

۲. پاره شدن پرده گوش

۳.عفونت گوش میانی

ـ درمان:

در اغلب موارد، هیچ درمانی لازم نیست و علایم در عرض چند ساعت یا چند روز برطرف می‌شوند. اگر گوش ترشح دارد، یك تکه کوچك پنبه را در کانال گوش خارجی بگذارید تا ترشح را جذب کند. ندرتاً لازم می‌شود که برای آزاد کردن مایع محبوس شده در گوش میانی، پرده گوش با جراحی باز شود. گاهی یك لوله کوچك پلاستیکی نیز در پرده گوش تعبیه می‌شود تا فشار در دو طرف پرده گوش متعادل باقی بماند. این لوله در عرض 12-9 ماه خود به خود بیرون می‌افتد.

ـ داروها:

برای رفع درد و ناراحتی خفیف، می‌توان از داروهای کاهنده تورم مخاط بینی و حلق، و داروهای ضددرد مثل استامینوفن استفاده کرد. امکان دارد برای شما قرص‌ها و اسپری‌های قوی‌تر تخفیف دهنده تورم مخاط بینی و حلق تجویز شود. این داروها باید حداقل به مدت دو هفته پس از آسیب مصرف شوند. اگر عفونت وجود داشته باشد، آنتی‌بیوتیك تجویز می‌شود.

ـ فعالیت:

با شروع بهبودی علایم، فعالیت‌های عادی خود را از سر گیرید.

ـ رژیم غذائی:

هیچ رژیم خاصی توصیه نمی‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری را دارید.

۲. اگر یکی از این مشکلات در هنگام درمان روی دهد: تب، سرگیجه ، سردرد شدید، درد شدید ، گیجی.

۳. اگر دچار علایم جدید غیرقابل کنترل شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124127

vista.ir
Online Classified Service

آفت دهان - canker sores

آفت دهان عبارت است از زخم‌های دردناکی که در مخاط دهان به وجود می‌آیند. آفت دهان سرطانی نیست. آفت دهان ممکن است با عفونت هرپسی (ناشی از ویروس تبخال) اشتباه گرفته شود. این نوع زخم می‌تواند در هر دو جنس رخ دهد، اما در زنان شایع‌تر است.



ـ علایم شایع:

زخم در دهان با این خصوصیات: کوچك، بسیار دردناك، و کم عمق هستند و توسط يك غشای خاکستری پوشیده شده‌اند. حاشیه آنها توسط يك هاله قرمز پررنگ احاطه شده است. این زخم‌ها می‌توانند روی لب‌ها، لثه‌ها، داخل گونه‌ها، زبان، کام و گلو ظاهر شوند. به هنگام حمله آفت معمولاً 3-2 زخم به وجود می‌آیند، اما ظهور يك باره 15-10 زخم با هم دیگر خیلی بعید نیست. زخم‌ها ممکن است در 3-2 روز اول بسیار دردناك باشند به نحوی که فرد موقع خوردن یا صحبت کردن دچار ناراحتی می‌شوند. گاهی قبل از بروز زخم، برای 24 ساعت احساس مورمور یا سوزش وجود دارد.

ـ علل بیماری:

۱. استرس عاطفی یا جسمانی، اضطراب، یا ناراحتی و عصبی بودن پیش از عادت ماهانه

۲. آسیب به مخاط دهان در اثر خشن بودن دندان‌های مصنوعی، غذای داغ، مسواك زدن، یا کار دندانپزشکی

۳. عفونت‌های ویروسی

۴. آزردگی و تحریك ناشی از غذاهایی مثل شکلات، غذاهای ترش و اسیدی (سرکه، غذاهای دودی، آجیل‌ها یا چیس‌های نمك زده شده

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

کار دندانپزشکی اخیر.

ـ پیشگیری:

۱. دندان‌های خود را روزانه حداقل دوبار مسواك بزنید و مرتباً از نخ دندان استفاده کنید تا تمیزی و سلامتی دهان و دندان‌ها حفظ شود.

۲. حتی‌المقدور سعی کنید استرس نداشته باشید.

۳. از تماس نزدیك با افراد دچار عفونت خودداری کنید.

۴. دقت کنید که آفت، بیشتر بعد از خوردن چه نوع غذایی رخ می‌دهد. از خوردن غذاهایی که به نظر باعث آغاز حمله می‌شوند خودداری کنید.

ـ عواقب مورد انتظار:

اکثر زخم‌های آفتی بدون برجای گذاشتن جوشگاه در عرض 2 هفته خوب می‌شوند. حملات مکرر آفت شایع هستند. آفت ممکن است به صورت یك زخم حداکثر 3-2 بار در سال تا بروز بدون وقفه چندین زخم در سال رخ دهد.

ـ عوارض احتمالی:

در موارد شدید که خوردن و آشامیدن سخت می‌شود امکان دارد بدن کم آب شود.

ـ درمان:

امکان دارد توصیه به کشت زخم شود تا بتوان آفت را از زخم هرپسی افتراق داد، یا احیاناً اگر عفونت باکتریایی ثانویه وجود داشته باشد آن را تشخیص داد. دهان را روزانه 3 بار یا بیشتر با محلول نمك (نصف قاشق چایخوری نمك در حدود یك لیوان آب حل شود) شستشو دهید، البته به شرط این که خیلی دردناك نباشد. زخم‌ها را مرتباً با کمك گوش پاك کن یا چیزی شبیه آن که آغشته به پراکسیدهیدروژن 2% باشد پاك کنید. اگر آفت در اثر خشن بودن دندان، بریس یا دندان مصنوعی ایجاد شده باشد، به دندانپزشك مراجعه کنید. تا زمانی که این نوع مشکلات برطرف نشود آفت دهان خوب نمی‌شود.

ـ داروها:

۱. بی‌حس‌کننده‌های موضعی برای تخفیف درد

۲. خمیر حاوی یك مشتق استرویید به همراه تریامسینولون استوناید. اگر به محض شروع زخم مالیده شود، می‌تواند از بروز درد جلوگیری کند.

۳. دارویی که برای حمله قبلی آفت تجویز شده است را نگاه دارید. در صورت بروز مجدد آفت، بلافاصله آن را مصرف کنید. درمان هر چقدر زودتر آغاز شود، آفت خفیف‌تر خواهد بود.

ـ فعالیت:

محدودیتی برای آن وجود ندارد.

ـ رژیم غذائی:

محدودیتی برای آن وجود ندارد، مگر پرهیز از غذاهایی که آفت را بدتر می‌کنند. به هنگام بهبود آفت، هر چقدر می‌توانید مایعات زیادتر بنوشید و یك رژیم غذایی متعادل داشته باشید. برای کم کردن درد، مایعات را با نی بنوشید. مواد غذایی که کمتر باعث درد می‌شوند عبارتند از: شیر، ژلاتین مایع، ماست و بستنی.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر درجه حرارت بدن به 9/38 درجه سانتیگراد یا بالاتر برسد.

۲. اگر علی‌رغم درمان، آفت در عرض 3 روز رو به بهبود نگذارد.

۳. اگر درد غیر قابل تحمل باشد و با درمان تخفیف نیابد.

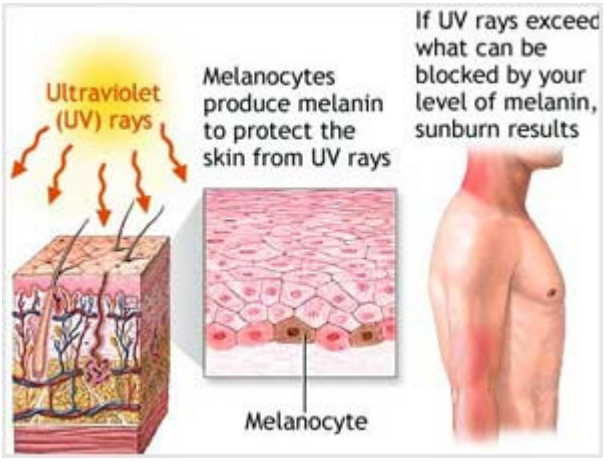
۴. اگر کودکی که دهانش آفت می‌زند وزن کم کند.

http://vista.ir/?view=item&id=124128

vista.ir
Online Classified Service

آفتاب‌زدگی (حساسیت به نور آفتاب) - sun poisoning

آفتاب‌زدگی عبارت است از واکنش به مواجهه بیش از حد با آفتاب. پوست در بخش‌هایی که بیشتر در معرض آفتاب است، درگیر می‌شود.



ـ علایم شایع:

۱. بثور قرمز پوست، گاهی همراه با تاول‌های کوچك، در نواحی مواجهه یافته با آفتاب

۲. لکه‌های پوسته‌ریزی‌کننده

۳. تب

۴. خستگی یا گیجی

۵. قرمزی پوست

ـ علل بیماری:

آفتاب زدگی بیشتر در فصول گرم که اشعه فرابنفش قوی‌تر است، رخ می‌دهد. مواجهه با آفتاب محرك آن است و معمولاً همراه با آفتاب سوختگی است. در افرادی که داروهایی مصرف می‌کنند که باعث حساسیت به نور می‌شوند (افزایش حساسیت به اشعه فرابنفش)، به ویژه محتمل است. شایع‌ترین داروها عبارتند از آنتی‌بیوتیك‌های تتراسایکلین، مدرهای تیازیدی، داروهای گوگرددار و قرص‌های ضد بارداری خوراکی. داروهای موضعی و مواد شیمیایی نیز می‌توانند واکنش ایجاد کنند (فنوتیازین‌ها، سولفونامیدها، قطران زغال، پسورالن‌ها). برخی از مواد آرایشی از جمله رژ لب، عطر و صابون‌ها نیز می‌توانند یك واکنش حساس به نور ایجاد کنند.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. عفونت زمینه‌ای

۲. سابقه آفتاب زدگی

۳. اختلالات متابولیك مثل دیابت شیرین یا بیماری تیرویید

۴. استفاده از داروهای سرکوبگر ایمنی با داروهای ذکر شده در فهرست «علل»

۵. اختلالات طبی مثل لوپوس اریتماتوی دیسکویید، لوپوس اریتماتوی سیستمیك و یا پورفیری

ـ پیشگیری:

اگر سابقه آفتاب‌زدگی دارید، در صورت امکان دور از آفتاب بمانید. در صورت مواجهه با آفتاب از لوسیون‌های ضد آفتاب با قدرت محافظتی 15 یا بالاتر استفاده کنید و لباس‌های محافظ بپوشید.

ـ عواقب مورد انتظار:

در صورتی که دور از آفتاب بمانید، علایم را می‌توان با درمان کنترل کرد. بهبودی تا یك هفته طول می‌کشد.

ـ عوارض احتمالی:

عود بثور و سایر علایم در صورت مواجهه با آفتاب حتی به مدت کوتاه به ویژه در بهار و تابستان.

ـ درمان:

هرگونه علت زمینه‌ای مثل داروها، مواد آرایشی یا اختلالات طبی را معلوم کنید. آزمون لکه نوری را می‌توان برای شناسایی علل آلرژی به نور به کار برد. در طول ساعات اوج اشعه فرابنفش (10 صبح تا 2 بعد از ظهر) از آفتاب دور بمانید. اگر باید به در اوج آفتاق به فضای باز بروید، لباس‌های محافظ بپوشید و از کرم‌های ضد آفتاب در دسترس استفاده کنید.

ـ داروها:

کلروکین قبل از مواجهه با آفتاب برای پیشگیری عود علایم ممکن است توصیه گردد. استروئیدهای التهابی ممکن است برای کاهش التهاب تجویز شوند.

ـ فعالیت:

جز برای اجتناب از مواجهه طولانی مدت با آفتاب، محدودیتی لازم نیست.

ـ رژیم غذائی:

رژیم غذایی خاصی ندارد. برای پیشگیری از دهیدراتاسیون (کم آبی)، مایعات فراوان بنوشید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان علامت آفتاب زدگی را داشته باشید.

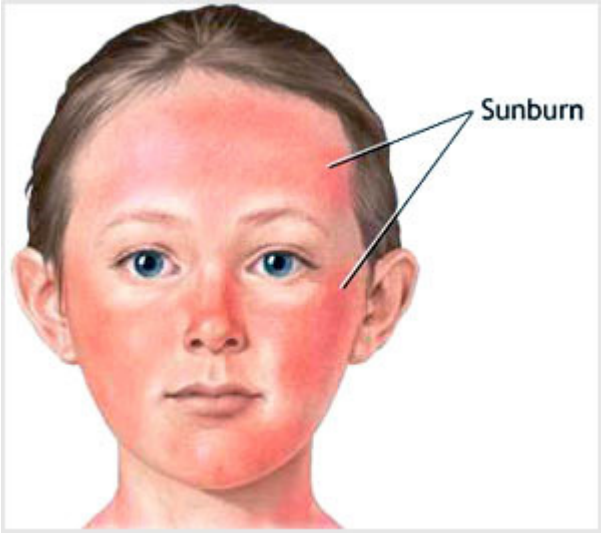
۲. اگر دچار علایم جدید و غیر قابل توجیه شده‌اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124129

vista.ir
Online Classified Service

آفتاب‌سوختگی - sunburn

آفتاب‌سوختگی عبارت است از التهاب پوست پس از مواجهه بیش از حد با آفتاب، لامپ‌های آفتابی یا مواجهه شغلی با نور شدید.



ـ علایم شایع:

۱. قرمزی، تورم، درد و گاهی تاول زدن پوست

۲. تب (گهگاه)

۳. تهوع و استفراغ (در سوختگی‌های شدید)

۴. دلیریوم (در سوختگی‌های شدید و وسیع)

۵. تیره شدن یا ور آمدن پوست پس از بهبودی، بسته به شدت سوختگی

ـ علل بیماری:

مواجهه بیش از حد با اشعه فرابنفش. در روزهای ابری، ابرهای نازك جلوی آن را نمی‌گیرند ولی بخار ودود تا حدی جلوی آن را می‌گیرند. مقدار زیادی اشعه فرابنفش به وسیله برف، آب، شن، و پیاده‌روها منعکس می‌شود.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. عوامل ژنتیك به ویژه پوست روشن، چشمان آبی و موی قرمز یا بور

۲. مواجهه با منابع صنعتی نور مثل قوس جوشکاری

۳. استفاده از داروها از جمله داروهای گوگرددار، تتراسایکلین‌ها، آموکسی‌سیلین یا قرص ضد بارداری خوراکی

ـ پیشگیری:

از ظهر تا 3 بعدازظهر از آفتاب دوری کنید. برای فعالیت‌های خارج از منزل از کرم ضد آفتاب استفاده کنید. محصولاتی که قدرت محافظت‌کنندگی آنها 15 یا بیشتر است، محافظت تقریباً کامل ایجاد می‌کنند. کرم‌هایی که قدرت محافظتی کمتری دارند، محافظت نسبی ایجاد می‌کنند و باعث تیره شدن خفیف می‌شوند. برخی از این کرم‌ها در برابر آب و تعریق، مقاوم هستند ولی باید پس از شنا یا مواجهه طولانی مدت دوباره از آنها استفاده کنید. روغن معدنی یا کره کاکائویی، باعث محافظت در برابر آفتاب نمی‌شوند.

برای حداکثر محافظت از یك داروی محافظت کننده فیزیکی مثل پماد اکسید روی استفاده کنید. پس از شنا و در مواجهه‌های متعدد، دوباره از آن استفاده کنید. استفاده از کرم‌های محافظت‌کننده به‌ویژه در نواحی حساس‌تر به سوختگی مثل پوست بینی، گوش‌ها، پشت ساق‌ها و پشت گردن مفید هستند. اگر بندرت دچار سوختگی می‌شوید، از یك کرم ضد آفتاب استفاده کنید که باعث تیره شدن شود و حداقل محافظت را ایجاد کند. از لباس‌های به رنگ خنثی مثل خرمایی استفاده کنید. از رنگ‌های روشن و سفید بپرهیزید زیرا آفتاب را روی صورتتان منعکس می‌کنند. اگر اصرار بر آفتاب گرفتن دارید، مواجهه خود را با آفتاب در روز اول به 10-5 دقیقه در هر طرف بدن محدود کنید. هر روز 5 دقیقه به این زمان اضافه کنید.

ـ عواقب مورد انتظار:

بهبود خود به خود در عرض 3 روز تا 3 هفته بسته به شدت آفتاب سوختگی

ـ عوارض احتمالی:

۱. تغییرات پوستی منجر به سرطان پوست از جمله ملانوم بدخیم و تهدید کننده زندگی

۲. کراتوز ضایعات پوستی پیش بدخیم

۳. چروك شدن زودرس و از دست رفتن خاصیت الاستیکی پوست

۴. دلیریوم موقت در موارد شدیدتر

ـ درمان:

برای کاهش گرمی و درد، پارچه نرمی را در آب خنك مرطوب کرده، روی نواحی سوخته قرار دهید. از کرم سرد یا لوسیون نوزاد استفاده کنید. برای تاول‌های شدید پوست، از پوشش سبك ژل نفت خام استفاده کنید. این ماده مانع چسبیدن اشیا به تاول‌ها می‌شود. در یك وان آب سرد که دارای بلغور یا سودای آشپزی باشد، غوطه‌ور شوید. خشکی پوست را آرام نوازش دهید و روی آن محکم نکشید.

ـ داروها:

برای تسکین درد و کاهش تب از داروهای بدون نیاز به نسخه مثل آسپرین یا استامینوفن استفاده کنید. داروهای ضد سوختگی بدون نیاز به نسخه که محتوی بی‌حس کننده‌های موضعی باشند، مثل بنزوکائین یا لیدوکائین، ممکن است مفید باشند ولی در برخی از افراد واکنش‌های آلرژیك ایجاد می‌کنند. مسکن‌ها یا داروهای کورتیزونی به مقدار کم ممکن است تجویز شوند.

ـ فعالیت:

تا کاهش تب و ناراحتی در هر وضعیتی که راحت هستید، استراحت کنید. خود را با یك «گهواره» تمام قد یا چادر نازك یا مواد دیگر بپوشانید تا پارچه بستر به پوست سوخته شده نخورد.

ـ رژیم غذائی:

رژیم غذایی خاصی ندارد. مصرف مایعات را افزایش دهید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. تب 3/38 درجه سانتیگراد یا بیشتر

۲. استفراغ یا اسهال

۳. دلیریوم

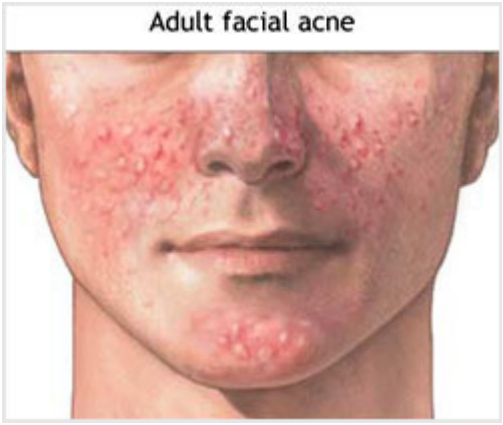
۴. درد و تبی که بیش از 48 ساعت طول کشیده باشد.

http://vista.ir/?view=item&id=124130

vista.ir
Online Classified Service

آکنه (جوشهای غرور) - acne

آکنه (جوشهای غرور) عبارت است از یك بیماری التهابی مزمن پوست که در دوران نوجوانی شایع است، اما گاهی به طور متناوب در سراسر زندگی رخ می‌دهد. مشخصهٔ این بیماری عبارت است از بروز جوشهایی روی صورت، قفسهٔ سینه و کمر. این بیماری در مردان شایع‌تر از زنان است.



ـ علایم شایع:

۱. نقاط سر سیاه به اندازهٔ سر سوزن

۲. نقاط سر سفید شبیه نقاط سر سیاه

۳. جوش‌های کوچك چرکی

۴. قرمزی و التهاب در اطراف جوشها

۵. در آکنهٔ شدید ممکن است کیست و آبسه دیده شود. کیست به صورت تورمی بزرگتر و سفت‌تر از جوشهای معمولی در پوست پدیدار می‌شود. آبسه نیز به صورت يك ناحيهٔ عفونی متورم ،ملتهب و دردناك به هنگام لمس و حاوی چرك است.

ـ علل بیماری:

غدد چربی پوست به دلایل نامعلوم دچار انسداد می‌شود، اما احتمالا تغییرات هورمونهای جنسی در دوران نوجوانی نقش دارد. وقتی که چربی داخل غدد چربی نتواند به بیرون پوست راه یابد، این چربی تجمع یافته و توسط باکتری‌هایی که به طور طبیعی در غده وجود دارند عفونی می‌شود. بر خلاف برخی عقاید رایج، عواملی چون عدم رعایت پاکیزگی یا غذاها نقشی در ایجاد آن ندارند. البته تمیزی می‌تواند آن را تخفیف دهد، اما فعالیت جنسی هیچ تأثیری روی آن ندارد.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. مواجهه با هوای بسیار گرم یا سرد

۲. استرس

۳. پوست چرب

۴. اختلالات غدد درون ریز

۵. استفاده از بعضی داروها مثل کورتیزون، هورمونهای مردانه، یا قرص‌های ضد بارداری

۶. سابقه خانوادگی آکنه

۷. بعضی مواد آرایشی

ـ پیشگیری:

در حال حاضر روشی برای پیشگیری از آن وجود ندارد.

ـ عواقب مورد انتظار:

درمان در اغلب موارد مؤثر است، و خود بیماری نیز معمولاً پس از دوران بلوغ و نوجوانی خود به خود بر طرف می‌شود. البته علی‌رغم درمان خوب و مناسب، آکنه گاهی شدت می‌یابد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. داشتن تصوری بد از ظاهر خود

۲. بروز جوشگاههای دائمی یا حالت حفره‌ای روی پوست صورت

ـ درمان:

اگر پوست‌تان چرب است، به ترتیب زیر آن را تمیز نمایید: به آرامی صورت خود را با صابون غیرمعطر برای 5-3 دقیقه ماساژ دهید. اما نواحی شدیداً جوش‌دار و دردناك را ماساژ ندهید (زیرا باعث گسترش عفونت می‌شود). پوست را به آرامی تمیز نمایید. صورت خود را 2-1 دقیقه بشویید و از صابون پاك كنید. گاهی صابون آنتی‌باکتریال كمك‌كننده است. پس از شستشوی پوست از الکل برای پاك كردن چربی استفاده نمایید. هر روز حولهٔ صورت را عوض نمایید. باکتری‌ها این توانایی را دارند که به سرعت در حوله‌های مرطوب رشد کنند. موهایتان را حداقل دو بار در هفته با شامپو بشویید. اجازه ندهید که موهایتان روی صورت بیاید، حتی در شب و به هنگام خواب مو باعث پخش چربی و باکتری‌ها می‌شود. برای پیشگیری یا درمان شورهٔ سر از شامپوی ضد شوره استفاده نمایید. از شوینده‌های کرم دار پرهیز کنید.

پس از ورزش شدید، عرقتان را بشویید و در اسرع وقت چربی صورت را پاك نمایید. از مواد آرایشی روغنی سنگین استفاده نکنید. مواد آرایشی غیرروغنی نازك که به صورت لوسیون هستند بسیار بهتر هستند. از مصرف مرطوب‌کننده‌ها خودداری نمایید مگر با نظر پزشك به هیچ وجه پوست خود را فشار ندهید، نخارانید، یا مالش ندهید. زمانی که پوست با این حرکات آسیب ندیده باشد بهتر و زودتر خوب می‌شود. البته پزشك ممکن است بسته به صلاحدید، نقاط سر سیاه را بردارد. هنگام مطالعه یا تماشای تلویزیون، دستتان را زیر صورت نگذارید. با توجه پزشك مقداری در معرض اشعهٔ ماوراءبنفش قرار بگیرید. شاید بعد از التیام آکنه و برای بر طرف کردن جوشگاههای نازیبا، جراحی زیبایی توصیه شود.

ـ داروها:

۱. آنتی‌بیوتیك‌ها، خوراکی و موضعی، برای مبارزه با عفونت

۲. تزریق کورتیزون به داخل ضایعات

۳. ایزوترتینوین (اگر باردار هستید به هیچ عنوان نباید استفاده شود)

۴. بنزیل پراکسید 5/2%، 5% یا 10% ممکن است کمك‌کننده باشد.

۵. رتین ـ آ باعث افزایش حساسیت پوست به آفتاب می‌شود.

۶. اگر باردار هستید، از هیچ داروی خوراکی برای آکنه استفاده نکنید.

۷. آکوتان نیز باعث افزایش حساسیت پوست به آفتاب می‌شود و حداقل سه ماه مانده به شروع بارداری مصرف آن باید متوقف شود.

ـ فعالیت:

هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد.

ـ رژیم غذائی:

غذا علت آکنه نیست، اما بعضی غذاها آن را بدتر می‌کنند. یادداشتی از غذاهایی که می‌خورید داشته باشید. برای اینکه بفهمید به کدام غذا حساسیت دارید، آن غذاهایی را که شك دارید آکنهٔ شما را بدتر می‌کنند از رژیم خود حذف کنید. بعد آنها را دوباره یکی یکی به رژیم غذایی اضافه نمایید. اگر مشخص شد که آکنه 3-2 روز بعد از اضافه کردن یك غذا تشدید می‌شود، آن غذا را به کلی از رژیم خود حذف کنید. اما اگر این اتفاق نیفتاد، می‌توانید آن را در رژیم غذایی نگاه دارید. آکنه معمولاً در تابستان بهتر می‌شود، بنابراین بعضی غذاها را که در زمستان نمی‌توان خورد شاید بتوان در تابستان نمود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر خود شما یا یکی از اعضای خانواده تان دچار آکنه است.

۲. اگر دچار علایم جدید و نامنتظره بروز کرده‌اند. توجه کنید که داروهای مورد استفاده برای درمان ممکن است باعث عوارض جانبی شوند.

http://vista.ir/?view=item&id=124131

vista.ir
Online Classified Service

آکنه روزاسه - acne rosacea

آکنه روزاسه (آکنه دوران بزرگسالی) عبارت است از التهاب مزمن پوست صورت (معمولاً گونه‌ها و بینی). این بیماری معمولاً بین 50-30 سالگی بروز می‌کند و در خانمها شایعتر از آقایان است، اما در آقایان شدیدتر است. درگیر شدن گسترده بینی، که بیشتر در آقایان دیده می‌شود، به رینوفیما معروف است.



ـ علایم شایع:

۱. پوست روی بینی و گونه‌ها به شکل نازیبایی قرمز و ضخیم می‌شود. رگهای کوچکی روی سطح پوست قابل مشاهده هستند.

۲. گاهی جوشهای کوچك قرمز رنگ و جوشهای کوچك چرکی سفید رنگ روی پوست صورت ظاهر می‌شوند.

۳. برافروختگی و قرمزی مداوم روی بینی، گونه‌ها و پیشانی

۴. صورت به هنگام لمس دردناك است.

ـ علل بیماری:

علت بروز این بیمار، ناشناخته است. اما به تجربه ثابت شده است که بیماری در اثر استرس، نوشیدنی‌های گرم، غذاهای داغ یا پر ادویه، و الکل تشدید می‌شود. گرما یا سرمای شدید، یا نور آفتاب نیز ممکن است باعث تشدید آن شوند.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. استفاده بیش از حد از کرمهای کورتیکواستروییدی برای درمان سایر بیماریهای پوستی

۲. عصبی بودن و استرس

۳. پوست سفید

۴. سوءمصرف الکل

ـ پیشگیری:

اجتناب از عوامل تشدیدکننده مثل نوشیدنی‌های داغ، غذاهای داغ یا پرادویه، الکل، و استرس. گاهی ممکن است گرما یا سرمای شدید و نور آفتاب باعث تخفیف بیماری شوند.

ـ عواقب مورد انتظار:

علایم را می‌توان با درمان تحت کنترل در آورد. آکنه روزاسه بیماری است که در سیر آن مرتباً فروکش کردن و شعله‌ور شدن رخ می‌دهد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. استرس روانی ناشی از ظاهر ناخوشایند صورت

۲. اختلالات خود ایمنی در چشم (نادر است)

ـ درمان:

۱. اگر شواهدی از آکنه روزاسه مشاهده کردید هر چه زودتر به پزشك مراجعه نمایید.

۲. از مواد آرایشی روغنی استفاده نکنید. از مواد آرایشی غیرروغنی و نازك استفاده کنید.

۳. استرس را کاهش دهید.

۴. گاهی برای حذف بافت‌های زاید جراحی انجام می‌گیرد.

۵. اگر تغییر شکل ظاهر باعث بروز استرس روانی شده است، روان درمانی و مشاوره می‌تواند مفید واقع شود.

ـ داروها:

آنتی‌بیوتیك‌ها یا داروهای موضعی شاید تجویز شوند. البته علت تأثیر مثبت آنها هنوز معلوم نیست. امکان دارد ایزوترتیفوئین تجویز شود. از مصرف ترکیبات حاوی کورتیزون خودداری نمایید، حتی آنهایی که بدون نسخه در دسترس هستند. این ترکیبات ممکن است باعث بدتر شدن بیماری شوند.

ـ فعالیت:

هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد.

ـ رژیم غذائی:

رژیم غذائی خاصی توصیه نمی‌شود. فقط باید از غذاهای پرادویه، الکل، یا هر غذایی که باعث برافروختگی صورت می‌شود پرهیز کرد.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر خود شما یا یکی از اعضای خانواده تان دچار آکنه روزاسه است.

۲. اگر التهاب علی‌رغم درمان بدتر شده است.

http://vista.ir/?view=item&id=124132

vista.ir
Online Classified Service

آلرژی غذائی - allergy food

آلرژی غذایی عبارت است از واکنش پیش از اندازه دستگاه ایمنی به برخی غذاها یا موادی که معمولاً بی‌خطرند. این واکنش‌های نامطلوب ممکن است ارثی یا ناشی از یك نقص اکتسابی بیوشیمیایی باشند. علایم ممکن است در عرض چند دقیقه یا تا 2 ساعت پس از خوردن آن غذای به خصوص بروز کنند. در بعضی موارد، امکان دارد علایم تا 2-1 روز بعد نیز ظاهر نشوند.



ـ علایم شایع:

۱. اسهال (شایع است)

۲. درد شکمی (شایع است)

۳. بثورات پوستی

۴. نفخ و باد شکم (شایع است)

۵. کهیر

۶. تورم صورت (به خصوص لب‌ها)

۷. خارش

۸. تورم دست‌ها و پاها

۹. آسم

۱۰. تهوع و استفراغ

۱۱. سرفه

۱۲. سردرد میگرنی

۱۳. غش یا حالت نزدیك به غش

ـ علل بیماری:

هرگونه غذا یا ماده‌ای که بلعیده می‌شود می‌تواند باعث بروز واکنش آلرژیك شود. غذاهایی که بیشتر باعث این حالت می‌شوند عبارتند از: شیر گاو، زرده تخم‌مرغ، گندم، سویا، بادام کوهی یا همان پسته شامی، ماهی، آجیل‌های درختی (مثل گردوی معمولی)، صدف دریایی، خربزه، کنجد، تخم آفتاب گردان، و شکلات.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. خطر برای کسانی که مشکلات آلرژی دیگری نیز دارند بیشتر است.

۲. اگر در یکی از اعضای خانواده سابقه آلرژی غذایی وجود داشته باشد.

ـ پیشگیری:

۱. غذاهای مسؤول ایجاد آلرژیی در خود را شناسایی نمایید و از آنها پرهیز کنید.

۲. معلوم شده است که شیرخورانی که غذای جامد برای آنها دیرتر شروع می‌شود کمتر به آلرژی غذایی دچار می‌شوند.

ـ عواقب مورد انتظار:

۱. آلرژی غذایی در شیرخواران معمولاً بعد از 4-2 سالگی برطرف می‌شود.

۲. بزرگسالانی که به بعضی از غذاها (به خصوص شیر، ماهی، صدف دریایی، یا آجیل) آلرژی دارند با احتمال بیشتری این آلرژی را برای سال‌ها حفظ می‌نمایند.

ـ عوارض احتمالی:

۱. واکنش شبیه کهیر

۲. آسم برونشیال

۳. التهاب روده‌ها

۴. ضایعات شبیه اگزما

۵. آنافیلاکسی (یك نوع آلرژی حاد و خطرناك که حین آن تنفس دچار مشکل شده، ضربان قلب نیر نامنظم شده، و فشارخون کاهش می‌یابد)

ـ درمان:

حذف غذاهای مورد شك از رژیم غذایی برای مدت دو هفته (یا تا زمانی که علایم آلرژی ناپدید شوند) و سپس اضافه نمودن غذاهای مورد شك به صورت تك تك به رژیم غذایی. به این ترتیب مشخص می‌شود که کدام غذاها در ایجاد آلرژی شما نقش دارند. آزمایش تزریق پوستی گاهی ممکن است غذای مسؤول آلرژی را شناسایی کند، اما کم نیستند مواردی که این آزمایش‌ها اشتباهاً غذاهایی که شما واقعاً به آنها آلرژی ندارید را به عنوان مسؤول آلرژی غذایی معرفی کنند. بیمارانی که آلرژی غذایی شدیدی به یك نوع غذا دارند باید بسیار مراقبت باشند که از خوردن آن غذا پرهیز کنند. همیشه یك کیت که دارای سرنگ حاوی آدرنالین است را به همراه داشته باشید تا اگر احیاناً غذای آلرژی‌زا تصادفاً خورده شد و واکنش حاد و فوری رخ داد، از این سرنگ استفاده شود. یك دست‌بند یا گردن آویز مخصوص همراه داشته باشید که روی آن نوع آلرژی دقیقاً مشخص شده باشد.

ـ داروها:

هیچ دارویی برای درمان آلرژی غذایی وجود ندارد، اما از بعضی از داروها می‌توان برای تخفیف یا رفع علایم استفاده نمود.

ـ فعالیت:

هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد.

ـ رژیم غذائی:

اجتناب از غذای مسؤول آلرژی، یا مصرف آن به مقدار کم. برچسب غذاها را به دقت مطالعه کنید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان دچار علایم خفیف تا متوسط آلرژی غذایی هستید.

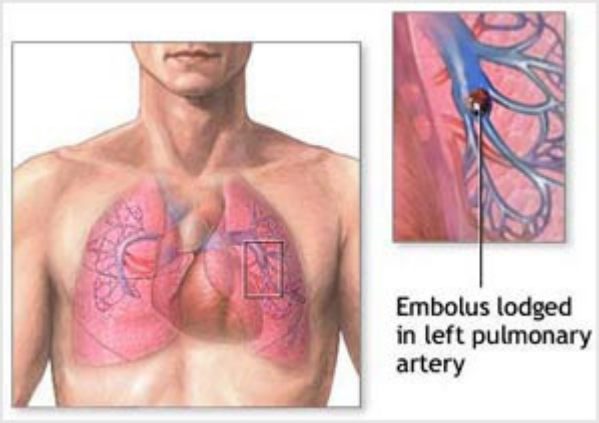
۲. اگر شاهد يك واكنش شديد پس از خوردن غذا در يكی از همراهانتان هستيد. در اين شرايط فوراً درخواست كمك اورژانس نمائيد.

http://vista.ir/?view=item&id=124133

vista.ir
Online Classified Service

آمبولی ریه - pulmonary embolism

آمبولی ریه وجود لخته خون یا چربی (به ندرت) در یکی از شریان‌هایی که به بافت ریه‌ها خونرسانی می‌کنند. لخته خون در ابتدا در یکی از وریدهای عمقی اندام تحتانی یا لگن شکل می‌گیرد. آمبولی چربی معمولاً از ناحیه يك شكستگی استخوانی تشکیل می‌شود.



لخته خون یا آمبولی چربی از طریق جریان خون و با عبور از قلب به یکی از شریان‌های مشروب کننده بافت ریه راه یافته و در آنجا مستقر می‌گردد. این پدیده سبب انسداد شریان مزبور و در نتیجه کاهش توانایی تنفسی و گاهی تخریب بافت ریه می‌گردد. آمبولی ریه در همه سنین ممکن است رخ دهد ولی در بزرگسالان شایع‌تر است.

ـ علایم شایع:

۱. کوتاهی نفس ناگهانی

۲. غش کردن یا حالت غش پیدا کردن

۳. درد قفسه سینه

۴. سرفه (گاهی همراه با خلط خونی)

۵. تندی ضربان قلب

۶. تب خفیف قبل از بروز علایم فوق معمولاً تورم و درد اندام تحتانی وجود دارد.

ـ علل بیماری:

لخته شدن خون در وریدهای عمقی. این حالت هر زمان که خون در داخل ورید تجمع یافته و به خوبی جریان نداشته باشد می‌تواند ایجاد شود.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سن بالای 60 سال

۲. هرگونه آسیب یا بیماری مستلزم استراحت طولانی در بستر

۳. نشستن در یك وضعیت ثابت به مدت طولانی مثلاً در طی مسافرت با هواپیما

۴. جراحی اخیر

۵. نارسایی احتقانی قلب

۶. اختلالات ریتم قلب

۷. پلی‌سیتمی؛ کم خونی همولیتیك

۸. شکستگی استخوان

۹. چاقی؛ استعمال دخانیات

۱۰. بارداری

۱۱. مصرف قرص‌های ضد بارداری به خصوص در خانم‌های سیگاری

ـ پیشگیری:

۱. از استراحت طولانی‌مدت در بستر در طی بیماری خودداری کنید. در طی دوره نقاهت از جوراب کشی استفاده کنید (چه در هنگام استراحت در بستر و چه در هنگام برخاستن از بستر)

۲. پس از جراحی هر چه سریعتر حرکت اندام‌های تحتانی و راه رفتن را شروع کنید.

۳. خودداری از استعمال دخانیات، به خصوص در خانم‌های 35 سال به بالا که قرص ضد بارداری مصرف می‌کنند.

۴. اجتناب از جراحی‌های غیر ضروری. در این موارد از روش‌های دیگری غیر از جراحی استفاده کنید.

۵. در طی سفر هر 2-1 ساعت مدتی ایستاده و راه بروید.

۶. مصرف یك قرص آسپرین در روز ممکن است نقش پیشگیری کننده در این زمینه داشته باشد؛ در این باره با پزشك خود مشورت کنید.

ـ عواقب مورد انتظار:

معمولاً مراقبت‌های ویژه در عرض 14-10 روز بهبود می‌یابد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. مرگ سریع‌الوقوع در اثر یك لخته بزرگ که بیش از 50% جریان خون ریه‌ها را مسدود کند.

۲. خونریزی شدید داخل ریه دراثر لخته‌های کوچکتر

ـ درمان:

بررسی‌های تشخیصی ممکن است شامل رادیوگرافی قفسه سینه، اسکن ریه، آنژیوگرافی ریه، نوار قلب، سمع قلب و ریه، و آزمایش‌های خون جهت اندازه‌گیری عوامل انعقادی و زمان پروترومبین باشد. هدف درمانی عبارتست‌از: حفظ عملکرد قلب و ریه در حد قابل قبول (تا برطرف شدن لخته) و جلوگیری از عود آمبولی. جراحی ممکن است به منظور بستن ورید بزرگ منتهی به قلب و ریه (ورید اجوف) یا قرار دادن یك صافی در داخل آن برای جلوگیری از عبور لخته‌ها به سمت قلب لازم باشد (به ندرت). استفاده از جوراب‌کشی یا پیچیدن ساق پا با باند

کشی، از نشستن به حالتی که ساق‌ها یا مچ پاها را روی یکدیگر بیندازید خودداری کنید. در هنگام نشستن طولانی مدت طوری بنشینید که پاها بالاتر از ران‌ها قرار گیرند. در هنگام خوابیدن پاها را بالاتر از سطح بستر قرار دهید.

ـ داروها:

۱. تجویز اکسیژن، در صورت نیاز

۲. آنتی‌بیوتیك‌ها، در موارد آمبولی عفونی

۳. داروهای ضد انعقاد در جهت حل کردن لخته و جلوگیری از ایجاد دوباره آن. سطح داروهای ضد انعقاد باید به طور مرتب اندازه‌گیری شود تا اطمینان حاصل شود سطح آنها در حد مطلوب و بی‌خطر است.

ـ فعالیت:

تا هنگام برطرف شدن علایم التهابی ناشی از لخته شدن خون در بستر استراحت نمایید. در طی استراحت در بستر اندام‌های تحتانی را به طور مکرر حرکت دهید تا به جریان یافتن خون در آن‌ها کمك شود.

ـ رژیم غذائی:

رژیم خاصی نیاز نیست.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. تشدید تورم و درد ساق پا

۲. درد قفسه سینه

۳. سرفه همراه خلط خونی

۴. کوتاهی نفس

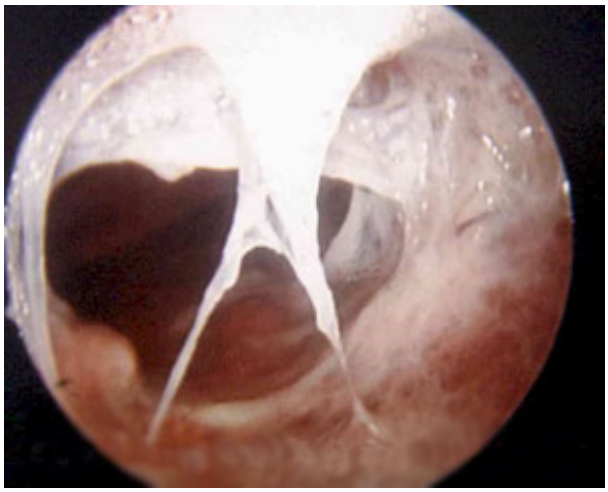
۵. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان دارای علایم آمبولی ریه باشید. این حالت یك اورژانس است!

http://vista.ir/?view=item&id=124134

vista.ir
Online Classified Service

empyema - آمپیم

آمپیم عبارت است از تجمع چرك در یکی از حفرات بدن. معمولاً در فضای اطراف ریه‌ها بین لایه‌های پرده جنب دچار عفونت، اتفاق می‌افتد. آمپیم به علت استفاده از آنتی‌بیوتیك‌ها تقریباً به ندرت رخ می‌دهد.



ـ علایم شایع:

۱. تنفس تند و سطحی

۲. لرز

۳. تب

۴. خستگی شدید

۵. سرفه خشك

۶. تنفس بد بو

۷. کاهش وزن

۸. درد قفسه سینه. این درد می‌تواند از یك ناراحتی مبهم تا درد تند و تیز، متغیر باشد. درد غالباً با سرفه یا تنفس بدتر می‌شود. درد ممکن است به قسمت پایینی قفسه سینه یا شکم گسترش یابد.

ـ علل بیماری:

۱. عارضه‌ای از: عفونت‌های ریه یا قفسه سینه، مثل ذات‌الریه، سل، یا آبسه ریه

۲. روی هم خوابیدن ریه یا آسیب به قفسه سینه

۳. وجود سرطان در سایر نقاط بدن

۴. بیماری کبد

۵. بروز عفونت در نقطه‌ای دیگر از بدن که به قفسه سینه گسترش یافته باشد.

۶. نارسایی احتقانی قلب

۷. بیماری کلیه

۸. بیماری از گروه بیماری‌های درگیر کننده بافت همبند و عروق، مثل لوپوس اریتمای منتشر

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. تغذیه نامناسب

۲. بیماری اخیر (قسمت علل را ببینید)

۳. سیگار کشیدن

۴. خستگی یا کار زیاد

۵. آب و هوای سرد و مرطوب

۶. محیط زندگی شلوغ و غیر بهداشتی

ـ پیشگیری:

در صورت بروز هر گونه بیماری یا عفونت جدی که ممکن است باعث آمپیم شود، برای درمان به پزشك خود مراجعه کنید.

ـ عواقب مورد انتظار:

درمان موفقیت‌آمیز به کشف و درمان بیماری زمینه‌ساز بستگی دارد. خارج کردن چرك از فضای تجمع چرك باعث تسریع بهبود می‌شود. برای درمان معمولاً نیاز به تجویز دوز بالای آنتی‌بیوتیك وجود دارد و بیمار غالباً باید بستری شود.

ـ عوارض احتمالی:

۱. منتژیت (عفونت پرده پوشاننده مغز)

۲. پریکاردیت (عفونت پرده دور قلب)

۳. آندوکاردیت (عفونت دریچه‌های قلب)

۴. آبسه مغز

ـ درمان:

برای تشخیص، کشت چرك و نیز عکس‌برداری از قفسه سینه با اشعه ایکس انجام می‌گیرد. درمان معمولاً شامل جراحی برای باز کردن حفره عفونی شده و تخلیه چرك است. این روش توراکوسنتز نامیده می‌شود. سیگار نکشید.

ـ داروها:

۱. آنتی‌بیوتیك برای مبارزه با عفونت

۲. برای درد خفیف می‌توان از استامینوفن استفاده کرد.

ـ فعالیت:

تا زمانی که درد و تب برطرف نشده باشد فعالیت خود را کم کنید. سپس فعالیت‌های عادی خود را تدریجاً از سرگیرید. بهبود کامل حدود دو ماه زمان می‌برد.

ـ رژیم غذائی:

رژیم خاصی توصیه نمی‌شود مکمل‌های ویتامینی بخورید و مایعات بیشتر بنوشید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان علایم آمپییم را دارید.

۲. تب

۳. زیاد شدن درد

۴. بدتر شدن تنگی نفس

۵. سرفه خشك و بدون خلط شود

۶. بستر ناخن‌های دست یا پا تیره شود.

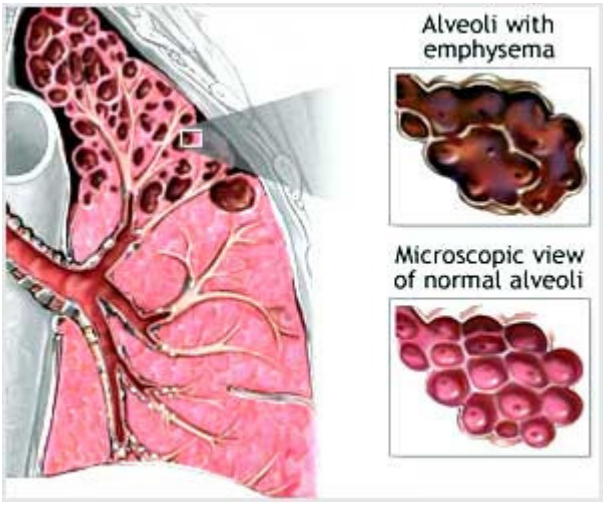
۷. در خلط خون ظاهر شود

http://vista.ir/?view=item&id=124135

vista.ir
Online Classified Service

آمفیزم - emphysema

آمفیزم عبارت است از یك بیماری مزمن ریه که طی آن کیسه‌های هوایی (حبابچه‌ها) در ریه بیش از اندازه گشاد می‌شوند و در نتیجه، خاصیت ارتجاعی رشته‌هایی که کیسه‌های هوایی را به هنگام تنفس باز و بسته می‌کنند از بین می‌رود. این بیماری معمولاً در بزرگسالان و بین سنین 55-75 سال رخ می‌دهد و در مردان شایع‌تر از زنان است.



ـ علایم شایع:

۱. غالباً در مراحل اولیه علامتی وجود ندارد.

۲. تنگی نفس که شدت آن تدریجاً طی سال‌ها زیاد می‌شود.

۳. عفونت‌های راجعه گاهگاهی در ریه‌ها یا لوله‌های نایژه‌ای

۴. بزرگ شدن قفسه سینه و شبیه شدن آن به بشکه

ـ علل بیماری:

۱. سیگار کشیدن برای سال‌های متمادی

۲. آلودگی هوا

۳. التهاب کیسه‌های هوایی در ریه‌ها

۴. کمبود ارثی آلفا ـ 1 ـ آنتی‌تریپسین

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سابقه آسم یا برونشیت

۲. بروز عفونت‌های مکرر تنفسی که باعث کاهش عملکرد بافت ریه می‌شود.

۳. آلرژی یا سابقه خانوادگی آلرژی

۴. مشاغلی که نیازمند تنفس مخصوص و با زور هستند مثل شیشه‌گری یا نواختن یك ساز بادی موسیقی.

ـ پیشگیری:

۱. سیگار نکشیدن

۲. از بودن در جاهایی که آلودگی هوا زیاد است خودداری کنید.

۳. ورزش در حد متوسط و در هوای تمیز انجام دهید.

۴. از بروز آنفلوآنزا و ذات‌الریه با زدن واکسن‌های مربوطه جلوگیری کنید.

۵. از تماس با بیمارانی که دچار عفونت تنفسی هستند خودداری کنید.

۶. در صورت بروز عفونت ریه به پزشك مراجعه کنید. پزشك ممکن است آنتی‌بیوتیك تجویز کند.

ـ عواقب مورد انتظار:

این بیماری را نمی‌توان معالجه کرد، اما با کنترل علایم می‌توان پیشرفت و شدت گرفتن بیماری را به تأخیر انداخت. اگر چه آمفیزم امید به زندگی را کاهش می‌دهد، بسیاری از افراد سال‌ها با آن زندگی می‌کنند. بدون درمان، عوارض بیماری ممکن است مرگبار باشند.

ـ عوارض احتمالی:

۱. مستعد بودن نسبت به بروز عفونت‌های ریه

۲. بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD)

۳. نارسایی تنفسی یا روی هم خوابیدن ریه

۴. نارسایی احتقانی قلب

ـ درمان:

۱. اقدامات تشخیصی ممکن است شامل آزمایش خون و سایر بررسی‌های آزماشگاهی، عکس‌برداری با اشعه ایکس، و آزمون‌های عملکرد ریه باشند.

۲. درمان با هدف کاهش علایم، کند کردن پیشرفت بیماری و جلوگیری از بروز عوارض صورت می‌گیرد.

۳. نوعی درمان جدید برای درمان آمفیزم ناشی از کمبود ارثی آلفا ـ 1 ـ آنتی‌تریپسین بسیار نویدبخش است.

۴. سیگار را ترك کنید. سیگار باعث پیشرفت بیماری می‌شود حتی اگر درمان صورت گیرد.

۵. از استنشاق آلاینده‌های تنفسی خودداری کنید.

۶. اگر در جایی کار می‌کنید که آلودگی هوا زیاد است، با اقدامات مختلف سعی کنید از قرار گرفتن در معرض آلودگی اجتناب کنید. در صورت لزوم، شغل خود را عوض کنید.

۷. به هنگام هشدار در مورد آلودگی هوا، در منزل بمانید.

۸. سیستم تهویه مطبوع فیلتردار با کنترل رطوبت در منزل خود نصب کنید.

۹. هر گونه آلرژی همراه آمفیزم باید درمان شود تا از بدتر شدن آمفیزم جلوگیری شود.

۱۰. از قرار گرفتن در معرض تغییرات ناگهانی دما یا رطوبت، حرف زدن با صدای بلند، خندیدن، گریه کردن، یا فعالیت بدنی شدید، در صورتی که باعث بروز حمله‌های سرفه شوند، خودداری کنید.

۱۱. از رفتن به ارتفاعات که هوا در آنجا رقیق است خودداری کنید.

۱۲. دندان‌های خود را مرتب مسواك کنید و نخ دندان بکشید تا احتمال بروز عفونت در دهان کم شود.

۱۳. انتهای تخت خود را حدود 12-10 سانتی‌متر بالا بیاورید. این کار کمك می‌کند تا ترشحات مخاطی در قسمت‌های تحتانی ریه جمع نشوند.

۱۴. از افرادی که سرفه می‌کنند یا سرماخوردگی دارند دوری کنید.

۱۵. ندرتاً ممکن است انجام پیوند ریه مدنظر قرار گیرد.

ـ داروها:

۱. آنتی‌بیوتیك برای مبارزه یا پیشگیری از عفونت‌های ثانویه

۲. داروهای گشاد کننده نایژه برای رفع اسپاسم لوله‌های نایژه‌ای

۳. واکسن انفلوآنزا و واکسن ذات‌الریه

۴. اکسیژن در مراحل انتهایی

ـ فعالیت:

فعالیت محدود خواهد شد، اما تا حدی که قدرتتان اجازه می‌دهد فعالیت خود را حفظ کنید. عدم فعالیت به مدت طولانی موجب بیشتر شدن ناتوانی خواهد شد.

ـ رژیم غذائی:

روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشید. این کار باعث رقیق شدن ترشحات ریوی، و آسان‌تر شدن تخلیه آنها با سرفه می‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آمفیزم را دارید.

۲. تب

۳. وجود خون در خلط

۴. افزایش تنگی نفس، یا تنگی نفس بدون سرفه یا به هنگام استراحت

۵. درد قفسه سینه

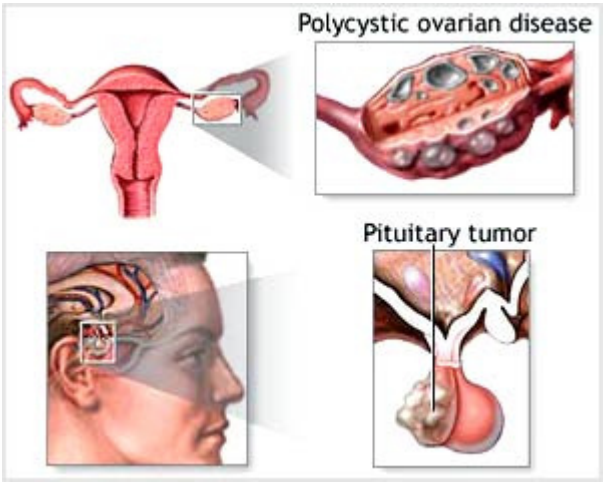
۶. زیاد شدن، غلیظ شدن، یا تغییر رنگ خلط، علی‌رغم درمان

http://vista.ir/?view=item&id=124136

vista.ir
Online Classified Service

آمنوره (قطع قاعدگی) ثانویه - amenorrhea secondary

آمنوره (قطع قاعدگی) ثانویه عبارت است از توقف قاعدگی برای حداقل 3 ماه در خانمی که قبلاً قاعده می‌شده است.



ـ علایم شایع:

از بین رفتن دوره قاعدگی برای حداقل 3 ماه یا بیشتر در خانمی که حداقل یك بار قاعدگی داشته است.

ـ علل بیماری:

۱. بارداری (اگر نزدیکی رخ داده است)

۲. شیردهی به کودك شیرخوار

۳. قطع مصرف قرص‌های ضدبارداری

۴. یائسگی (در صورتی که سن بیش از 35 سال و بارداری وجود نداشته باشد)

۵. استرس عاطفی یا اختلال روانی

۶. جراحی و برداشتن تخمدان‌ها و رحم

۷. اختلال غدد درون‌ریز، از جمله هیپوفیز، هیپوتالاموس، تیرویید، پاراتیرویید، غدد فوق کلیوی، و تخمدان‌ها

۸. دیابت شیرین (مرض قند)

۹. بیماری سل

۱۰. چاقی، بی‌اشتهایی عصبی، یا پرخوری عصبی

۱۱. فعالیت جسمانی شدید مثل دوهای استقامت

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. استرس

۲. تغذیه نامناسب

۳. ورزش شدید

۴. استفاده از بعضی داروها مثل مخدرها، فنوتیازین‌ها (از داروهای ضد روان‌پریشی)، رزرپین، یا هورمون‌ها

ـ پیشگیری:

۱. اگر علت قطع قاعدگی مشخص نیست، هیچ‌گونه روش خاصی برای پیشگیری وجود ندارد.

۲. تغذیه باید خوب باشد و باید سعی شود وزن در حد مناسب نگهداری شود.

۳. اگر قطع قاعدگی به علت یك بیماری زمینه‌ساز مثل بیماری سل، دیابت، یا بی‌اشتهایی عصبی رخ داده است، باید این بیماری زمینه‌ساز درمان شود.

ـ عواقب مورد انتظار:

۱. اگر آمنوره ناشی از بارداری یا شیردهی باشد، قاعدگی بعد از اتمام آنها باز خواهد گشت.

۲. اگر ناشی از قطع قرص‌های ضدبارداری باشد، قاعدگی بعد از 2 ماه تا 2 سال باید باز گردد.

۳. اگر ناشی از یائسگی باشد، قاعدگی‌ها مرتباً کاهش یافته و شاید دیگر هیچگاه برنگردد. برداشتن رحم نیز باعث قطع قاعدگی به طور دایمی خواهد شد.

۴. اگر غدد درون‌ریز دچار اختلال شده باشند، با تجویز هورمون کاهش یافته معمولاً باعث بازگشت قاعدگی خواهد شد.

۵. اگر قطع قاعدگی ناشی از بیماری‌هایی چون بی‌اشتهایی یا پرخوری عصبی باشد، درمان موفقیت‌آمیز این بیماری‌ها برای بازگشت قاعدگی ضروری است.

۶. اگر قطع قاعدگی ناشی از دیابت یا بیماری سل باشد، امکان دارد قاعدگی هرگز باز نگردد.

۷. اگر قطع قاعدگی ناشی از فعالیت جسمانی شدید باشد، با کاهش فعالیت، قاعدگی باز خواهد گشت.

ـ عوارض احتمالی:

۱. در صورتی که هیچ‌گونه علت جدی زمینه‌ساز پیدا نشود، هیچ عارضه‌ای رخ نخواهد داد.

۲. امکان دارد توانایی بچه‌دار شد مختل شود.

۳. امکان دارد بعضی از علایم کمبود استروژن، مثل گُرگرفتگی و خشکی مجرای تناسلی بروز کنند.

ـ درمان:

۱. برای کمك به تشخیص، معمولاً آزمایشاتی چون آزمایش بارداری، اندازه‌گیری هورمون‌ها در خون، و پاپ اسمیر، ضروری هستند.

۲. امکان دارد کارهای تشخیصی‌ای که نیاز به جراحی دارند، مثل لاپاروسکپی یا هیستروسکوپی، نیز توصیه شوند.

۳. ممکن است با عمل جراحی، دهانه رحم گشادشده و با کورت دیواره داخلی رحم کورت کشیده می‌شود.

۴. درمان بیماری زمینه‌ساز در صورت وجود

۵. روان درمانی یا مشاوره در صورتی که قطع قاعدگی ناشی از استرس باشد.

۶. زمان‌های قاعدگی خود را یادداشت نمایید تا اگر قاعدگی مجدداً قطع شد، زودتر تشخیص داده شود.

ـ داروها:

از پروژسترون و یا استروژن می‌توان جهت درمان و نیز تشخیص استفاده نمود. جنبه تشخیصی درمان پروژسترون این گونه است که پروژسترون قطع شود و خونریزی قاعدگی رخ دهد، معلوم می‌شود که دستگاه تناسلی فعال است. امکان دارد برای درمان بیماری زمینه‌ساز از داروهای دیگر نیز استفاده شود.

ـ فعالیت:

هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد.

ـ رژیم غذائی:

معمولاً رژیم خاصی توصیه نمی‌شود. اگر اضافه وزن یا کاهش وزن وجود دارد، تغییر رژیم غذایی برای تصحیح مشکل توصیه می‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آمنوره را دارید.

۲. اگر قاعدگی، علی‌رغم درمان، تا 6 ماه باز نگردد.

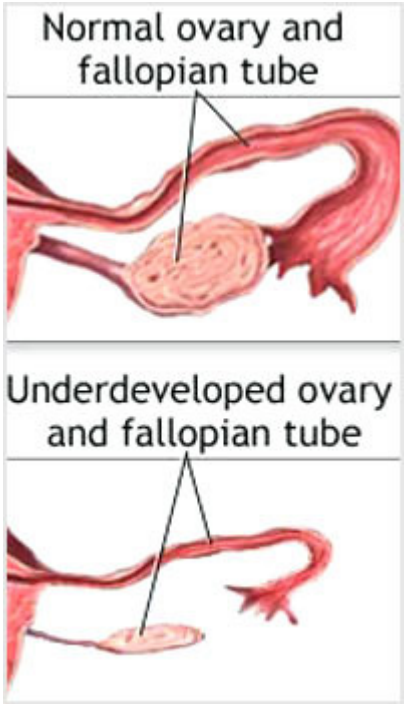
۳. اگر دچار علایم جدید و نامنتظره بروز کنند. هورمون‌های مورد استفاده در درمان ممکن است باعث عوارض جانبی شوند.

http://vista.ir/?view=item&id=124137

vista.ir
Online Classified Service

آمنوره اولیه - amenorrhea primary

آمنوره اولیه عبارت است از فقدان کامل عادت ماهانه در یك دختر جوان حداقل 16 ساله ظاهراً طبیعی، یا 14 ساله که رشد طبیعی نداشته است یا خصوصیات ثانویه جنسی در وی به وجود نیامده‌اند. این اختلال نادر است زیرا بیش از 95% از دختران اولین قاعدگی خود را تا 15 سالگی تجربه می‌کنند.



ـ علایم شایع:

فقدان‌عادت ماهانه پس از بلوغ. عادت ماهانه اکثر دختران تا سن 14 سالگی آغاز می‌شود و سن متوسط شروع عادت ماهانه 12 سال و 8 ماه است.

ـ علل بیماری:

۱. به تأخیر افتادن بلوغ

۲. بسته بودن کامل پرده بکارت که به این ترتیب مانع خروج خونریزی عادت ماهانه می‌شود.

۳. اختلالات دستگاه غدد درون‌ریز (تومورها، عفونت‌ها، یا سایر مشکلات)

۴. اختلالات کروموزمی

۵. بیماری عمومی در بدن

۶. ندرتاً، مشکلات تغذیه‌ای شدید مثل بی‌اشتهایی روانی، یا فعالیت بدنی شدید مثلاً در ورزشکاران زن حرفه‌ای

۷. ناهنجاری‌های مادرزادی مثل فقدان اعضای تناسلی (مجرا تناسلی، رحم، یا تخمدان‌ها) یا غیرطبیعی بودن ساختمان آنها

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. استرس

۲. ورزش شدید

۳. سابقه خانوادگی آغاز دیرهنگام عادت ماهانه

۴. رژیم لاغری یا کاهش وزن شدید

۵. استفاده از داروهایی مثل قرص‌های ضدحاملگی، داروهای ضدسرطان، بار بیتورات‌ها، مخدرها، داروهای کورتیزونی، کلردیازپوکساید و رزرپین.

ـ پیشگیری:

۱. از هیچ دارویی سرخود استفاده نکنید مگر با تجویز پزشك

۲. فعالیت‌های حرفه‌ای ورزشی را در صورت توصیه تا حدی کم کنید.

۳. در صورت وجود هرگونه بیماری زمینه‌ساز، برای درمان به پزشك مراجعه کنید.

۴. تغذیه مناسب و نگهداری وزن در حد ایده‌آل

ـ عواقب مورد انتظار:

فقدان عادت ماهانه به خودی خود یك خطر برای سلامتی محسوب نمی‌شود، اما علت آن باید معلوم شود. اگر عامل آن یك کیست یا تومور تخمدان باشد، باید جراحی انجام شود. آمنوره معمولاً با هورمون درمانی یا رفع علت زمینه‌ساز قابل معالجه است. درمان ممکن است تا سن 18 سالگی به تعویق انداخته شود مگر این که بتوان علت را مشخص کرد و بدون خطر درمان نمود. عللی که گاهی نمی‌توان آنها را درمان نمود عبارتند از اختلالات کروموزومی و ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی.

ـ عوارض احتمالی:

۱. پریشانی روانی در رابطه با تکامل جنسی

۲. ناتوانی در حامله شدن

۳. در موارد نادر مشکلات غدد درون‌ریز، ممکن است علاوه بر هورمون درمانی نیاز به جراحی وجود داشته باشد.

ـ درمان:

۱. اقدامات تشخیصی ممکن است شامل موارد زیر باشد: شرح حال پزشکی و شخصی و معاینه کامل؛ اندازه‌گیری هورمون‌های خون به علاوه بررسی کار تیرویید و غدد فوق‌کلیوی

۲. درمان معمولاً شامل هورمون درمانی جایگزین می‌شود. درمان آمنوره‌ای که ربطی به کمبود هورمون ندارد بسته به علت آن انجام می‌گیرد.

۳. روان درمانی یا مشاوره، در صورتی که آمنوره در اثر استرس یا مشکلات تغذیه‌ای شدید به وجود آمده باشد.

۴. در صورت لزوم، یك جراحی کوچك برای ایجاد سوراخ در پرده بکارت کاملاً بسته

۵. گاهی جراحی برای تصحیح ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی

ـ داروها:

امکان دارد برای شروع خونریزی هورمون پروژسترون تجویز شود. اگر با قطع مصرف پروژسترون خونریزی آغاز شود، دستگاه تناسلی درست کار می‌کند و احتمال وجود بیماری غده هیپوفیز نیز کم است. اگر با قطع مصرف پروژسترون خونریزی آغاز نشود، امکان دارد از داروهای محرك تخمدان مثل کلومیفن یا گنادوتروپین‌ها (هورمون‌های طبیعی محرك تخمدان که از هیپوفیز ترشح می‌شوند) برای این منظور استفاده شود.

ـ فعالیت:

۱. محدودیتی برای آن وجود ندارد. مرتباً ورزش کنید ولی شدت آن نباید زیاد باشد.

۲. با رژیم‌های لاغری سخت‌گیرانه وزن خود را به سرعت پایین بیاورید.

۳. اگر اضافه وزن دارید یا زیادی لاغر هستید، در رابطه با رژیم غذایی مناسب با پزشکتان یا متخصص تغذیه مشورت کنید. سعی نکنید

ـ رژیم غذائی:

۱. روزانه سه وعده غذایی متعادل مصرف کنید.

۲. در صورتی که بسیار لاغر یا چاق هستید، در مورد رژیم غذایی با پزشك مشورت کنید. با رژیم‌های سرخود سعی نکنید وزن خود را کاهش دهید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما 16 سالتان شده است اما هرگز عادت ماهانه نداشته‌اید.

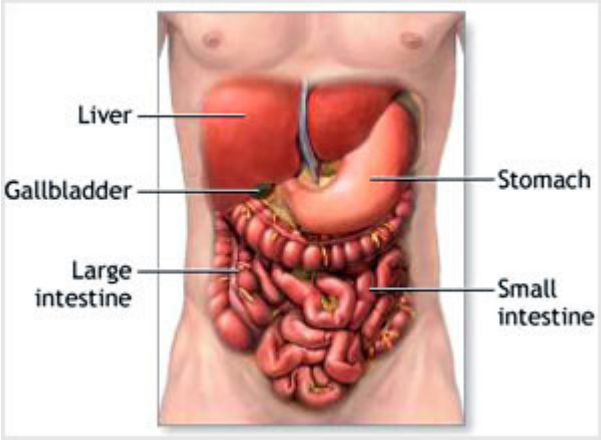
۲. اگر علی‌رغم درمان، عادت ماهانه در عرض 6 ماه آغاز نشود.

http://vista.ir/?view=item&id=124138

vista.ir
Online Classified Service

آمیبیاز (اسهال خونی آمیبی) - amebiasis

آمیبیاز (اسهال خونی آمیبی) عبارت است از یك عفونت انگلی روده بزرگ و گاهی کبد. اسهال آمیبی در تمام دنیا وجود دارد اما در کشورهای در حال توسعه شایع‌تر است.



بسیاری از افراد، خصوصاً کسانی که در آب و هوای معتدل زندگی می‌کنند، این انگل را دارند بدون این که علامتی داشته باشند. علایم وقتی ظاهر می‌شوند که انگل بافت روده بزرگ را مورد تهاجم قرار دهد. علایم ممکن است خیلی مبهم باشند.

ـ علایم شایع:

۱. تب

۲. خستگی

۳. لرز شدید

۴. کاهش وزن

۵. گاز و نفخ شکم

۶. دل پیچه و حساسیت شکم به لمس

۷. گاهی مخاط و خون در اجابت مزاج

۸. دردهای عضلانی اگر کبد گرفتار شده باشد

۹. درد در ناحیه کبد و سمت راست شکم

۱۰. گاهی زرد شدن چشم‌ها و پوست

۱۱. گاهی هیچ علامتی وجود ندارد.

۱۲. اسهال متناوب همراه با اجابت مزاج بد بو. در مراحل اولیه، غالباً قبل از اسهال یبوست وجود دارد.

ـ علل بیماری:

یك انگل میکروسکپی به نام آنتاموبا هیستولیتیکا ، که توسط پشه، سوسك حمام، و تماس مستقیم با دستمال یا غذای آلوده به مدفوع انتقال می‌یابد. شایع‌ترین منابع عفونت عبارتند از: آلودگی در افرادی که با غذا سروکار دارند. معیوب بودن لوله‌کشی هتل یا کارخانه. سبزیجات یا میوه‌های خامی که با کود انسانی پرورش یافته‌اند یا در آب آلوده شسته شده‌اند.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. محیط زندگی شلوغ و غیربهداشتی

۲. مسافرت به مناطق با زیرساخت‌های بهداشتی نامطلوب

۳. زندگی در مؤسسات نگهداری مختلف مثل خانه سالمندان و غیره

ـ پیشگیری:

دستان خود را به طور مرتب بشویید، خصوصاً قبل از غذا خوردن اگر در منطقه‌ای هستید که غذا و آب ممکن است در آنجا آلوده باشد، اقدامات زیر ضروری هستند: آب آشامیدنی را 5 دقیقه بجوشانید. برای مسواك کردن و شستن دندان‌ها از آب شیر استفاده نکنید و مراقب باشید هنگام حمام کردن آب قورت ندهید. از خوردن میوه با پوست یا سبزیجات، ماهی یا صدف خام، یا هرگونه محصول لبنی مشکوك (بستنی، شیر، کره و غیر) خودداری کنید.

ـ عواقب مورد انتظار:

در اکثر موارد بدن عارضه، اسهال آمیبی در عرض 3 هفته با درمان خوب می‌شود. در مواردی که فرد به صورت حامل بیماری در آمده است، هیچ علامتی ممکن است وجود نداشته باشد. در موارد شدید، امکان دارد اسهال خونی شدید بروز کند که نیاز به درمان در بیمارستان وجود دارد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. آبسه ریه

۲. آبسه مغز

۳. هپاتیت یا آبسه کبد

۴. عفونت پرده دور قلب

۵. پریتونیت (التهاب پرده صفاق که سطح حفره شکم را می‌پوشاند).

ـ درمان:

اقدامات تشخیصی ممکن است عبارت باشند از آزمایش مدفوع و خون؛ سی‌تی اسکن در موارد شك به گرفتاری کبد و در صورت لزوم، نمونه‌برداری. در مورد بهداشت شخصی بسیار مراقب باشید. مرتب حمام کنید و پس از اجابت مزاج و قبل از دست زدن به غذا یا مواد غذایی دستان خود را با آب گرم و صابون بشویید. در مواردی که آبسه کبد وجود دارد، جراحی ممکن است ضروری باشد.

ـ داروها:

۱. امکان دارد مترونیدازول یا یدوکینول (یا هر دو)، پاروموماپسین، یا دیلوکسانید تجویز شوند.

۲. امکان دارد جایگزینی مایعات از دست رفته برای درمان اختلال آب و الکترولیت به وجود آمده در اثر اسهال ضروری باشد.

ـ فعالیت:

به هنگام حمله حاد اسهال در رختخواب استراحت کنید. فعالیت‌های عادی خود را وقتی آغاز کنید که تب رفع شود و اسهال رو به بهبود گذارد.

ـ رژیم غذائی:

رژیم غذایی شامل غذاهای نرم و تدریجاً از سر گرفتن رژیم غذایی عادی.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

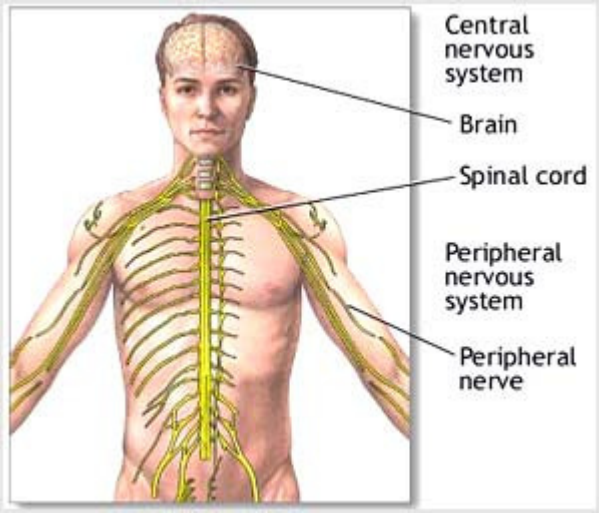
۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم اسهال آمیبی را دارید.

۲. اگر یکی از موارد زیر هنگام درمان رخ دهد: دل‌پیچه بیش از 24 ساعت طول بکشد. اسهال یا خون در اجابت مزاج بیشتر شود. استفراغ آغاز شود. درد در ناحیه کبد آغاز شود یا زردی به وجود آید (زردی پوست یا چشم‌ها)، بثور پوستی ظاهر شود. تحریك‌پذیری یا سردرد شدید رخ دهد.

http://vista.ir/?view=item&id=124139

آميوتروفيك لاترال اسكلروز - amyotrophic lateral sclerosis

آميوتروفيك لاترال اسكلروز (ALS) عبارت است از تخريب پيش رونده سلول‌های طناب نخاعی، كه منجر به از دست رفتن تدريجی عملكرد عضلات می‌شود. اين بيماری مسری يا سرطانی نيست.



علايم اين بيماری ممكن است با علايمی كه در اثر بيماری لايم در دستگاه عصبی بروز می‌كند اشتباه شوند. در بيماری ALS ، دستگاه عصبی مركزی و عضلات، به خصوص عضلات دست، ساعد، پا، سر و گردن درگير می‌شوند.

ـ علايم شايع:

۱. گرفتگی عضله

۲. كاهش وزن بدون توجيه

۳. حملات ناگهانی خنده يا گريه

۴. خورده خورده و نامفهوم صحبت كردن

۵. سفتی و انعطاف‌ناپذيری گروه‌های عضلانی

۶. معمولاً توانايی‌های ذهنی مشكلی پيدا نمی‌كنند

۷. پرش و ضعف عضلات، كه از دست‌ها شروع شده، به بازوها و پاها گسترش می‌يابد. نهايتاً عضلات مسؤول تنفس و بلع نيز درگير شده، دچار ضعف می‌شوند.

ـ علل بيماری:

علت دقيق آن نامشخص است.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سن بالای 40 سال

۲. سابقه خانوادگی ALS

۳. بروز این بیماری در بین افرادی که شغلشان مستلزم فعالیت بدنی شدید است بیشتر گزارش شده است.

ـ پیشگیری:

در حال حاضر نمی‌توان از این بیماری پیشگیری کرد.

ـ عواقب مورد انتظار:

در حال حاضر این بیماری علاج‌ناپذیر است. بیماران معمولاً در عرض 5-2 سال فوت می‌کنند، اما 20% از آنها تا 5 و 10% از آنها تا 10 سال زنده می‌مانند.

تحقیقات علمی در زمینه علل و درمان این بیماری در حال انجام هستند، بنابراین امید می‌رود که روش‌های درمانی مؤثرتری یافت شوند و نهایتاً علاج آن میسر گردد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. لریه ناشی از مشکل در بلع و جمع‌شدن ترشحات در راه‌های هوایی

۲. عدم توانایی حرکت ناشی از بیماری باعث بروز زخم‌های ناشی از فشارآمدن طولانی‌مدت روی نقاط خاص می‌شود.

۳. زوال رفتن پیش‌رونده قوای جسمانی فرد بر جنبه‌های مختلف زندگی وی از جمله روابط، کار، درآمد، هماهنگی عضلانی و مسایل جنسی تأثیر منفی می‌گذارد.

ـ درمان:

۱. روان درمانی یا مشاوره برای یادگیری روش‌های مقابله با ناتوانی و معلولیت

۲. بیمار باید تکنیك مکش و بیرون آوردن ترشحات جمع شده در ریه خود را یاد بگیرد.

۳. برای پیشگیری از زخم‌های فشاری، باید مراقبت پرستاری در حد مناسب انجام گیرد.

۴. نهایتاً بستری شدن در بیمارستان یا مراکز نگهداری از بیماران دچار بیماری‌های مزمن

۵. هیچ درمان اختصاصی وجود ندارد. برای کنترل علایم و اورژانس‌های عارض شده، بیمار تحت مراقبت حمایتی قرار می‌گیرد.

۶. تشخیص شامل آزمون الکترمیوگرافی (نوار عضله) است. این آزمایش برای ارزیابی انتقال پیام‌های عصبی به عضله انجام می‌گیرد.

ـ داروها:

۱. هیچ دارویی برای درمان ALS وجود ندارد.

۲. آنتی‌بیوتیك برای مبارزه با عفونت در صورت بروز ذات‌الریه

۳. از داروهای ضدافسردگی شاید بتوان برای کاهش تولید بزاق استفاده نمود.

۴. داروی باکلوفن ممکن است به کاهش سفتی و انعطاف‌پذیری عضلات کمك کند.

ـ فعالیت:

تا حدی که امکان دارد بیمار باید فعالیت خود را حفظ کند. ضعف عضلانی تدریجاً توانایی جسمانی فرد را کاهش می‌دهد. با استفاده از یك برنامه مخصوص بازتوانی می‌توان استقلال فرد را به مدت بیشتری حفظ نمود. باید وسایلی تهیه شوند تا فرد را در حرکت کمك کنند، مثلاً واکِر یا صندلی چرخدار.

ـ رژیم غذائی:

اگر مشکل در بلع وجود دارد، باید غذاهای نرم و راحت‌الحلقوم خورده شوند. نهایتاً ممکن است نیاز به دادن غذا از راه لوله وجود داشته باشد.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آمیوتروفیك لاترال اسکلروز (ALS) را دارید.

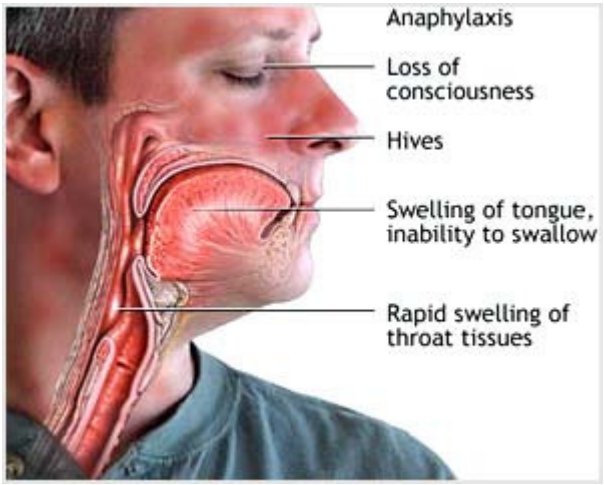
۲. اگر پس از تشخیص و اقدامات لازم، دچار سرفه، تنگی نفس، یا تب شده‌اید.

http://vista.ir/?view=item&id=124140

vista.ir
Online Classified Service

آنافیلاکسی (شوك آلرژیك) - anaphylaxis

آنافیلاکسی (شوك آلرژیك) عبارت است از یك پاسخ آلرژیك شدید به داروها و بسیاری از مواد آلرژی‌زای دیگر که زندگی فرد را به خطر می‌اندازد. آن دسته از واکنش‌های آلرژیکی که تقریباً بلافاصله رخ می‌دهند معمولاً شدیدترین هستند.



ـ علایم شایع:

۱. عطسه

۲. غش

۳. تپش قلب

۴. اشك ریزش

۵. سرفه یا خس‌خس

۶. احساس اضطراب

۷. تورم صورت و دست‌ها

۸. نبض ضعیف و سریع

۹. از دست دادن هوشیاری

۱۰. تورم یا خارش در دهان یا گلو

۱۱. دل پیچه در ناحیه معده، استفراغ، و اسهال

۱۲. خارش در تمام بدن و اغلب همراه با کهیر

۱۳. حالت سوزن سوزن شدن یا کرختی اطراف دهان

۱۴. احساس گرفتگی در سینه؛ مشکل در نفس کشیدن

ـ علل بیماری:

خوردن یا تزریق ماده‌ای که به آن حساس هستید. پاسخ آلرژیکی که برای خنثی کردن یا خلاص شدن از شر این ماده از سوی بدن داده می‌شود خود منجر به بروز یك نوع واکنش بسیار بیش از حد عادی شده که گاهی زندگی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. آن چیزهایی که بیشتر باعث بروز این گونه واکنش می‌شوند عبارتند از:

۱. ورزش

۲. واکسن‌ها

۳. گرده گیاهان

۴. موادی که در بعضی از انواع عکس‌برداری تزریق می‌شوند.

۵. غذاها، به خصوص تخم‌مرغ، باقلا، لوبیا، غذاهای دریایی، و میوه‌ها

۶. گزش یا نیش حشرات مثل انواع زنبور، مورچه‌های گزنده، و برخی عنکبوت‌ها

۷. انواع داروها، به خصوص پنی‌سیلین. تزریق دارو با خطر بیشتری همراه است تا قرص و کپسول یا قطره

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سابقه اگزما، تب یونجه، یا آسم

۲. سابقه آلرژی خفیف به چیزهایی که در بالا ذکر شد.

ـ پیشگیری:

۱. اگر به گزش حشرات آلرژی دارید، به هنگام بیرون رفتن لباس‌های محافظتی بپوشید.

۲. همیشه یك دست‌بند یا گردن آویز مخصوص داشته باشید که روی آن آلرژی شما مشخص باشد.

۳. همیشه پس از تزریق هرگونه دارو، تا 15 دقیقه در مطب پزشك بمانید. هرگونه علامت آلرژی را فوراً اطلاع دهید.

۴. پیش از پذیرفتن هرگونه دارو، مطلب را به پزشك یا دندانپزشك گوشزد کنید. پیش از اینکه تزریقی برای شما انجام شود، از ماهیت آن مطلع شوید.

۵. همیشه و در همه جا یك کیت آنافیلاکسی به همراه داشته باشید. مطمئن شوید که خانواده‌تان طریقه استفاده از کیت را بلدند تا وقتی واکنش در شما بروز کرد بتوانند از آن استفاده کنند.

۶. یکی از روش‌هایی را که می‌توانید مدنظر قرار دهید عبارت است از تزریق ماده‌ای که به آن حساسیت دارید به روشی مخصوص و تدریجی به طوری که حساسیت شما به تدریج برطرف شود (نام دیگر این روش حساسیت‌زدایی است).

ـ عواقب مورد انتظار:

با درمان فوری و به موقع، کاملاً بهبود می‌یابید.

ـ عوارض احتمالی:

در صورت عدم درمان فوری و به موقع، امکان دارد آنافیلاکسی منجر به شوك، ایست قلبی، و مرگ شود.

ـ درمان:

اگر علایم آنافیلاکسی را در فردی مشاهده کردید و دیدید که تنفس وی متوقف شد: ـ اورژانس را خبر کنید یا به فرد دیگری بگویید این کار را انجام دهد. (اگر این اتفاق برای یك کودك افتاده است، قبل از خبر کردن اورژانس، اقدامات احیا را به مدت یك دقیقه انجام دهید.) ـ فوراً تنفس دهان به دهان را آغاز کنید. ـ اگر قلب ضربان ندارد، ماساژ قلبی بدهید. ـ تا زمانی که کمك نرسیده است، عملیات احیا را ادامه دهید.

هر گاه دارویی را مصرف می‌کنید، نسبت به امکان بروز واکنش آلرژیك هوشیار باشید و آمادگی این را داشته باشید که به محض بروز علایم اقدامات لازم را انجام دهید. اگر قبلاً دچار واکنش آلرژیك شدید شده‌اید، همیشه کیت آنافیلاکسی همراه داشته باشید. درمان طولانی مدت مستلزم حساسیت‌زدایی است.

ـ داروها:

۱. تزریق اپی‌نفرین (آدرنالین) تنها درمان فوری مؤثر است.

۲. داروهایی مثل آمینوفیلین، کورتیزون، یا آنتی‌هیستامین‌ها، که پس از آدرنالین تزریق می‌شوند، جلوی بازگشت علایم حاد را می‌گیرند.

ـ فعالیت:

به محض بهبود علایم حمله، فعالیت‌های عادی خود را از سر بگیرید. اما اگر علایم دوباره برگشتند، باید 24 ساعت تحت‌نظر باشید.

ـ رژیم غذائی:

از خوردن غذاهایی که به آنها آلرژی دارید خودداری کنید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

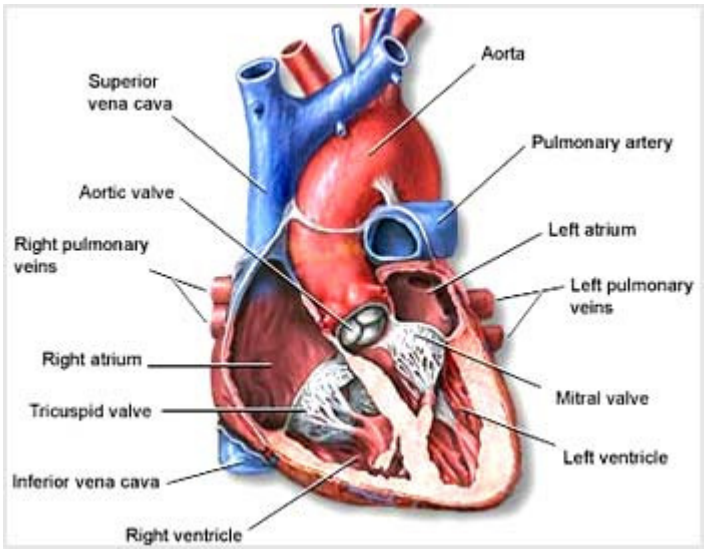
۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آنافیلاکسی را بروز داده‌اید. این یك اورژانس است! فوراً درخواست کمك اورژانس نمایید.

۲. اگر دچارعلایم جدید و نامنتظره بروز کرده‌اند. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

vista.ir
Online Classified Service

آندوکاردیت - endocarditis

آندوکاردیت عبارت است از یك عفونت غیر مسری که عضله قلب، دریچه‌های قلب، و آندوکاردیوم (پوشش داخلی حفرات یا دریچه‌های قلب) را درگیر می‌سازد.



ـ علایم شایع:

۱. کاهش وزن

۲. دردهای مبهم

۳. خستگی و ضعف

۴. تورم پاها و شکم

۵. لرز شدید و تب بالا

۶. تند یا نامنظم شدن ضربان قلب

۷. تب، لرز و تعریق زیاد، خصوصاً در شب

۸. وجود صدای غیر طبیعی در قلب علایم

۹. تنگی نفس در هنگام فعالیت

ـ علل بیماری:

باکتری‌ها یا قارچهایی که وارد خون می‌شوند و دریچه‌ها و پوشش داخلی قلب را در کسانی که قبلاً آسیب قلبی (به قسمت عوامل خطر در زیر مراجعه کنید) داشته‌اند عفونی می‌کنند. باکتری‌ها یا قارچها به دریچه‌ها، عضله، و پوشش داخلی قلب آسیب وارد می‌آورند یا آسیبی که از قبل وجود داشته است را تشدید می‌کنند.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. تب رماتیسمی

۲. بیماری مادرزادی قلب

۳. پس از وارد آمدن آسیب به دریچه‌های قلب، خطر آندوکاردیت در اثر عوامل زیر بیشتر می‌شود: حاملگی، تزریق مواد آلوده به داخل جریان خون، مثلاً همراه با تزریق وریدی مواد مخدر، سوء در مصرف الکل، استفاده از داروهای سرکوب‌کننده ایمنی، وجود دریچه مصنوعی در قلب.

ـ پیشگیری:

گر دریچه قلبتان آسیب دیده است یا صدای غیر طبیعی در قلب شما شنیده می‌شود: پیش از انجام هر گونه اقدام پزشکی که امکان ورود باکتری‌ها به خون در طی آن وجود دارد به پزشك یا دندانپزشك اطلاع دهید و آنتی‌بیوتیك مناسب جهت پیشگیری از بروز آندوکاردیت دریافت کنید. این مسأله به خصوص باید قبل از کارهای دندانپزشکی، زایمان، و جراحی در دستگاه ادراری یا گوارش مدنظر قرار گیرد:

۱. هیچگاه الکل ننوشید.

۲. قبل از حامله شدن، با پزشك خود مشورت کنید.

۳. مواد مخدر تزریقی مصرف نکنید.

ـ عواقب مورد انتظار:

معمولاً با تشخیص و درمان زودهنگام قابل معالجه است، امابهبود ممکن است هفته‌ها طول بکشد. اگر درمان به تأخیر افتد، عملکرد قلب کاهش یافته و نارسایی احتقانی قلب و مرگ رخ خواهد داد.

ـ عوارض احتمالی:

تشکیل لخته‌های خونی که ممکن است به مغز، کلیه‌ها، یا احشای شکمی بروند و باعث بروز عفونت، آبسه، یا سکته مغزی شوند. اختلالات ریتم قلب (شایعترین آن فیبریلاسیون دهلیزی است).

ـ درمان:

۱. جراحی برای تعویض دریچه عفونی شده در بعضی از بیماران

۲. پس از رهایی از آندوکاریت، مرتب زیر نظر پزشك باشید تا از عود بیماری پیشگیری شود.

۳. هدف درمان، ریشه‌کنی میکروب‌ها با دارو، و فراهم آوردن مراقبت‌های حمایتی برای رفع علایم است.

۴. اقدامات تشخیصی ممکن است عبارت باشند از: شمارش سلول‌های خون و کشت خون، نوار قلب، عکس‌برداری از قلب و ریه‌ها با اشعه ایکس، و اکوکاردیوگرام

۵. بستری شدن در بیمارستان در مرحله حاد بیماری. زمانی که وضعیت بیمار با ثبات شد، بعضی از بیماران را می‌توان از بیمارستان ترخیص کرد و ادامه مراقبت از آنها را در منزل پی گرفت.

۶. اگر دریچه قلبتان آسیب دیده است، قبل از هر اقدام پزشکی، مشکل خود را به پزشك یا دندانپزشك اطلاع دهید. در برخی از موقعیت‌ها، نیاز به استفاده از آنتی‌بیوتیك برای پیشگیری از آندوکاردیت وجود خواهد داشت.

۷. همیشه دست‌بند یا گردن‌آویز مخصوص که نشان دهنده مشکل پزشکی شما باشد همراه داشته باشید. در کیف پول خود روی یك کارت فهرست آنتی‌بیوتیك‌های مورد نیاز برای مصرف پیش از کارهای دندانپزشکی و پزشکی را یادداشت کنید.

ـ داروها:

مصرف آنتی‌بیوتیك به مدت چندین هفته برای مبارزه با عفونت. غالباً آنتی‌بیوتیك به صورت تزریقی مصرف می‌شود.

ـ فعالیت:

تا زمان بهبودی کامل در رختخواب استراحت کنید. زمانی که در رختخواب استراحت می‌کنید، پاهای خود را مرتب خم و راست کنید تا از تشکیل لخته در سیاهرگ‌های عمقی پا پیشگیری شود.فعالیت‌های عادی خود را در صورتی که وضعیت جسمی‌تان اجازه دهد از سر بگیرید.

ـ رژیم غذائی:

رژیم خاصی توصیه نمی‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. وجود خون در ادرار

۲. تنگی نفس یا درد قفسه سینه

۳. ضعف یا فلج ناگهانی در عضلات صورت، تنه، یا اندام‌ها

۴. افزایش وزن بدن بدون اینکه رژیم غذایی تغییر کرده باشد.

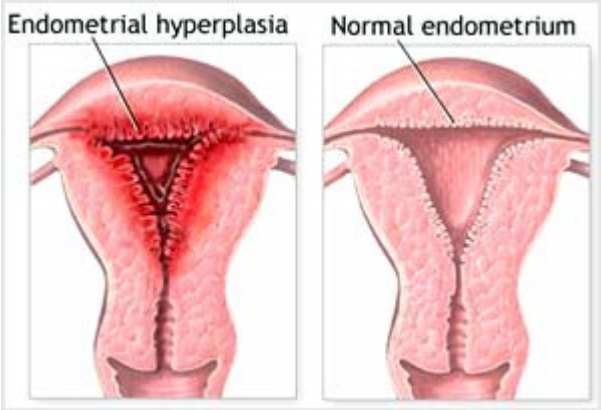
۵. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آندوکاردیت را دارید.

http://vista.ir/?view=item&id=124142

vista.ir
Online Classified Service

آندومتریوز - endometriosis

آندومتریوز عبارت است از اختلالی که در آن بافت مشابه پوشش داخلی رحم (آندومتر) در نقاطی غیرمعمول در قسمت پایینی شکم ظاهر شود. این بافت ممکن است روی سطح تخمدان؛ پشت رحم و در حفره لگنی؛ روی دیواره روده؛ و ندرتاً در نقاطی دورتر به وجود آید.



آندومتریوز به چهار مرحله محدود، خفیف، متوسط، و شدید تقسیم می‌شود که بیانگر محل قرارگیری و شدت اختلال هستند. این اختلال می‌تواند در هر سنی از بلوغ تا یائسگی رخ دهد اما در سنین 30-20 سالگی بیشتر دیده می‌شود.

ـ علایم شایع:

۱. نازایی

۲. لکه‌بینی قبل از عادت ماهانه

۳. گاهی وجود خون در ادرار یا مدفوع

۴. کمردرد؛ درد همراه با انقباضات روده‌ای

۵. درد به هنگام مقاربت جنسی

۶. درد لگنی فزاینده به هنگام عادت ماهانه، خصوصاً روزهای آخر گاهی درد لگنی ممکن است در هر زمانی رخ دهد.

ـ علل بیماری:

ناشناخته هستند، اما پزشکان نظریه زیر را بیشتر از بقیه قبول دارند؛ معمولاً در هنگام تخمک‌گذاری، پوشش داخلی رحم (آندومتر) ضخیم شده تا آماده کاشته شدن تخم لقاح یافته باشد. اگر این اتفاق نیافتد، بافت پوشش داخلی رحم کنده شده و در خونریزی عادت ماهانه از بدن خارج می‌شود و در بعضی از موارد، این بافت تخریب‌شده تجمع یافته و از راه لوله‌های رحمی به درون حفره لگن می‌روند. بافت در اینجا آزادانه غوطه‌ور می‌شود و خود را به سایر بافت‌ها می‌چسباند و در هر ماه رشد کرده و به سایر نقاط هم گسترش می‌یابد. رشد بافت آندومتر بر روی احشای لگنی ممکن است باعث چسبیدن احشاء به یکدیگر شود و به این ترتیب درد و سایرعلایم ظاهر خواهند شد.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سابقه خانوادگی آندومتریوز

۲. خانم‌هایی که حامله نمی‌شوند یا حاملگی را به تعویق می‌اندازند.

۳. تنگ یا بسته شدن گردن رحم (مسیر خروجی بافت تخریبی و خون)

ـ پیشگیری:

اقدام خاصی برای پیشگیری نمی‌توان انجام داد. تنها می‌توان با تشخیص زودهنگام و درمان مناسب از گسترش آندومتریوز جلوگیری کرد.

ـ عواقب مورد انتظار:

۱. در خانم‌هایی که شدت بیماری در آنها زیاد است، موفقیت درمان کمتر است.

۲. علایم را می‌توان با دارو تخفیف داد و گاهی این بیماری با جراحی قابل معالجه است.

۳. بدون درمان، آندومتریوز تدریجاً شدید می‌شود. اما پس از یائسگی، به علت کاهش تولید استروژن، تدریجاً پسرفت می‌کند.

ـ عوارض احتمالی:

۱. چسبندگی احشای لگنی

۲. عود آندومتریوز پس از جراحی

۳. مشکلات ادراری و اجابت مزاج

۴. درد ناتوان‌کننده اما این درد هیچگاه نشانه‌ای از تهدید زندگی نیست.

۵. نازایی به علت کاشته شدن بافت در لوله‌های رحمی و تنگ شدن آنها

۶. وجود بافت کاشته شده روی تخمدان می‌تواند باعث ایجاد کیست‌های بزرگ و توده‌های لگنی به نام آندومتریوما شود.

ـ درمان:

امکان دارد تشخیص این اختلال دشوار و نیازمند معاینات مکرر یا اقدامات جراحی تشخیصی مثل لاپاروسکوپی باشد. در لاپاروسکوپی، با ایجاد منفذی از روی شکم، وسیله‌ای باریك که نوك آن منبع نور قرار دارد به درون حفره شکم فرستاده شده و احشای شکمی و لگنی بررسی می‌شوند. عکس‌برداری از قسمت پایینی روده‌ها با اشعه ایکس (همراه با تنقیه باریم برای بهتر دیدن روده‌ها) ممکن است در رسیدن به تشخیص کمك کننده باشد.

۱. درمان برحسب مرحله بیماری، سن بیمار، و تصمیم به بچه‌دار شدن یا نشدن متفاوت است.

۲. امکان دارد برای حذف بافت کاشته شده از جراحی با لیزر یا منعقد ساختن بافت با جریان الکتریکی استفاده شود.

۳. جراحی برای برداشتن بافت‌های کاشته شده، یا درآوردن رحم، لوله‌های رحمی و تخمدان‌ها در خانم‌هایی که دیگر نمی‌خواهند حامله شوند.

۴. به جای تامپون از نوارهای بهداشتی استفاده کنید. تامپون ممکن است احتمال جریان پس‌گرد خون و بافت تخریبی و ورود آن به حفره شکم و لگن را بیشتر کند.

۵. برای تخفیف درد از گرما استفاده کنید. یك صفحه گرمکننده یا شیشه آب داغ را روی شکم یا کمر قرار دهید، یا حمام آب گرم بگیرید تا عضلات شل شوند و ناراحتی تخفیف یابد.

۶. اگر بچه می‌خواهید، هرچه زودتر به فکر حاملگی باشید. حاملگی ممکن است بیماری را مقداری تخفیف هم بدهد. توجه داشته باشید که به تعویق انداختن حاملگی ممکن است به نازایی بیانجامد.

ـ داروها:

۱. امکان دارد داروهای ضد درد قوی‌تری تجویز شوند.

۲. می‌توان از داروهای ضد التهابی غیراستروییدی برای رفع درد خفیف استفاده کرد.

۳. داروهای رایجی که برای درمان آندومتریوز با مهار کار تخمدان تجویز می‌شوند عبارتند از قرص‌های جلوگیری از حاملگی، داروهای پروژسترونی، دانازول و هورمون آزاد کننده گنادوتروپین‌ها.

ـ فعالیت:

ورزش، حتی راه رفتن، درد را تخفیف داده و سطح استروژن را کاهش می‌دهد که این ممکن است باعث کند شدن رشد آندومتریوز شود. پس از جراحی نیاز است تا فعالیت مقداری محدود شود.

ـ رژیم غذائی:

از خوردن کافئین اجتناب کنید زیرا به نظر می‌رسد درد را در بعضی از خانم‌ها بدتر کند.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. درد غیر قابل تحمل

۲. خونریزی غیرمعمول یا زیاد

۳. اگر پس از درمان، علایم مجدداً ظاهر شوند.

۴. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آندومتریوز را دارید.

۵. اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124143

vista.ir
Online Classified Service

آنرژین صدری - angina pectoris

آنرژین صدری عبارت است از درد قفسه سینه که از قلب برخاسته باشد. درد معمولاً زیر استخوان جناغ حس می‌شود و به علت نرسیدن اکسیژن به مقدار کافی به عضله قلب روی می‌دهد. عواملی چون ورزش، هیجانات عاطفی، یا غذاهای سنگین در فردی که از قبل مشکل قبلی داشته است می‌توانند باعث برانگیخته شدن این نوع درد شوند.



اما اگر رگ‌های قلبی بیمار باشند، یا فشارخون بالا باشد، خونرسانی به عضله قلب محدود می‌شود. این درد معمولاً در مردان بالای 35 سال و خانم‌هایی که یائسگی را پشت سر گذاشته‌اند دیده می‌شود. در حالت عادی، وقتی نیاز قلب به اکسیژن زیاد می‌شود، رگ‌های خونرسان قلب می‌توانند از پس برآوردن این نیاز برآیند.

ـ علایم شایع:

۱. حالت خفگی در گردن

۲. درد در بین دو کتف

۳. درد قفسه صدری مشابه سوءهاضمه

۴. بروز ناگهانی مشکل در تنفس (گاهی)

۵. احساس سفتی، فشرده شدن، فشار، یا درد در قفسه صدری

۶. درد قفسه صدری که به آرواره، دندان‌ها، یا گوش تیر می‌کشد

۷. سنگینی، کرختی، سوزن سوزن شدن یا درد در قفسه صدری، بازو، شانه، آرنج، یا دست، معمولاً در سمت چپ

ـ علل بیماری:

۱. کم‌خونی

۲. پرکاری تیرویید

۳. بیماری دریچه قلب

۴. تندشدن ضربان قلب

۵. بیماری سرخرگ‌های قلبی، به عبارتی انسداد یا انقباض سرخرگ‌هایی که به قلب خونرسانی می‌کنند.

ـ عوارض افزایش‌دهنده خطر:

۱. سیگارکشیدن، چاقی، دیابت شیرین (مرض قند)

۲. فشارخون بالا، کلسترول بالا

۳. خوردن زیاده از حد چربی یا نمك

۴. عدم تحرك، خستگی، کار زیاد یا استرس

۵. سابقه خانوادگی بیماری سرخرگ‌های قلبی

۶. قرار گرفتن در معرض سرما یا باد

ـ پیشگیری:

۱. ترك سیگار

۲. درمان علل یا عوامل خطر زمینه‌ساز

۳. پس از مشورت با پزشك، به طور منظم ورزش کنید.

۴. خوردن غذاهای کم چرب و کم نمك. کاهش وزن در صورت اضافه وزن

۵. اجتناب از عوامل فیزیکی یا عاطفی استرس‌زا که باعث بروز حمله آنژین صدری می‌شوند.

ـ عواقب مورد انتظار:

آنژین صدری خفیف با استراحت و استفاده از نیتروگلیسیرین و سایر داروها برطرف می‌شود. برای برطرف کردن بیماری‌های زمینه‌ساز ممکن است درمان‌های دیگری ضروری باشند.

ـ عوارض احتمالی:

۱. حمله قبلی

۲. نارسایی احتقانی قلب

۳. بی‌نظمی‌های ضربان قلب که بالقوه مرگبار هستند.

ـ درمان:

هدف درمان عبارت است از کاهش نیاز قلب به اکسیژن یا افزایش اکسیژن‌رسانی به قلب. این هدف معمولاً با دارو قابل دستیابی است. اگر آنژین صدری با دارو کنترل نشد، درمان‌های دیگر عبارتند از: آنژیوپلاستی با بادکنك برای بازکردن سرخرگ‌های قلبی مسدودشده، یا جراحی بای‌پاس در حالتی که سرخرگ‌های قلبی شدیداً مسدود شده‌اند. توصیه‌هایی که در قسمت پیشگیری ذکر شد را رعایت نمایید. از موقعیت‌هایی که کار قلب را افزایش می‌دهند پرهیز کنید، مثلاً عصبانیت، هوای خیلی گرم یا سرد، ارتفاع بالا (البته به جز مسافرت با هواپیمای مسافربری)، یا فعالیت شدید بدنی به طور ناگهانی.

ـ داروها:

نیتروگلیسیرین آنژین صدری حاد را بهبود می‌بخشد، اما تأثیری بر علایم سایر بیماری‌ها ندارد. این می‌تواند در عرض چند ثانیه درد را برطرف کند. همیشه آن را برای استفاده فوری همراه داشته باشید. امکان دارد سایر داروها مورد استفاده برای بیماری سرخرگ‌های قلبی، مثل آسپیرین، بتا ـ بلوکرها، یا داروهای مسدودکننده کانال کلسیم، نیز تجویز شوند. در این صورت، رعایت دقیق دستور دارویی بسیار مهم است.

ـ فعالیت:

فعالیت خود را طوری تنظیم کنید که درد بروز نکند. البته این طور نباشد که آنژین صدری را بهانه کنید و اصلاً ورزش نکنید. باید توجه داشته باشید که انجام ورزش به صورت متعادل و منظم (با نظر پزشك) می‌تواند به کنترل علایم کمك کند.

ـ رژیم غذائی:

۱. در صورت اضافه وزن، وزن خود را کم کنید.

۲. توصیه می‌شود غذاهای کم چرب و کم نمك استفاده نمایید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر علایم آنژین صدری را دارید.

۲. حمله درد قفسه صدری، علی‌رغم استراحت و درمان با نیتروگلیسیرین، بیش از 15-10 دقیقه طول بکشد.

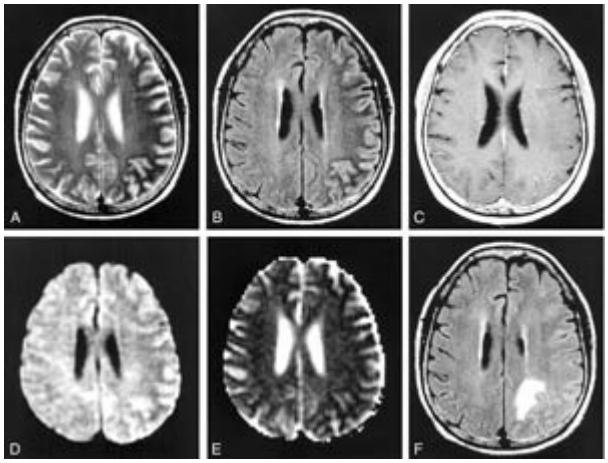
۳. با درد قفسه صدری از خواب بلند می‌شوید و درد با یك قرص نیتروگلیسیرین برطرف نمی‌شود. اگر این حملات ادامه یافتند، حتماً مراجعه کنید، حتی اگر نیتروگلیسیرین آنها را برطرف کند.

۴. حمله درد قفسه صدری متفاوت با گذشته یا شدیدتر از حد معمول است.

http://vista.ir/?view=item&id=124144

آنسفالیت ویروسی - encephalitis viral

آنسفالیت ویروسی عبارت است از التهاب حاد مغز در اثر عفونت ویروسی. عفونت ویروسی می‌تواند از همان اول باعث آنسفالیت شود یا این که به عنوان عارضه‌ای ثانویه به دنبال عفونت‌های ویروسی مثل سرخك، آبله‌مرغان، سرخجه، آبله‌گاوی، و عفونت ناشی از سایر ویروس‌های کمتر شناخته شده، یا واکسیناسیون آبله رخ دهد.



ـ علایم شایع:

۱. تب

۲. استفراغ

۳. سردرد

۴. تشنج

۵. سفتی گردن

۶. دو تا دیدن اشیاء

۷. گاهی بدون علامت

۸. احساس ناخوشی

۹. هماندازه نبودن مردمك‌ها

۱۰. از دست دادن هوشیاری

۱۱. تغییرات شخصیتی

۱۲. اختلال در صحبت کردن

۱۳. از دست دادن شنوایی

۱۴. تورم یا بیرون زدن ملاج شیرخواران

۱۵. ضعف یا فلج گاهگاهی دست یا پا

۱۶. خواب‌آلودگی که به سمت اغما پیشرفت می‌کند.

ـ علل بیماری:

۱. سرطان خون

۲. مسمومیت با سرب

۳. واکنش نسبت به واکسن

۴. ویروس‌هایی که ناقل آنها پشه‌ها یا سایر حشرات هستند.

۵. ویروس‌هایی که باعث بیماری‌های دیگر می‌شوند مثل فلج اطفال؛ تب خال؛ سرخك؛ اوریون؛ آبله‌مرغان؛ منونوکلئوز عفونی؛ هپاتیت عفونی؛ سرخجه؛ آبله؛ ویروس کوکساکی و بیماری‌های اکوویروسی

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سن بالای 60 سال

۲. آلودگی با ویروس ایدز

۳. نوزادان و شیرخواران

۴. محیط زندگی شلوغ یا غیر بهداشتی

۵. وجود بیماری که مقاومت بدن را کم کرده باشد.

ـ پیشگیری:

۱. از تماس با هر بیماری که آنسفالیت دارد خودداری کنید.

۲. اگر در نواحی پرخطر به سر می‌برید، از مواد دافع حشرات و توری جهت جلوگیری از گزش حشره استفاده کنید.

۳. در صورت وجود هر گونه عفونتی در بدن به پزشك مراجعه کنید، خصوصاً عفونت‌های ویروسی که در قسمت علل ذکر شدند. باید تلاش شود تا از گسترش عفونت جلوگیری شود.

ـ عواقب مورد انتظار:

آنسفالیت ویروسی خفیف یك بیماری شایع است و امکان دارد اصلاً جلب توجه نکند. در مواردی که آنسفالیت شدید باشد معمولاً بیمار باید بستری شود. عوارض و موارد فوت ناشی از آنسفالیت بیشتر در شیرخواران و پیرمردان دیده می‌شود. بیمارانی که به سایر گروه‌های سنی تعلق دارند معمولاً به طور کامل بهبود می‌یابند. انتظار می‌رود بهبودی در عرض 3-2 هفته حاصل می‌شود، مگر در موارد شدید

ـ عوارض احتمالی:

درصد بسیار کمی از بیماران دچار آسیب دایمی مغز می‌شوند که عملکرد ذهنی یا عضلانی بیمار را مختل می‌کند.

ـ درمان:

اقدامات تشخیصی ممکن است شامل موارد زیر باشند: بررسی‌های آزمایشگاهی خون و مایع نخاع، عکس‌برداری از جمجمه با اشعه ایکس و نوار مغز. درمان مشتمل است بر داروهای متناسب و بر مبنای تشخیص، و نیز مراقبت‌های حمایتی. امکان دارد نیاز به بستری کردن بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه (آی‌سی‌یو) وجود داشته باشد. بیمار باید از نظر مشکلات تنفسی یا گروه خون نیز تحت درمان قرار گیرد.

ـ داروها:

۱. داروهای ضد تشنج

۲. استامینوفن برای سردرد یا تب

۳. ندرتاً داروهای کورتیزونی برای مهار التهاب

۴. در صورت لزوم، داروهای کنترل کننده صرع

۵. امکان دارد داروهای ضد ویروسی مثل آسیلکوویر یا آمانتادین تجویز شوند

۶. اگر آزمایشات نشان‌دهنده یك علت باکتریایی یا قارچی باشند، داروی اختصاصی آن تجویز خواهد شد.

ـ فعالیت:

باید در رختخواب استراحت کنید. همانطور که گفته شد، بهبود بیماری 3-2 هفته طول می‌کشد. البته تدریجاً هر چقدر که قدرت و احساس سلامتی‌تان اجازه می‌دهد فعالیت داشته باشید.

ـ رژیم غذائی:

رژیم خاصی توصیه نمی‌شود، البته ممکن است نیاز به سرم وجود داشته باشد. در بیماستان، وضعیت آب و الکترولیت بدن مرتباً کنترل می‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان علایم آنسفالیت را دارید.

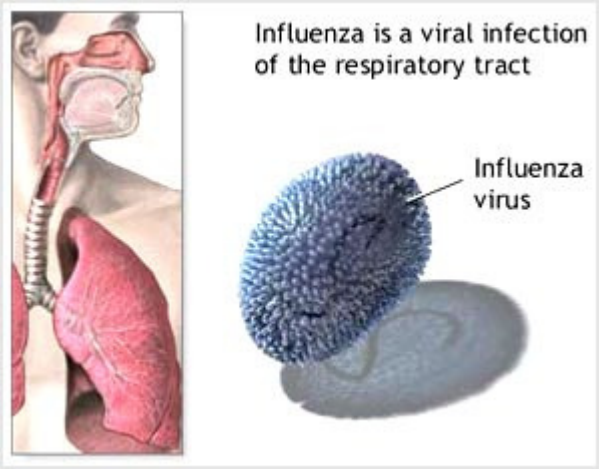
۲. اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124145

vista.ir
Online Classified Service

آنفلوانزا - influenza

آنفلوانزا عبارت است از یك عفونت تنفسی مسری و شایع که در اثر یك ویروس ایجاد می‌شود. مدت زمان شروع علایم از زمان وارد شدن ویروس به بدن 48-24 ساعت است. سه نوع اصلی ویروس آنفلوانزا وجود دارد (A,B,C) ، اما این ویروس‌ها توانایی جهش به انواع گوناگونی را دارند.



شیوع ناگهانی انواع مختلف آنفلوانزا تقریباً هر زمستان رخ می‌دهد و شدت آنها متفاوت است. آنفلوانزا هم در مرد و هم در زن در تمام سنین به غیر از دوران شیرخوارگی دیده می‌شود.

ـ علایم شایع:

۱. گلودرد

۲. سردرد

۳. خستگی

۴. خشونت صدا

۵. آبریزش از بینی

۶. لرز و تب متوسط تا بالا

۷. دردهای عضلانی، از جمله کمردرد

۸. سرفه، که معمولاً یا با خلط بسیار کم همراه است یا اصولاً خلطی همراه آن وجود ندارد.

ـ علل بیماری:

عفونت با ویروس‌های دسته میکسوویروس‌ها. این ویروس‌ها در اثر تماس مستقیم یا غیرمستقیم (مثلاً استفاده از لیوان آلوده) گسترش می‌یابند.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

۱. استرس

۲. خستگی شدید

۳. تغذیه نامناسب

۴. حاملگی (سه ماه سوم)

۵. سرکوب ایمنی ناشی از دارو یا بیماری

۶. مکان‌های شلوغ به هنگام بروز همه‌گیری

۷. بیماری مزمن، خصوصاً بیماری مزمن قلبی یا ریوی

۸. افرادی که در یك محیط نیمه بسته زندگی می‌کنند.

۹. وجود بیماری اخیر که موجب کاهش مقاومت بدن شده باشد.

ـ پیشگیری:

۱. حتی‌المقدور از خطرات ذکر شده در بالا پرهیز کنید.

۲. از تماس غیرضروری با افرادی که دچار عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی به هنگام فصل آنفلوانزا (زمستان) هستند خودداری کنید.

۳. استفاده از داروی آمانتادیس برای افراد پرخطر (که واکسن تزریق نکرده باشند) یا افرادی که نیازمند اقدامات کنترلی اضافه‌تری هستند.

۴. اگر بالای 65 سال سن دارید یا مبتلا به بیماری مزمن قلبی یا ریوی هستید، سالانه واکسن آنفلوانزا دریافت کنید. این واکسن تنها در برابر 2 یا 3 زیر نوع به خصوص از آنفلوانزای نوع A حفاظت ایجاد می‌کند.

ـ عواقب مورد انتظار:

بهبود خود به خودی در عرض 10-7 روز در صورتی که هیچ عارضه‌ای رخ ندهد. اگر عارضه‌ای رخ دهد، درمان با آنتی‌بیوتیك معمولاً ضروری است، و بهبود ممکن است 6-3 هفته به درازا انجامد.

ـ عوارض احتمالی:

عفونت‌های باکتریایی از جمله برونشیت یا ذات‌الریه. این عفونت‌ها ممکن است خصوصاً در افرادی که بیماری مزمن دارند یا افراد بالای 65 سال خطرناك باشند.

ـ درمان:

۱. روی عضلاتی که دچار درد هستند کمپرس گرم یا صفحه گرم‌کننده بگذارید.

۲. برای تخفیف گرفتگی بینی، غالباً با آب گرم یا سرد، چای غلیظ یا آب نمك قرقره کنید.

۳. بررسی‌های آزمایشگاهی، مثل آزمایش خون و کشت خلط؛ عکس‌برداری اشعه ایکس از قفسه سینه (تنها در صورت بروز عوارض).

۴. برای جلوگیری از سرایت بیماری به دیگران، دستان خود را مرتباً بشویید، خصوصاً پس از فین کردن یا پیش از دست زدن به غذا یا مواد غذایی.

۵. برای افزایش رطوبت هوا از یك دستگاه بخور خنك استفاده نمایید. رطوبت کمك می‌کند تا ترشحات ریه رقیق و بنابراین راحت‌تر تخلیه شوند. درون دستگاه بخور خنك دارو نگذارید، زیرا کمکی نمی‌کند. دستگاه را روزانه تمیز کنید.

ـ داروها:

برای ناراحتی خفیف می‌توان از داروهایی مثل استامینوفن، شربت‌های ضد سرفه، افشانه‌ها (اسپری‌های) بینی یا ضد احتقان‌ها (رفع‌کننده گرفتگی بینی) استفاده نمود. آسپیرین نخورید، زیرا در بعضی از تحقیقات مشخص شده است که بین مصرف آسپیرین (خصوصاً در کودکان) به هنگام بروز یك بیماری ویروسی و به وجود آمدن نشانگان رای ارتباط وجود دارد. نشانگان رای یك نوع آنسفالیت (التهاب مغز) است. می‌توان از یك دسته داروهای ضد ویروسی در موارد شدید یا برای کسانی که در معرض بیشترین خطر بروز عوارض هستند استفاده نمود.

ـ فعالیت:

بهترین درمان برای آنفلوانزا استراحت است. اگر وضعیت سلامت عمومی شما خوب باشد، استراحت کمك می‌کند تا بدنتان با ویروس به خوبی مبارزه کند.

ـ رژیم غذائی:

معمولاً اشتها به هنگام آنفلوانزا کم می‌شود. شاید در ابتدا فقط اشتها به مایعات داشته باشید، سپس پس از مدتی به وعده‌های غذایی کوچك حاوی مواد نشاسته‌ای بدون ادویه (نان سوخاری، برنج، پوره، غلات پخته شده، سیب‌زمینی پخته) اشتها پیدا کنید. روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشید (خصوصاً اگر تبتان بالا باشد). نوشیدن مایعات بیشتر مثل آب میوه، چای و نوشیدنی‌های غیر گازدار نیز به رقیق شدن ترشحات کمك می‌کنند.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان علایم آنفوآنزا را دارید.

۲. درد یا سفتی گردن

۳. افزایش تب یا سرفه

۴. وجود خون در خلط

۵. گوش درد

۶. تنگی نفس یا درد قفسه سینه

۷. ترشحات غلیظ از بینی، سینوس‌ها یا گوش‌ها

۸. درد سینوس

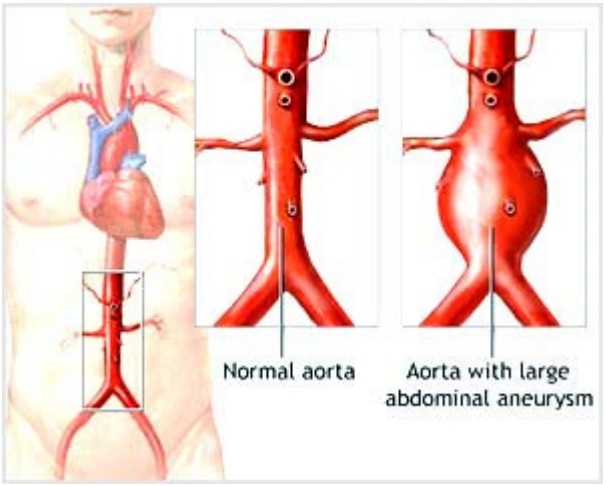
۹. اگر دچار علایم جدید و غیر قابل توجیه شده‌اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند

http://vista.ir/?view=item&id=124146

vista.ir
Online Classified Service

آنوریسم - aneurysm

آنوریسم عبارت است از بزرگ شدن یا بیرون‌زدگی دیواره یك سرخرگ در اثر ضعف دیواره سرخرگ. آنوریسم اغلب پس از حمله قلبی رخ می‌دهد و معمولاً در آئورت (سرخرگ بزرگی که از قلب منشاء گرفته و در سینه و شکم به سمت پایین حرکت می‌کند) یا سرخرگ‌هایی که مغز، پاها، یا دیواره قلب را تغذیه می‌کنند، ایجاد می‌شود.



ـ علایم شایع:

۱. وجود آنوریسم در عضله قلب باعث نامنظم شدن ضربان قلب و علایم نارسایی احتقانی قلب می‌شود.

۲. آنوریسم در قفسه صدری باعث درد قفسه صدری، گردن، کمر، و شکم می‌شود. درد ممکن است ناگهانی و تیز باشد.

۳. آنوریسم در شکم باعث درد در کمر (گاهی شدید)، بی‌اشتهایی و کاهش وزن، و وجود یك توده ضربان‌دار در شکم می‌شود.

۴. وجود آنوریسم در یك سرخرگ مغزی باعث سردرد (اغلب ضربان‌دار)، ضعف، فلج یا کرختی، درد پشت چشم، تغییر بینایی یا نابینایی نسبی، و مساوی نبودن اندازه مردمك‌ها می‌شود.

۵. آنوریسم در یك سرخرگ در پا باعث نرسیدن خون به قدر کافی به نقاط مختلف پا می‌شود. در نتیجه پا دچار ضعف و رنگ‌پریدگی می‌شود، یا اینکه متورم شده، رنگ آن به آبی تغییر می‌کند. امکان دارد یك توده ضربان‌دار در ناحیه کشالهٔ ران یا پشت زانو وجود داشته باشد.

ـ علل بیماری:

۱. صدمه فیزیکی

۲. آترواسکلروز (تصلب شرایین)

۳. عفونت آئورت در اثر بیماری سیفلیس (نادر است).

۴. شایع‌ترین علت، افزایش فشارخون است که سرخرگ را ضعیف می‌کند.

۵. ضعف مادرزادی سرخرگ (به خصوص در مورد آنوریسم‌های سرخرگ‌هایی که به مغز می‌روند.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. چاقی

۲. فشارخون بالا

۳. سیگارکشیدن

۴. سابقه حمله قلبی

۵. سن بیشتر از 60 سال

۶. سابقه خانوادگی تصلب شرایین

۷. آندوکاردیت باکتریال (عفونت سطح داخلی قلب)

۸. پلی‌آرتریت گرهی (یك نوع بیماری که طی آن التهاب سرخرگ‌های کوچك و متوسط رخ می‌دهد)

ـ پیشگیری:

۱. ترك سیگار

۲. ورزش منظم

۳. کاهش استرس

۴. تغذیه کافی و رژیم کم‌چربی

۵. رعایت برنامه درمانی کنترل فشارخون

۶. در صورت وجود سیفلیس، درمان زودهنگام

ـ عواقب مورد انتظار:

اغلب به کمك جراحی درمان‌پذیر است. در جراحی، رگ مصنوعی به جای آن قسمت از رگ که آنوریسم دارد گذاشته می‌شود. جراحی در مورد آنوریسم قلبی می‌تواند باعث بر طرف شدن نامنظمی‌های ضربانی شود و عمر را طولانی‌تر کند. گاهی آنوریسم عود می‌کند.

ـ عوارض احتمالی:

۱. سکته مغزی

۲. پاره‌شدن آنوریسم. علایم بسته به مکان آنوریسم عبارتند از: سردرد شدید، درد شدید و تند و تیز در قفسه صدری، شکم یا پا، از دست دادن هوشیاری. اگر پارگی درمان نشود می‌تواند به مرگ بیانجامد.

ـ درمان:

۱. جراحی برای جایگزین کردن رگ دچار آنوریسم یا بستن آنوریسم

۲. تشخیص زودهنگام و درمان قبل از اینکه آنوریسم پاره شود ضروری است.

۳. پس از جراحی، اندازه‌گیری فشارخون و کنترل فشارخون را جدی گرفته و یاد بگیرید.

۴. آنوریسم مغزی نیاز به جراحی اورژانس دارد. جراحی برای سایر انواع آنوریسم را می‌توان در میزان مناسب انجام داد.

۵. بررسی‌ها عبارتند از: آزمایش خون از لحاظ انعقادی، نوار قلب، آنژیوگرافی، سایر عکس‌برداری‌ها، سی‌تی‌اسکن، یا سونوگرافی

ـ داروها:

داروهای ضدانعقادی برای جلوگیری از تشکیل لخته و داروهای ضددرد، پس از جراحی تجویز می‌شوند. امکان دارد برای جلوگیری از عفونت آنتی‌بیوتیك تجویز شود.

ـ فعالیت:

قبل از جراحی از فعالیت سنگین یا فشارآوردن به خود اجتناب کنید. بعد از جراحی، به تدریج فعالیت‌های عادی خود را از سر گیرید.

ـ رژیم غذائی:

قبل از جراحی، غذای پرفیبر مصرف نمایید تا از زور زدن به هنگام اجابت مزاج اجتناب کنید. بعد از جراحی، رژیم خاصی توصیه نمی‌شود.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر پس از جراحی، هر کدام از علایم دوباره رخ دهد.

۲. اگر حمله قبلی داشته‌اید و بعد از آن دچار نامنظمی ضربان قلب یا علایم نارسایی احتقانی قلب شده‌اید.

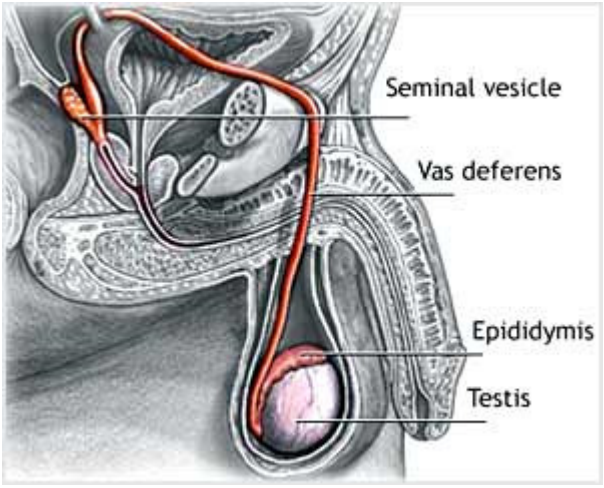
۳. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم آنوریسم را دارید، به خصوص وجود یك توده ضربان‌دار در شکم یا پا، یا درد قفسه صدری یا شکمی این یك اورژانس است! کمك بخواهید و تا زمان رسیدن آمبولانس در تخت استراحت کنید.

http://vista.ir/?view=item&id=124147

vista.ir
Online Classified Service

اپیدیدیمیت - epididymitis

اپیدیدیمیت عبارت است از التهاب و عفونت اپیدیدیم. اپیدیدیم یك ساختار مستطیلی شکل است که به قسمت بالایی هر کدام از بیضه‌ها می‌چسبد.



ـ علایم شایع:

۱. تب

۲. بزرگ، سفت و دردناك شدن بیضه.

۳. گاهی حساس بودن بیضه دیگر به لمس

۴. حساس بودن محتویات کیشه بیضه به لمس

۵. غالباً التهاب حاد پیشابراه که باعث سوزش به هنگام ادرار می‌شود.

۶. شروع سریع درد، گرمی و تورم در پشت یکی از بیضه‌ها (گاهی هر دو بیضه)

ـ علل بیماری:

معمولاً عارضه‌ای از یك عفونت باکتریایی در قسمت دیگری از بدن است، مثلاً سوزاك؛ عفونت پروستات؛ یا عفونت مثانه یا کلیه. اپیدیدیمیت ممکن است عارضه‌ای از عفونت در کیسه بیضه باشد یا به علت آسیب به کیسه بیضه ایجاد شود.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. تنگی پیشابراه

۲. بودن سوند ادراری به‌مدت طولانی

۳. بیماری اخیر، خصوصاً التهاب حاد یا مزمن پروستات، التهاب پیشابراه، یا عفونت مجاری ادراری

ـ پیشگیری:

۱. استفاده از کاندوم و عدم بی‌بندوباری

۲. حتی‌المقدور اجتناب از سوند ادراری.

ـ عواقب مورد انتظار:

معمولاً با درمان خوب می‌شود. درد معمولاً در عرض 3-1 روز بهبود می‌یابد، اما بهبودی کامل ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها به طول انجامد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. گاهی یبوست، زیرا اجابت مزاج باعث بدتر شدن درد می‌شود.

۲. عقیمی یا تنگی و انسداد پیشابراه. در صورتی که اپیدیدیمیت در هر دو طرف رخ داده باشد. این موارد احتیاج به جراحی دارند.

ـ درمان:

۱. ندرتاً برای تشخیص قطعی و نجات بیضه، عمل جراحی تفحصی انجام می‌شود.

۲. امکان دارد عمل جراحی برای موارد شدید که به آنتی‌بیوتیك‌ها جواب نمی‌دهند ضرورت یابد.

۳. برای کمك به کاهش درد و تورم، یك کیسه یخ را روی نواحی ملتهب قراردهید. از گرما استفاده نکنید.

۴. بررسی‌های آزمایشگاهی مثل آزمایش ادرار و کشت ترشحات پروستات برای شناسایی میکروب مسؤول.

۵. هدف درمان عبارت است از مبارزه با عفونت و کاهش درد و تورم درمان معمولاً می‌تواند در منزل انجام گیرد.

۶. سعی شود کیسه بیضه از زیر نگاه داشته شود تا درد کمتر شود. برای این کار می‌توان از یك حوله نرم استفاده کرد و آن را بین پاها و زیر ناحیه ملتهب قرار داد.

۷. پیش از شروع فعالیت‌های عادی از یك وسیله محافظت‌کننده و نگهدارنده که در بعضی از ورزش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد یا لباس زیر نسبتاً تنگ استفاده نمایید.

ـ داروها:

۱. نرم‌کننده‌های مدفوع

۲. آنتی‌بیوتیك برای مبارزه با عفونت

۳. ایبوپروفن یا استامینوفن برای درد خفیف. در مواردی که درد متوسط تا شدید وجود داشته باشد ممکن است داروهای ضد درد قوی‌تر تجویز شوند.

ـ فعالیت:

تا وقتی که تب، درد و تورم بهبود نیافته‌اند، در رختخواب استراحت کنید. از مقاربت جنسی خودداری کنید؛ حداقل یك ماه پس از فروکش کردن کلیه علایم صبر کنید.

ـ رژیم غذائی:

۱. برای پیشگیری از یبوست، غذاهای مسهل طبیعی بخورید، مثل آلو، میوه تازه، غلات سبوس‌دار و آجیل.

۲. از خوردن الکل، چای، قهوه، یا نوشابه‌های گاز دار خودداری کنید. این مواد باعث تحریك و آزردگی دستگاه ادراری می‌شوند.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما دچار تب شوید

۲. اگر شما دچار یبوست شوید

۳. اگر درد با کارهای توصیه شده تخفیف نیابد.

۴. اگر علایم در عرض 4 روز پس از شروع درمان، رو به بهبود نگذارند.

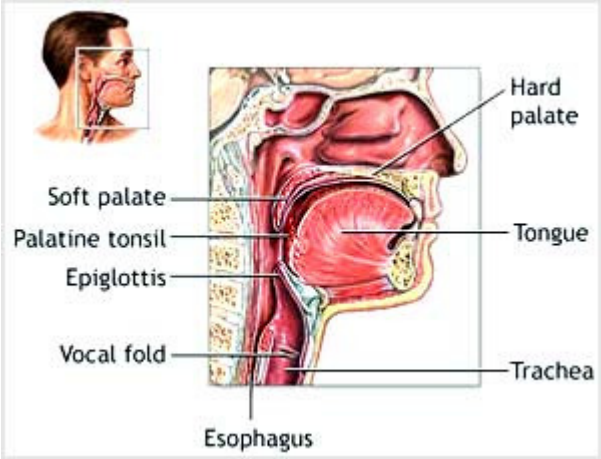
۵. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علایم اپیدیدیمیت را دارید.

http://vista.ir/?view=item&id=124149

vista.ir
Online Classified Service

اپی‌گلوتیت - epiglottitis

اپی‌گلوتیت عبارت است از یك عفونت ناگهانی و تهدیدکننده زندگی درکودکان که در اپی‌گلوت روی می‌دهد. اپی‌گلوت یك صفحه بافتی کوچك در عقب گلو است که از ورودی نای مراقبت به عمل می‌آورد.



اپی‌گلوتیت مسری است و اغلب با خروسك (کروپ) که خطر کمتری دارد اشتباه می‌شود. توجه داشته باشید که تورم اپی‌گلوت ممکن است در عرض 12 ساعت از شروع بیماری باعث بسته شدن کامل راه هوایی شود، بنابراین بیمار باید فوراً تحت درمان قرار گیرد.

ـ علایم شایع:

۱. تب

۲. گلو درد

۳. خشونت صدا

۴. مشکل تنفسی فزاینده

۵. بنفش شدن پوست و بستر ناخن‌ها

۶. آبریزش از دهان به علت مشکل در بلع بزاق

۷. دم پر سروصدا، جیغ مانند و با فرکانس بالا

۸. صدا یا گریه خفه و گرفته (در خروسك صدا یا گریه خشن‌تر است).

۹. سرفه در حد کم (در خروسك سرفه زیاد و شبیه پارس سگ است).

۱۰. کودك سر خود را ممکن است در وضعیت نامعمولی قرار دهد. کودك گردن خود را به عقب و بدن خود را به جلو خم می‌کند، زبانش را بیرون می‌آورد و پره‌های بینی را تا حد امکان گشاد می‌کند. با این کار کودك تلاش دارد تا هوای بیشتری را استنشاق کند.

ـ علل بیماری:

عفونت اپی‌گلوت توسط باکتری (معمولاً هموفیلوس آنفلوآنزا ، پنوموکك، یا استرپتوکك). تورم اپی‌گلوت باعث بسته شدن ورودی نای می‌شود.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. محیط زندگی شلوغ یا غیربهداشتی

۲. وجود یك بیماری که مقاومت بدن را کاهش داده باشد.

ـ پیشگیری:

اگر کودکتان قبلاً مبتلا به اپی‌گلوتیت شده است، هرگونه عفونت تنفسی را جدی بگیرید و برای درمان تحت نظارت مراجعه کنید. کودك باید واکسن هموفیلوس آنفلوآنزا را بزند.

ـ عواقب مورد انتظار:

بهبود کامل در صورت تشخیص و درمان زودهنگام

ـ عوارض احتمالی:

ذات‌الریه، منتژیت، عفونت مفصل، عفونت و التهاب پرده دور قلب، یا سلولیت (عفونت بافت عمقی زیر پوست). بدون درمان امکان دارد مسیر هوایی کاملاً مسدود شود و کودك ممکن است در عرض چند ساعت فوت کند.

ـ درمان:

۱. کودك را به جای خواباندن بنشانید.

۲. بستری کردن کودك برای دادن اکسیژن و انجام سایر اقدامات مراقبتی ویژه

۳. اگر مشکوك به اپی‌گلوتیت هستید هرگز سعی نکنید ته گلوی کودك را نگاه کنید.

۴. کودك را تا رسیدن به بیمارستان آرام و بی‌حرکت نگاه دارید. اضطراب و ترس بچه باعث بدتر شدن مشکلات تنفسی می‌شود.

۵. اقدامات تشخیصی ممکن است شامل کشت خون، کشت گلو، و سایر اقداماتی که تحت کنترل دقیق انجام می‌گیرند تا از بروز عوارض جلوگیری شود باشد.

۶. پس از ترخیص از بیمارستان، شب‌ها در اتاق کودك یك دستگاه بخور تولید هوای مرطوب خنك بگذارید. این کار را 3-2 هفته ادامه دهید. ضمناً دستگاه باید روزانه تمیز شود.

۷. جراحی برای باز کردن راهی به نای یا قرار دادن لوله‌ای در نای برای اینکه کودك بتواند تنفس کند. راهی که به نای باز شده است (یا لوله‌ای که در نای قرار داده شده است) در عرض 3-1 روز بسته (یا درآورده) می‌شود.

ـ داروها:

۱. داروهای کورتیزونی برای کاهش التهاب

۲. آنتی‌بیوتیك برای کنترل عفونت. آنتی‌بیوتیك باید حداقل 10 روز ادامه یابد.

ـ فعالیت:

تا وقتی که تمام علایم برطرف نشده باشند، استراحت در رختخواب ضروری است. سپس کودك می‌تواند به‌تدریج فعالیت‌هایش را از سر گیرد.

ـ رژیم غذائی:

تا زمانی که کودك دوباره قادر به بلع باشد باید تنها از مایعات (معمولاً سرم) استفاده شود. پس از ترخیص از بیمارستان، کودك را تشویق کنید که مایعات بیشتر بنوشد. رژیم غذایی کودك در این هنگام به حالت عادی برمی‌گردد.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر کودك شما قبلاً مبتلا به اپی‌گلوتیت شده است، و هم‌اکنون علایم عفونت تنفسی دارد.

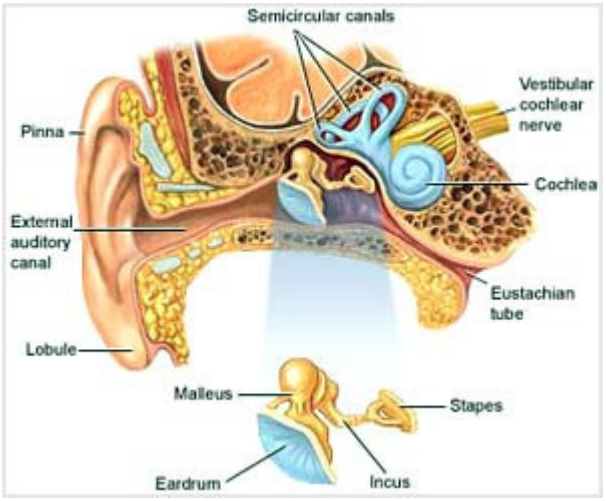
۲. اگر کودکتان علایم اپی‌گلوتیت را دارد. خصوصاً اگر کودك مشکل تنفسی داشته باشد، اورژانس را خبر کنید.

http://vista.ir/?view=item&id=124148

vista.ir
Online Classified Service

اتواسکلروز - otosclerosis

اتواسکلروز رشد غیرطبیعی تدریجی استخوان اسفنجی در گوش میانی. این رشد مانع عملکرد طبیعی یکی از استخوان‌های کوچك گوش میانی که مسؤول انتقال صداست شده و از این طریق سبب کاهش شنوایی می‌شود.



اتواسکلروز معمولاً هر دو گوش را مبتلا می‌سازد و در هر دو جنس و همه سنینن دیده می‌شود ولی در جنس مؤنث دوبرابر شایع‌تر بوده و در سنین 30-15 سال شایع‌تر است.

ـ علایم شایع:

۱. وزوزگوش

۲. کاهش شنوایی تدریجی و پیشرونده

۳. شنوایی بهتر در محیطهای شلوغ نسبت به محیطهای ساکت

ـ علل بیماری:

این اختلال به نظر می‌رسد ارثی باشد. 60% افراد مبتلا دارای سابقه خانوادگی این بیماری هستند.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سابقه خانوادگی کاهش شنوایی

۲. بارداری که ممکن است تحریک‌کننده آغاز بیماری باشد.

۳. نژاد سفیدپوست. حدود 10% افراد سفیدپوست به درجاتی از اتواسکلروز مبتلا هستند.

ـ پیشگیری:

در حال حاضر این بیماری قابل پیشگیری نیست. در صورت وجود سابقه خانوادگی این بیماری، قبل از تشکیل خانواده مشاوره ژنتیك الزامی است.

ـ عواقب مورد انتظار:

در بیشتر موارد با جراحی، شنوایی حداقل به طور نسبی حفظ می‌شود.

ـ عوارض احتمالی:

کری کامل در عرض 15-10 سال. در صورت عدم درمان هرچه بیمار جوانتر باشد، سرعت کاهش شنوایی بیشتر خواهد بود.

ـ درمان:

تشخیص بیماری براساس آزمون‌های شنوایی نظیر اودیوگرام و آزمون رینه (بررسی هدایت استخوانی صدا) داده می‌شود. درمان معمولاً عبارتست از جراحی برای برداشت استخوان چکشی (یکی از استخوان‌های گوش میانی) و جایگزین کردن آن با استخوان مصنوعی. در اکثر موارد و با این درمان، شنوایی حداقل به طور نسبی اصلاح می‌گردد. ممکن است به جای درمان جراحی از سمعك استفاده شود.

ـ داروها:

۱. آنتی‌بیوتیك ممکن است پس از جراحی تجویز شود.

۲. درمان با قرص فلوریدسدیم، کلسیم و ویتامین ـ د ممکن است با سخت کردن استخوان اسفنجی تشکیل شده مانع پیشرف بیشتر کاهش شنوایی گردد.

ـ فعالیت:

پس از جراحی به تدریج فعالیت‌های طبیعی خود را از سر بگیرید.

ـ رژیم غذائی:

رژیم خاصی نیاز نیست.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر شما یا یکی از اعضا خانواده‌تان دارای علایم اتواسکلروز باشید.

۲. اگر دچار علایم عفونت، نظیر تب، درد یا منگی بیش از حد پس از جراحی.

http://vista.ir/?view=item&id=124150

vista.ir
Online Classified Service

اختلال تنش‌زای پس از حادثه - post traumatic stress disorder

اختلال تنش‌زای پس از حادثه (PTSD) نوعی اضطراب در افرادی که حادثه‌ای را که برای اکثر مردم بسیار آزارنده و مضطرب کننده است تجربه کرده‌اند. این حوادث (بلایای طبیعی، قتل، هتك حرمت، جنگ، زندانی شدن، شکنجه، تصادفات) در همه افراد يك استرس روانی ایجاد می‌کنند ولی برخی افراد پس از آن سیر طبیعی بهبود را طی نمی‌کنند.



مشخصه اختلال تنش‌زای پس از حادثه این اختلال عبارتست از یادآوری مداوم حادثه و بروز علایم مربوط به آن. این علایم ممکن است درست پس از حادثه شروع شده یا چند ماه بعد بروز کند.

ـ علایم شایع:

۱. بی‌خوابی

۲. اضطراب مزمن

۳. اختلال در تمرکز

۴. اختلال حافظه

۵. احساس منزوی شدن از دیگران

۶. کاهش علاقه به فعالیت‌های معمول

۷. دیدن خواب‌های مکرر مرتبط با حادثه

۸. یادآوری مکرر، غیرقابل اجتناب و آزارنده حادثه

۹. احساس رخداد دوباره حادثه (مجسم شدن تصاویر حادثه)

۱۰. واکنش‌های ترس نسبت به موقعیت‌ها یا اجتناب از فعالیت‌هایی که باعث یادآوری حادثه می‌گردند.

۱۱. آثار روانی (تحریك‌پذیری، بی‌قراری، هراسان بودن، بروز رفتارهای ناگهانی به صورت انفجاری، رکود احساسات، احساس زجرآور

ـ علل بیماری:

۱. خونین و بی‌رحمانه بودن حادثه

۲. ناگهانی و غیرمنتظره بودن حادثه

۳. استرس طولانی‌تر و مزمن در طی حادثه

۴. قدرت و ضعف روانی و سرشتی قربانی حادثه

۵. آسیب‌های جسمی (به خصوص آسیب سر)

۶. نوع حمایت اجتماعی و میزان دسترسی به آن

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سطح سواد پایین

۲. وجود والدین الکلی

۳. سوء رفتار با فرد در کودکی

۴. سابقه بی‌توجهی به فرد یا شرایط بد خانوادگی در کودکی

ـ پیشگیری:

مداخله فوری بلافاصله پس از حوادث غیرمترقبه ممکن است از ایجاد این اختلال جلوگیری کند.

ـ عواقب مورد انتظار:

در برخی بیماران، علایم خودبه‌خود پس از 6 ماه برطرف می‌شوند؛ درمان در بعضی بیماران ممکن است کمك کننده باشد؛ در سایر بیماران این اختلال ممکن است سیری مزمن برای ماه‌ها یا سال‌ها داشته باشد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. خودکشی

۲. وابستگی به داروها و الکل

۳. آسیب زدن به خود در طی تجسم دوباره حادثه

۴. اختلال تنش‌زای پس از حادثه از نوع مزمن که می‌تواند به از دست دادن شغل، اختلالات خانوادگی و ناتوانی منجر شود.

ـ درمان:

۱. پیمان بستن بیمار با خود جهت مقابله با مشکل

۲. اخذ سابقه طبی و معاینه فیزیکی توسط یك پزشك

۳. مشاوره روانشناختی جهت درمان توصیه می‌شود.

۴. برای رد کردن اختلالات مغزی آزمون‌های آزمایشگاهی و طبی ضروری است.

۵. آموختن روش‌های آسوده‌سازی. این روش‌ها به ویژه برای کمك به رفع مشکلات خواب مفیدند.

۶. گروه‌های حمایتی بسیار مؤثر بوده و در مراکز نظامی و مراکز بحران‌های اجتماعی در دسترس‌اند.

ـ داروها:

پزشك ممکن است برای دوره‌های کوتاه داروهای ضداضطراب یا ضد افسردگی تجویز کند. داروی اختصاصی برای درمان این اختلال وجود ندارد.

ـ فعالیت:

محدودیتی وجود ندارد. یك برنامه ورزشی معمول در تسکین برخی تنش‌ها سودمند است.

ـ رژیم غذائی:

رژیم خاصی نیاز نیست.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر علایم پس از شروع درمان بهبود نیافته یا بدتر شوند.

۲. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان دارای علایم اختلال تنش‌زای پس از حادثه باشید.

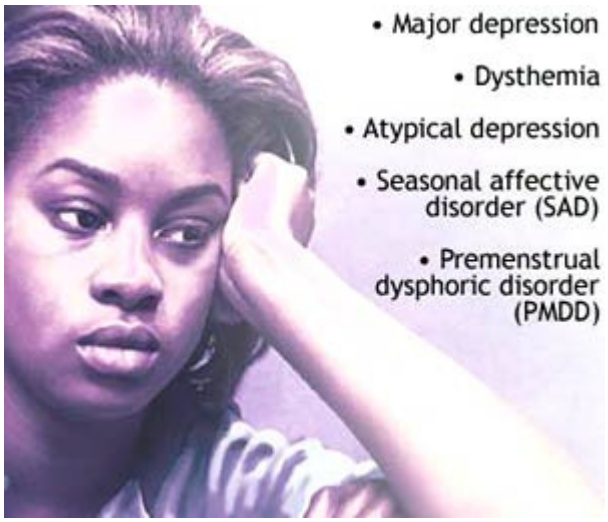
۳. اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید/ داروهای تجویزی ممکن است با عوارض جانبی همراه باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124151

vista.ir
Online Classified Service

اختلال خلقی فصلی - seasonal affective disorder

اختلال خلقی فصلی تغییر فصلی خلق که در طی فصل زمستان بروز کرده و با آمدن بهار برطرف می‌گردد. علایم این عارضه معمولاً در ماه شهریور که روزها شروع به کوتاه شدن می‌کنند آغاز شده، در طی زمستان تا ماه اسفند که روزها دوباره شروع به بلند شدن می‌کنند ادامه می‌یابد. روشنایی نقش مهمی در ایجاد و نیز درمان این اختلال دارد.



این عارضه هم در بزرگسالان و هم در کودکان بروز کرده و در خانم‌ها شایعتر است. در موارد نادر، این اختلال فصلی خلق در ماه‌های تابستان بروز کرده و ممکن است ناشی از عدم تحمل گرما باشد.

ـ علایم شایع:

۱. افسردگی

۲. خستگی

۳. افزایش وزن

۴. تحریک‌پذیری

۵. سستی و تنبلی

۶. نیاز بیشتر به خواب

۷. احساس شادی کمتر

۸. افزایش اشتها (به‌خصوص نسبت به کربوهیدرات‌ها)

۹. تمایل کمتر برای شرکت در فعالیت‌های اجتماعی اختلال در تطبیق دادن خود با زندگی در اثر تغییرات فوق.

ـ علل بیماری:

غده پینه‌آل (یکی از اعضای تنظیم‌گر بدن) در مغز، هورمونی به‌نام ملاتونین ترشح می‌کند که می‌تواند اثر منفی بر روی خلق داشته باشد. در محیط روشن (در طی روز) میزان ترشح ملاتونین بسیار اندك است؛ حداکثر میزان ترشح آن در شب و بین ساعت‌های 3-2 صبح است. در فصل زمستان که طول مدت شب در آن طولانی‌تر است ترشح ملاتونین افزایش یافته و بنابراین سطح آن در بدن نیز افزایش می‌یابد. روشن بودن چراغ در حد معمول شب‌ها در منزل یا دفتر کار برای خنثی کردن یا اثر فصل زمستان ناکافی است.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. وجود سایر بیماری‌های منجر به افسردگی

۲. موقعیت جغرافیایی (افراد ساکن در عرض‌های جغرافیایی شمالی کره زمین نسبت به این اختلال مستعدترند).

ـ پیشگیری:

هیچ اقدام خاصی برای پیشگیری از این اختلال شناخته نشده است.

ـ عواقب موردانتظار:

با تشخیص و درمان صحیح، علایم این اختلال را می‌توان به حداقل رساند.

ـ عوارض احتمالی:

تداوم علایم در طول زندگی و ایجاد اختلال در زندگی

ـ درمان:

۱. در برخی بیماران نوردرمانی مؤثر نبوده و ممکن است انواع دیگر درمان نظیر دارودرمانی یا روان‌درمانی لازم گردد.

۲. تشخیص این اختلال ممکن است مشکل باشد زیرا سایر انواع افسردگی نیز ممکن است همین علایم را داشته باشند.

۳. آزمایش‌های خون برای رد سایر اختلالات طبی احتمالی ممکن است انجام شود. تشخیص این اختلال معمولاً نیاز به یك بررسی سه‌ساله تغییرات خلقی دارد؛ چنانچه این تغییرات خلقی در پاییز شروع شده و با آمدن بهار فروکش نمایند این تشخیص تأیید می‌گردد.

۴. علایم خفیف ممکن است با اقدامات ساده زیر قابل برطرف شدن باشند: پرده‌های اتاق را کنار بزنید؛ در کنار پنجره بنشینید و به‌طور مکرر به بیرون نگاه کنید. در روزهای ابری از چراغ‌های پرنور استفاده کنید. تغییرات خلقی خود را به‌طور روزانه ثبت کنید تا هرگونه تغییر خلقی یا الگوی خلقی بعداً قابل ارزیابی باشد. خود را منزوی نکنید (به ملاقات دوستان رفته، از نمایشگاه‌ها دیدن کنید و...). به پیشنهادهای ذکرشده در قسمت «فعالیت» توجه کنید.

۵. سایر درمان‌ها در این زمینه هنوز مراحل تکاملی خود را طی می‌کنند، ولی اساس آنها را معمولاً طولانی کردن روز به‌طور مصنوعی با روش‌های مختلف یا نوردرمانی تشکیل می‌دهد. مدت و شدت درمان ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد و تعیین آن باید با همفکری شما و تیم پزشکی شما صورت گیرد. اگرچه این منابع روشنایی به‌صورت تجاری در دسترس قرار دارند، توصیه می‌شود که بدون دستور پزشك از آنها استفاده نشود. نمونه‌هایی از این درمان‌ها به‌شرح زیر است: ۱. روزی یك ساعت صبح و عصر زیر یك چراغ بسیار پرنور (معادل لامپ‌های 10100 وات یا بیشتر) بنشینید. واژه لوکس (LUX) که معادل لاتین واژه روشنایی (light) در انگلیسی است، واحد اندازه‌گیری برای نوردرمانی است. ۲. از یك کلاه آفتاب‌گردان دارای چراغ‌های کوچك روشن‌شونده با باتری که روشنایی را مستقیماً بر روی چشم‌ها می‌اندازد استفاده کنید.

ـ داروها:

داروهای ضدافسردگی در بیمارانی که به سایر درمان‌ها پاسخ نمی‌دهند ممکن است تجویز گردد.

ـ فعالیت:

۱. در فصل زمستان به مناطق گرمسیر مسافرت نمایید.

۲. تا آنجا که ممکن است در محیط باز قرار گیرید به‌خصوص در روشنایی اول صبح.

۳. در حد توان و انرژی خود به فعالیت بپردازید. فعالیت فیزیکی تقریباً همیشه برای اختلالات خلقی اثر درمانی دارد.

ـ رژیم غذائی:

از یك رژیم طبیعی متعادل برای حفظ سلامتی مطلوب استفاده کنید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر علایم با وجود درمان ادامه یافته یا تشدید شوند.

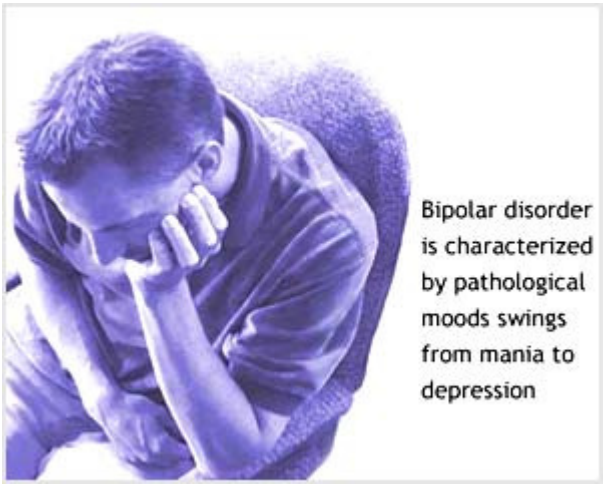
۲. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان دارای علایم اختلال خلقی فصلی باشید.

http://vista.ir/?view=item&id=124152

vista.ir
Online Classified Service

اختلال دوقطبی - bipolar disorder

اختلال دوقطبی (اختلال شیدایی ـ افسردگی) عبارت است از اختلالی که در آن خلق بیمار دچار نوسانات شدیدی می‌شود، و ارتباطی بین خلق بیمار و آنچه که واقعاًدر زندگی بیمار رخ می‌دهد وجود ندارد.



سیر بیماری بدین نحو است که به طور یك در میان ولی نامنظم، یك مدت فرد دچار سرخوشی و فعالیت زیاد بدون توجیه است (شیدایی) و به دنبال آن دچار افسردگی شدید می‌شود، و این سیکل به همین منوال ادامه پیدا می‌کند. در بین شیدایی و افسردگی، دوره‌ای از رفتار طبیعی (ممکن است کوتاه باشد یا حتی چند سال طول بکشد) وجود دارد.

ـ علایم شایع:

۱. شیدایی

۲. افسردگی

۳. کاهش میل جنسی

۴. غفلت از رسیدگی به خود

۵. افزایش انرژی؛ سرخوردگی و نئشگی در بیمار

۶. بیمار صبح زودتر و زودتر از خواب برمی خیزد (در مواردی بیمار ممکن است حتی 4-3 روزنخوابد)

۷. حواس بیمار خیلی زود از یك كار پرت می‌شود و بسیار بی‌قرار است (امکان دارد این مسأله باعث کاهش بازده کاری شود). فرد پروژه‌های جدید را با اشتیاق فراوان آغاز می‌کند، ولی ندرتاً آنها را به پایان می‌برد.

۸. امکان دارد بیمار شروع به ولخرجی کند.

۹. امکان دارد بیمار شریك‌های جنسی متعدد اختیار کند.

۱۰. بیمار اغلب تحریك‌پذیر است و دچار حملات عصبانیت می‌شود.

۱۱. صحبت کردن بیمار سریع، خشن، و غیرمنطقی می‌شود.

۱۲. امکان دارد بیمار فکر کند که توانایی‌های خیلی زیادی دارد(خود بزرگ‌بینی)

۱۳. امکان دارد بیمار غذا خوردن را فراموش کند و وزن وی کم و خستگی بر وی عارض شود.

۱۴. امکان دارد بیمار به یك باور نادرست و غیرقابل تغییر از اهمیت و بزرگی خود برسد و فکر کند که می‌تواند کارهای خطرناك انجام دهد.

۱۵. امکان دارد بیمار به طور فزاینده‌ای گوشه نشینی اختیار کند؛ خوابش مختل شود؛ و صبح‌ها دیر از رختخواب بر خیزد.

۱۶. امکان دارد بیمار دراتاقش بماند، و از رو به رو شدن با دنیای بیرون واهمه داشته باشد؛ یا در واقع عزت نفس نداشته باشد.

۱۷. کاهش سرعت صحبت کردن و کند شدن حرکات

۱۸. افزایش تصورات در مورد وجود مشکلاتی که واقعاً وجود ندارند.

۱۹. نگرانی بیش از حد در مورد بیماریهایی که واقعاً وجود ندارند.

ـ علل بیماری:

ناشناخته است. عوامل زیست‌شناختی، روانی، و ارثی همگی ممکن است نقش داشته باشند. امکان دارد استرس زیاد یا مرگ یکی از نزدیکان باعث ظهور ناگهانی شیدایی یا افسردگی شود.

ـ عوامل افزایش دهنده خطر:

سابقهٔ خانوادگی این اختلال

ـ پیشگیری:

هیچ داروی خاصی برای پیشگیری از آن وجود ندارد.

ـ عواقب مورد انتظار:

ممکن است بتوان این اختلال را با درمان دراز مدت که باعث کاهش دفعات و شدت حملات شیدایی و افسردگی می‌شود، تا حد زیادی کنترل کرد و سلامت فرد را به حد نزدیك به طبیعی رساند. بسیاری از مدیران، دانشمندان، و افراد سرشناس دچار این اختلال بوده‌اند.

ـ عوارض احتمالی:

۱. خودکشی

۲. عدم رو به بهبود گذاشتن اختلال

۳. عود بیماری، به خصوص با قطع دارو

۴. از دست دادن شغل؛ بروز مشکلات در زندگی مشترك

ـ درمان:

۱. گرفتن شرح حال و انجام معاینه توسط پزشکان (گاهی روانپزشك)

۲. روان‌درمانی یا مشاوره همراه با درمان دارویی بهترین نتایج را در بر دارد.

۳. امکان دارد در مورد بیمارانی که به دارو جواب نمی‌دهند، از شوك (ECT) استفاده شود.

۴. برای مواردی که علایم شدید هستند، ممکن است لازم باشد بیمار در بیمارستان یا مرکز درمانی بستری شود.

۵. هیچگاه وقتی احساس کردید حالتان بهتر شده است، دارو را قطع نکنید. این کار ممکن است باعث عود بیماری شود که شاید به دارو خوب جواب ندهد.

۶. رژیم دارویی باید دقیقاً رعایت شود. ضمناً باید به طور منظم به پزشك معالج مراجعه شود تا اثربخشی درمان و اثرات جانبی احتمالی مورد بررسی قرار گیرند.

۷. با کمك مشاوره می‌توانید روشهای کنار آمدن با این اختلال را فراگیرید. اعضای خانواده باید بتوانند علایم پیش درآمد وقوع حمله را بشناسند و چگونگی کمك به فرد بیمار را فرا بگیرند.

ـ داروها:

پزشك شما ممکن است لیتیم، والپرویك اسید، یا کاربامازپین (تگرتول) تجویز کند. برای علایم شدیدتر ممکن است تجویز یك داروی ضد روان‌پریشی ضروری باشد.

ـ فعالیت:

فعالیت‌های روزانه خود را حتی اگر تمایل ندارید، ادامه دهید.

ـ رژیم غذائی:

یك رژیم طبیعی و متعادل داشته باشید، حتی اگر اشتها ندارید. امکان دارد مکمل ویتامین‌ها و مواد معدنی لازم باشد. پزشکتان ممکن است به شما توصیه کند که از مصرف کافئین پرهیز کنید، زیرا کافئین یك مادهٔ تحریك‌کننده است.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

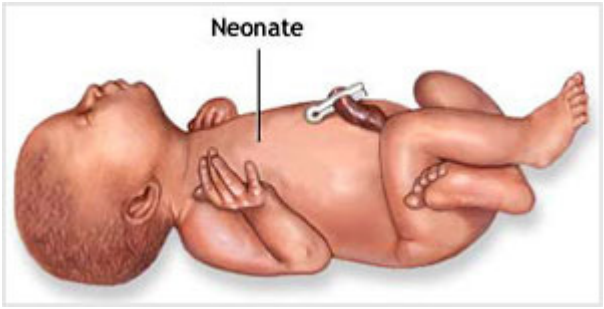
۱. اگر فکر خودکشی به سرتان زده است یا احساس ناامیدی می‌کنید.

۲. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان دارای علایم افسردگی یا سرخوشی هستید.

http://vista.ir/?view=item&id=124153

اختلال رشد بچه - failure to thrive

اختلال رشد بچه عبارت است از ناتوانی شیرخواران یا کودکان از رشد و نموی طبیعی. این واژه تا زمانی استفاده می‌شود که تشخیص خاصی برای توجیه این ناتوانی پیدا نشده باشد. سن شایع این مسأله بین 5-1 سالگی است. تقریباً تمام کودکانی که این مشکل را دارند زیر 5 سال هستند.



ـ علایم شایع:

۱. قد، وزن، و دور سر به‌طور طبیعی افزایش نمی‌یابند.

۲. رشد و نموی طبیعی بسیار متغیر است، بنابراین میزان تغییرات رشد و نمو در معاینات منظم کودك اهمیت بیشتری دارد.

۳. مهارت‌های حرکت کودك غالباً دیرتر از حالت طبیعی ظاهر می‌شوند. بعضی از این مهارت‌ها عبارتند از: ـ چرخیدن در تخت ـ نشستن ـ ایستادن و راه رفتن

۴. ظهور مهارت‌های ذهنی و اجتماعی نیز غالباً به تأخیر می‌افتد. بعضی از این مهارت‌ها عبارتند از: ـ صحبت کردن؛ رابطه اجتماعی ـ غذا خوردن بدون کمك ـ یادگیری اختیار ادرار و اجابت مزاج و رفتن به توالت

ـ علل بیماری:

در بعضی از این کودکان، علت بروز این حالت به مشکلات جسمی (معمولاً گوارشی یا مربوط به دستگاه عصبی) برمی‌گردد. در اکثر این کودکان، علت درواقع مربوط به خود کودك نیست، مثلاً عدم تغذیه صحیح کودك.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سوءتغذیه

۲. بی‌تجربگی والدین

۳. نوزاد زودرس یا بیمار

۴. محیط زندگی شلوغ یا غیربهداشتی

۵. شیرخواری که ناهنجاری جسمی دارد.

۶. بیماری مزمن (مثل نارسایی کلیه یا عفونت مزمن)

۷. بیماری‌های ژنتیکی، مثل نشانگان داون یا فیبروز کیستیك

۸. محیط عاطفی نامناسب (مثل عدم رسیدگی به بچه، سوءرفتار با بچه، یا طرد بچه)

۹. والدینی که در یك محیط عاطفی نامناسب بزرگ شده‌اند یا آموزش مناسبی ندیده‌اند.

۱۰. بیماری‌های غدد درون‌ریز، مثل بیماری‌های غده تیرویید، غده هیپوفیز، غدد فوق‌کلیوی، غده لوزالمعده، و غدد جنسی

ـ پیشگیری:

۱. کودك خود را به‌طور منظم برای معاینات سلامتی نزد پزشك یا مراکز بهداشت ببرید.

۲. محیط زندگی باثبات را فراهم آورید و سعی کنید والدین خوبی برای فرزندتان باشید.

ـ عواقب موردانتظار:

۱. اگر اختلال رشد بچه به‌علت بی‌تجربگی والدین یا مشکلات روانی باشد، انتظار می‌رود با آموزش و دادن مشاوره به والدین بهبودی حاصل شود.

۲. اگر اختلال رشد بچه به‌علت یك بیماری یا اختلال زمینه‌ای باشد (مثلا سوءتغذیه)، بهبودی بستگی به این دارد که بیماری یا اختلال زمینه‌ای قابل درمان باشد یا خیر.

ـ عوارض احتمالی:

۱. ناتوانی و معلولیت دایمی ذهنی، عاطفی، یا جسمی.

۲. کودك کوچك باقی می‌ماند و از لحاظ نمو نیز دچار نقص خواهد بود.

ـ درمان:

اقدامات تشخیصی: اندازه‌گیری مکرر قد، وزن، و دور سر؛ آزمون‌های سنجش توانایی‌های ذهنی و روانی مثل آزمون دنور که معیاری از رشد و نمو به‌دست می‌دهد؛ آزمایش خون، از جمله بررسی‌های هورمونی؛ عکس‌برداری از مچ دست‌ها برای تعیین سن استخوانی کودك که معیار خوبی برای رشد بدن به‌شمار می‌رود.

۱. از یك پرستار خانه بخواهید که به خانه شما بیاید و راهنمایی‌های لازم را ارایه دهد.

۲. والدین باید کتاب‌ها یا جزوات مخصوص بچه‌داری و بزرگ کردن بچه را بخوانند یا به کلاس‌های مربوطه بروند.

۳. اگر والدین مشکلات عاطفی دارند و از برقراری رابطه عاطفی مناسب با کودك خود ناتوان هستند، می‌توان آنها را تحت روان‌درمانی یا مشاوره قرار داد.

۴. بستری کردن کودك (به‌طور کوتاه‌مدت) در صورتی که نیاز به انجام اقدامات تشخیصی پیچیده وجود داشته باشد یا برای فهمیدن اینکه آیا کودك در منزل غذا می‌خورده است یا خیر.

۵. تا آنجا که می‌توانید به کودکتان محبت کنید و از وی حمایت به‌عمل آورید. هرازچندگاهی به بررسی احساسات و رفتارتان نسبت به کودکتان بپردازید. اگر فکر می‌کنید که احساسات و رفتارتان آنچنان که باید باشد نیست برای مشاوره روانی مراجعه کنید.

ـ داروها:

داروی خاصی به‌طور معمول تجویز نمی‌شود. اگر یك بیماری زمینه‌ای وجود داشته باشد که باعث رشد نکردن بچه شده است، امکان دارد داروهای لازم برای درمان آن بیماری زمینه‌ای تجویز شوند.

ـ فعالیت:

محدودیتی برای آن وجود ندارد.

ـ رژیم غذائی:

برای کودکتان یك رژیم غذایی کافی و متعادل فراهم آورید. اگر علت رشد نکردن بچه سوءتغذیه باشد، امکان دارد نیاز به یك رژیم مخصوص وجود داشته باشد.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

اگر شما از اینکه کودکتان رشد و نموی طبیعی ندارد دچار نگرانی شده‌اید.

http://vista.ir/?view=item&id=124154

vista.ir
Online Classified Service

اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی - attention deficit hyperactivity disorder

اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی عبارت است از یك نوع رفتار خاص در کودکان به طوری که این کودکان تنها می‌توانند برای مدت کوتاهی روی یك موضوع خاص تمرکز کنند. ضمناً این کودکان گاهی حرکات و رفتار کنترل نشده‌ای را به طور ناگهانی از خود بروز می‌دهند.



البته بیش فعالی می‌تواند وجود داشته باشد یا نداشته باشد. به نظر می‌رسد که این اختلال در اختلالات یادگیری نقش داشته باشد و تخمین زده می‌شود حدود 10%-5% کودکان مدرسه‌ای گرفتار این اختلال باشند.

ـ علایم شایع:

۱. زیاد صحبت می‌کند.

۲. کودك روی صندلی مرتب می‌جنبد و دست‌ها و پاهای خود را تکان می‌دهد.

۳. اغلب کارهای خطرناك انجام می‌دهد بدون اینکه به عواقب ناگوار آنها توجه داشته باشد.

۴. حواس کودك به راحتی پرت می‌شود.

۵. قبل از مطرح شدن کامل سؤال، کودك پاسخ را می‌دهد.

۶. کودك در رعایت نوبت در بازی و صف مشکل دارد.

۷. کودك در اجرای دستورالعمل‌ها مشکل دارد.

۸. کودك قادر به تمرکز روی یك کار یا بازی مشخص نیست.

۹. مرتب از یك کار تمام نشده منصرف شده، به کار دیگری می‌پردازد.

۱۰. در انجام بازی، بدون ایجاد سروصدا، مشکل دارد.

۱۱. وسط صحبت یا کار دیگران می‌پرد.

۱۲. به نظر می‌رسد که اصلاً گوش نمی‌دهد.

۱۳. چیزهای مورد نیاز برای انجام کارها را گم می‌کند.

۱۴. وقتی به کودك گفته می‌شود که بنشینید، فقط به مدت کوتاهی روی صندلی بند می‌شود.

ـ علل بیماری:

ناشناخته است. فرضیات زیادی مطرح شده‌اند، اما هیچ یك تأیید یا رد نشده‌اند. تصور بر این است که منشای آن بیولوژیك باشد.

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

سابقه خانوادگی این اختلال

ـ پیشگیری:

هیچ روش خاصی برای پیشگیری وجود ندارد.

ـ عواقب مورد انتظار:

در بعضی از موارد، رفتار غیرطبیعی کودك به هنگام بلوغ کاملاً برطرف می‌شود. در بعضی دیگر، بیش فعالی با افزایش سن کاهش می‌یابد. اما تعدادی از این کودکان نهایتاً به نوجوانان و بزرگسالانی مشکل‌دار تبدیل می‌شوند.

ـ عوارض احتمالی:

امکان دارد مشکلات کودك در طی زمان برطرف نشوند. نهایتاً کودك وقتی بزرگ می‌شود ممکن است در تحصیل موفق نباشد، یا اینکه رفتار ضداجتماعی و گاهی جنایی از خود بروز دهد. امکان دارد کودك در بزرگسالی دچار اختلال شخصیت شود.

ـ درمان:

۱. درمان و مشاوره به والدین و کودك توسط پزشك

۲. با معلم کودك تماس مستمر داشته باشید. اگر کودك در درس خود نیاز به کمك بیشتری دارد، امکان آن را فراهم کنید.

۳. در خانه یك محیط متناسب و محدودیت‌های کاملاً مشخص برای رفتار کودك را در نظر بگیرید. ضمناً باید از روش‌های تربیتی نیز به طور مداوم بهره گرفت. اگر احساس می‌کنید که نیاز به کمك از طرف افراد متخصص امر دارید مراجعه کنید.

۴. رفتار درمانی و شناخت درمانی. کودك خود در این نوع درمان‌ها نقش مهمی را به عهده دارد. او باید مواظب رفتار خود باشد، نقش محوله را به خوبی ایفا کند، و رفتار خود را ثبت کند. در یك طرح کلی، اساس این روش‌های درمانی بر راهبردهای تغییر رفتار نامطلوب استوار است. به نظر می‌رسد که ترکیب این روش‌های درمانی با داروها بهترین نتایج را در کنترل علایم به همراه داشته باشد.

ـ داروها:

پزشك شما شاید تصمیم بگیرد داروهایی مثل متیل فنیدات (ریتالین)، که ظاهراً اثر آرامش‌بخش در کودکان دچار این اختلال دارند، تجویز کند. این داروها اثرات جانبی ناخوشایندی دارند، از جمله: اختلال در خواب، افسردگی، سردرد، معده درد، بی‌اشتهایی، و کاهش رشد.

ـ فعالیت:

فعالیت کودك خود را حتی‌المقدور در چارچوب مشخصی در آورید.

ـ رژیم غذائی:

رژیم غذایی مخصوصی پیشنهاد شده‌اند: حذف کلیه افزودنی‌های غذایی (ادویه جات و غیره)، حذف مواد به خصوصی از رژیم غذایی، یا ویتامین درمانی شدید. اغلب تحقیقات پزشکی اشاره به این دارند که این رژیم‌ها برای تعداد بسیار کمی از کودکان مفید هستند. اما بسیاری از والدین تغییرات قابل توجهی را در رفتار کودکان خود پس از استفاده از این رژیم‌ها گزارش کرده‌اند. شاید دلیل آن این باشد که با تهیه غذاهای مخصوص برای کودك، وی احساس می‌کند که توجه بیشتری به او می‌شود. در مورد هرگونه رژیم غذایی مخصوصی که برای کودك خود در نظر دارید با پزشك خود مشورت کنید.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر پس از شروع درمان علایم بدتر شوند.

۲. اگر احساس می‌کنید کودکتان علایم اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی را دارد.

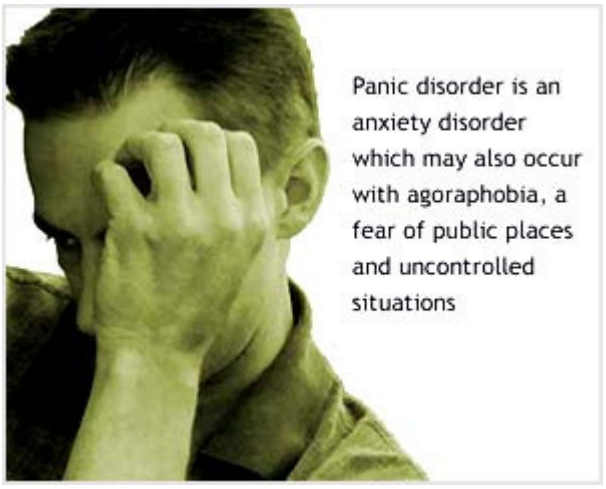
۳. اگر دچار علایم جدید وغیرقابل کنترل شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

http://vista.ir/?view=item&id=124155

vista.ir
Online Classified Service

اختلال هراس - panic disorder

اختلال هراس نوعی اضطراب شدید خودبه خودی که حملات آن عودکننده و غیرقابل پیش‌بینی است بیشتر این حملات 10-2 دقیقه طول می‌کشد ولی برخی حملات ممکن است بیش از 2-1 ساعت نیز به طول انجامد. این نوع اضطراب با علایم حمله‌ای بروز می‌کند (اغلب در حین خواب)، در حالی که در اضطراب مزمن (اضطراب عمومی)، اضطراب حالت پایدار دارد.



ـ علایم شایع:

۱. تپش قلب؛ تُندی ضربان قلب؛ درد سینه

۲. احساس بی‌واقعیتی، قطع ارتباط با افراد یا اشیاء

۳. کرختی و گزگز اطراف دهان، دست‌ها و پاها گرفتگی یا انقباضات عضلانی در دست‌ها و پاها

۴. احساس «پرپرزدن پروانه‌ها» در معده

۵. ترس شدید از دیوانه شدن (از دست دادن مشاعر)؛ ترس از مردن؛ احساس وحشت

۶. کوتاهی نفس؛ احساس خفگی؛ تنفس عمیق و سریع؛ ضعف یا حالت سستی؛ غش کردن (گاهی)؛ تعریق و لرزیدن

ـ علل بیماری:

دستگاه هشدار دهنده مغز به نظر می‌رسد تحت‌تأثیر تعامل پیچیده عوامل زیست‌شناختی، ژنتیکی، بیماری‌ها، داروها، و سابقه شخصی حوادث ناگوار باشد. اختلالات مختلفی می‌توانند محرك بروز حملات هراس باشند (از قبیل اختلالات ریتم قلبی، آنژین صدری، اختلالات تنفسی، آسم، بیماری‌های انسدادی ریه، اختلالات غددی، اختلالات تشنجی، داروهای محرك، محرومیت از برخی داروهایی که بدن به آنها وابستگی پیدا کرده است).

ـ عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. سابقه سایر اختلالات روانی؛ سابقه خانوادگی اختلال هراس

۲. استرس؛ احساس گناه، خستگی یا کار زیاد ؛ بیماری؛ سوءمصرف الکل یا داروها

ـ پیشگیری:

اقدام خاصی برای پیشگیری از حمله اولیه وجود ندارد؛ درمان به پیشگیری از حملات بعدی کمك می‌کند.

ـ عواقب مورد انتظار:

در بسیاری از بیماران این اختلال به صورت حملات اندك در طی دوره محدود که فروکش طولانی مدت بیماری را به دنبال دارد بروز می‌کند. در مورد سایر بیماران، روان درمانی یا تجویز داروها ممکن است مؤثر باشد.

ـ عوارض احتمالی:

۱. وابستگی دارویی

۲. اضطراب یا افسردگی مزمن

۳. اختلالات ترس، از قبیل موقعیت هراس (ترس هنگام تنها بودن یا قرار گرفتن در مکان‌های عمومی)

ـ درمان:

۱. بررسی سوابق پزشکی و معاینه توسط پزشك

۲. تا حد امکان استرس را در زندگی خود کاهش دهید.

۳. بررسی‌های آزمایشگاهی در صورت لزوم برای رد کردن سایر اختلالات

۴. روش‌های آسوده‌سازی را فرا بگیرید. برای برخی افراد، تجویز دارو مؤثر است.

۵. در مورد احساسات خود با یك دوست یا یکی از اعضای خانواده صحبت کنید. این اقدام گاهی اضطراب شما را کاهش می‌دهد.

۶. برای رفع علایم مربوط به تنفس عمیق و سریع، یك کیسه کاغذی کوچك را جلوی دهان و بینی خود بگیرید و به مدت چند دقیقه درون آن تنفس کنید.

۷. افکار و احساسات اضطرابی خود را به طور روزانه در یك دفتر ثبت نمایید. با بررسی اطلاعات ثبت شده علل اضطراب خود و راه‌حل‌های احتمالی آن را ارزیابی کنید.

ـ داروها:

پزشك ممکن است برای بیمار داروهای ضدافسردگی، بنزودیازپین یا داروهای مسدودکننده گیرنده بتا تجویز کنند. داروی تجویز شده ممکن است پس از 12-6 ماه درمان به آهستگی کاهش داده شده یا به طور موقت قطع گردد تا مشخص شود آیا حملات هراس عود می‌کند یا خیر. اگر حملات عود نکند دارو را می‌توان برای همیشه قطع کرد.

ـ فعالیت:

به طور منظم ورزش کنید. شب به اندازه کافی استراحت کنید.

ـ رژیم غذائی:

مصرف کافئین به هر شکل (قهوه، چای، نوشیدنی‌های غیرالکلی) را قطع کنید. با قطع مصرف این نوشیدنی‌ها ممکن است دچار علایم محرومیت نظیر سردرد یا خستگی شوید، ولی این علایم در عرض چند روز برطرف می‌شوند.

ـ در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمائید:

۱. اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید.

۲. عدم موفقیت برنامه درمانی پس از 8 هفته درمان

۳. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان دارای علایم اختلال هراس باشید که با درمان‌های معمولی انجام شده توسط خودتان برطرف نشده باشد.

http://vista.ir/?view=item&id=124156

اختلالات آب و الکترولیت - fluid and electrolyte disorders

اختلالات آب و الکترولیت عبارت است از وجود يك عدم تعادل در آب و نمك‌هایی (الکترولیت‌هایی) که برای کار طبیعی بدن لازم هستند. نمك‌های ضروری برای کار بدن عبارتند از: سدیم، پتاسیم، کلسیم، بی‌کربنات و فسفات. تمام قسمت‌های بدن در مایعی که حاوی نسبت‌های دقیقی از آب و نمك‌های طبیعی است شناور هستند. مایعات بدن همواره در يك حالت ثبات درونی قرار دارند به نحوی که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها از تعادل خاصی برخوردارند.

ـ علایم شایع:

۱. خشکی دهان

۲. پوست چروکیده

۳. افزایش، کاهش یا به کلی فقدان ادرار

۴. خستگی

۵. پاها، دست‌ها، صورت یا شکم ورم کرده و پف کرده

۶. احتقان و ورم ریوی

۷. ضعف و گیجی

۸. نامنظم بودن ضربان قلب

ـ علل بیماری:

مایعات و نمك‌ها ممکن است به طرق زیر از دست روند:

۱. استفراغ

۲. اسهال

۳. تعریق زیاد

۴. بعضی داروها، مثل ادرارآورها (دیورتیك)

۵. گذاشتن يك لوله در معده از راه بینی به هنگام بستری شدن در بیمارستان

مایعات و نمك‌ها ممکن است به طرق زیر در بدن جمع شوند:

۱. نارسایی حاد یا مزمن کلیه

۲. دیابت بیمزه

۳. بیماری غدد فوق کلیوی

۴. بیماری مزمن ریه

۵. مصرف داروهای کورتیزونی، هورمون‌های زنانه، یا بی‌کربنات سدیم

ـ عوامل افزایش‌دهنده:

۱. تب

۲. اسهال ویا استفراغ

۳. بیماری کلیه

۴. دیابت شیرین

۵. بیماری قلب

۶. رژیم غذایی نامعمول یا افراطی

۷. بی‌اشتهایی یا پرخوری روانی

۸. وابستگی به الکل

۹. مصرف داروهای ادرارآور (دیورتیك)

۱۰. شیرخواران، کودکان کم سن و سال، و افراد بالای 60 سال. در این گروه‌های سنی به هنگام بیماری مایعات سریع‌تر از دست می‌روند.

ـ پیشگیری:

در صورت بروز استفراغ یا اسهال، هر 30 دقیقه مقادیر کمی از مایعات رقیق مثل آب میوه، سودا، چای، یا آب ژلاتین بنوشید. نوشیدن مایع جایگزین مایعات از دست رفته می‌تواند کمك کننده باشد. برای درست کردن این مایع، حدود نیم لیتر آب، يك قاشق چایخوری شکر و نصف قاشق چایخوری نمك را به خوبی هم بزنید تا شکر و نمك کاملاً حل شوند. البته می‌توان از محلول‌های جایگزین که در بازار موجود هستند نیز استفاده نمود. به هنگام بروز بیماری‌های جدی، تعادل مایعات (ورودی و خروجی) را ثبت کنید.

ـ عواقب مورد انتظار:

با درمان معمولاً در عرض 48-24 ساعت (بسته به علت زمینه‌ساز) خوب می‌شود.

ـ عوارض احتمالی:

نامنظمی‌های ضربان قلب، ایست قلبی و مرگ

ـ درمان:

۱. روزانه خود را وزن کنید. هرگونه افزایش یا کاهش ناگهانی وزن ممکن است نشان دهنده تغییرات مایعات بدن باشد.

۲. بستری شدن در بیمارستان برای دریافت مایعات از راه رگ (سرم) و درمان در موارد جدی عدم تعادل آب و الکترولیت، و نیز برای درمان علت زمینه‌ساز